

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica del Grupo Familiar

AÑO XI Nro.17 AGOSTO 1988

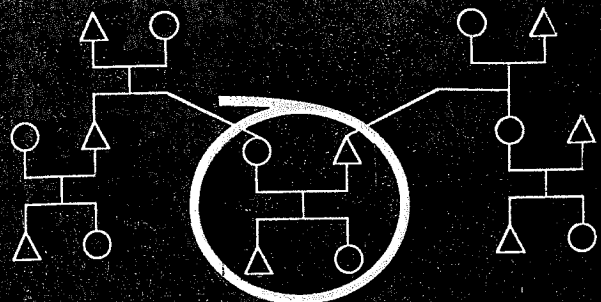
EL PROCESO TERAPEUTICO

Editores Invitados: Dr. Adolfo Loketek y Lic. Estrella Joselevich

INTRODUCCION	7
MARA SELVINI PALAZZOLI, STEFANO CIRILLO, MATTEO SELVINI, ANNA MARIA SORRENTINO	
El individuo en el juego	9
ADOLFO LOKETEK	
La inclusión de la historia en un modelo de terapia sistémica	21
ALFREDO A. CANEVARO	
Comentario al artículo de Adolfo Loketek	29
PAUL DELL	
¿Por qué las llamamos todavía "paradojas"?	33
FIDEL LEBENSOHN	
Comentario al artículo de Paul Dell. Cuando la excepción es la regla	47
ENRIQUE ESCOT, LINO GUEVARA	
Descripción del proceso terapéutico sistémico como un juego de varios niveles: la Descripción de Nivel (DN).	53
RUTH DEL C. CASABIANCA	
Comentario al artículo de Enrique Escot y Lino Guevara	64
CAROL ANDERSON, MARA SELVINI PALAZZOLI, VICENZO F. DI NICOLA	
Juegos psicóticos: ¿terapia o investigación?	69
ESTRELLA JOSELEVICH	
¿Las manzanas de Schiller?	83
REVISTA DE LIBROS	99

terapia familiar

ESTRUCTURA, PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA
DEL GRUPO FAMILIAR



CELEBRANDO SU 10º ANIVERSARIO ORGANIZA LAS "II JORNADAS ARGENTINAS" DE TERAPIA FAMILIAR TRIGENERACIONAL

VIERNES (12 de AGOSTO) 8 a 9 Entrega de Credenciales
9 a 12.30 Dr. A. A. CANEVARO y Equipo
14 a 17.30 Dres. F. y E. LEBENSOHN y Equipo

SABADO (13 de AGOSTO) 9 a 12.30 Dr. A. LOKETEK y Equipo
14 a 17.30 Panel de los integrantes y discusión con el público
Coord. Psic. A. GONZALEZ

• Proyección de video-tapes y discusión teórico-clínica

Lugar: Sala de Conferencias Jardín Japonés
 Av. Casares y Av. Libertador - Bs. As. - Argentina

Secretaría: Julián Alvarez 239, de 10 a 15 hs.
Informes: 572-0322-553-5136

EL PROCESO TERAPEUTICO

Editores Invitados:

Dr. Adolfo Loketek y Lic. Estrella Joselevich

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica del Grupo Familiar
AÑO XI - Nº 17 - Agosto de 1988

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Asistente de Dirección

Lic. Inés Dates

Secretario de Redacción

Lic. Claudio Hirsch

Coordinadora General

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk

Consejo de Redacción

Maurizio Andolfi (Roma)

Isidoro Berenstein (Buenos Aires)

Rodolfo de Bernart (Florenia)

Donald Bloch (New York)

Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)

Ives Colas (Lyon)

Alberto Eiguer (Bs. As. - París)

Craig A. Everett (Florida)

Jorge García Badaracco (Bs. As.)

J. Howells (Ipswich - Inglaterra)

Florence Kaslow (West Palm Beach
Florida)

Raymundo Macías (México)

Juan C. Nocetti (Buenos Aires)

Reynaldo Perrone (Rosario -

Argentina, St. Etienne - Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)

Jacques Rudrauf + (París)

Alberto Serrano (Filadelfia)

Mara Selvini-Palazzoli (Milán)

Robin Skynner (Londres)

Carlos Sluzki (Bs. As., Berkshire
Massachusetts)

Helm Stierlin (Heidelberg)

Guillermo Vidal (Buenos Aires)

Gerald Zuk (Nueva Orleans)

Israel Zwerling (Filadelfia)

Lyman Wynne (Rochester - USA)

Director Honorario

Alberto Cattani

Asesor Editorial

Alfredo Carlino

Comité de Redacción

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk

Lic. Inés Dates

Dr. Carlos Díaz Usandivaras

Dr. Fernández Moya (Mendoza)

Dr. Lino Guevara (Neuquén)

Lic. Sara B. Jutoran

Dres. Fidel y Elena Lebensohn
(Rosario)

Dr. Rafael Skiadaressis

Directores de Sección

Relaciones Interprovinciales

Dr. Fernández Moya

Relaciones Internacionales

y Publicaciones Extranjeras

Lic. Sara B. Jutoran

Ateneos Clínicos y

Mesas Redondas

Dr. Rafael Skiadaressis

Proyectos de Investigación

Lic. Inés Dates

Derecho de Familia y

Terapia Familiar

Dr. Carlos Díaz Usandivaras

Epistemología

Lic. Elena Lebensohn

Dr. Fidel Lebensohn

Prevención y Salud Familiar

Lic. Fanny Levinton-Baranchuk

Gerente Comercial

Claudio Sfeir

TERAPIA FAMILIAR es una publicación semestral de Ediciones A.C.E., Casilla de Correo 94, Suc. 28, Buenos Aires, Argentina.
Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor.
Nombre de la Revista registrado como marca.
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nro. 332.195.
Registro Internacional de Publicaciones Científicas. ISSN 0325-5905.
Composición y armado: Patricia Tur Tarizzo y Federico Tatter. Tel.: 27-3018.

Indice

INTRODUCCION	7
MARA SELVINI PALAZZOLI, STEFANO CIRILLO, MATTEO SELVINI, ANNA MARIA SORRENTINO El individuo en el juego	9
ADOLFO LOKETEK La inclusión de la historia en un modelo de terapia sistémica	21
ALFREDO A. CANEVARO Comentario al artículo de Adolfo Loketek	29
PAUL DELL ¿Por qué las llamamos todavía "paradojas"?	33
FIDEL LEBENSOHN Comentario al artículo de Paul Dell. Cuando la excepción es la regla	47
ENRIQUE ESCOT, LINO GUEVARA Descripción del proceso terapéutico sistémico como un juego de varios niveles: la Descripción de Nivel (DN).	53
RUTH DEL C. CASABIANCA Comentario al artículo de Enrique Escot y Lino Guevara	64
CAROL ANDERSON, MARA SELVINI PALAZZOLI, VICENZO F. DI NICOLA Juegos psicóticos: ¿terapia o investigación?	69
ESTRELLA JOSELEVICH ¿Las manzanas de Schiller?	83
REVISTA DE LIBROS	99
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES	108

Introducción

Reflexionar sobre el Proceso Terapéutico tiene que ver con lo esencial de nuestro ser terapeutas. Revisamos allí nuestras hipótesis sobre aspectos tan importantes como el ser humano, el enfermar, el cambio; sobre las intervenciones, las maneras de indagar, la recolección y procesamiento de datos, las evaluaciones, los seguimientos. Todo ello se pone en juego en esta experiencia única, en la cual un grupo humano llamado familia, que al decir de André Green es el espacio trágico por excelencia porque en ella los nudos de amor y odio son los primeros en fecha e importancia, busca ayuda en un otro grupo llamado terapeutas, unidos también por vínculos humanos de solidaridad, rivalidad, etc . . .

Si bien durante mucho tiempo la mirada y la escucha tenían una dirección lineal, de los terapeutas a la familia, desde esta última década la mira se ha puesto también en aquellos, determinando nuevas e imprevisibles posibilidades de desarrollo. Hemos caminado, sembrado, probado, ha llegado el momento en que la Terapia Familiar puede ser evaluada según los aportes que en cuarenta años ha brindado a la comprensión y tratamiento de la conducta humana. Creemos que el tema Procesos Terapéuticos ofrece una gran riqueza en este balance.

Al seleccionar estos trabajos hemos querido ofrecer el pensamiento y la praxis de profesionales de experiencia de nuestro medio y del mundo entero, sus cuestionamientos, sus críticas mutuas, sus incertidumbres, sus búsquedas; ingredientes imprescindibles de todo proceso terapéutico, de todo acto de pensar en este proceso. De toda vida familiar. De toda vida.

El individuo en el juego

MARA SELVINI PALAZZOLI

Psiquiatra. Directora del Nuevo Centro per le Studio della Famiglia, en Milán.

STEFANO CIRILLO

MATTEO SELVINI

ANNA MARIA SORRENTINO

Desde 1982 son miembros del Nuevo Centro per lo Studio della Famiglia, en Milán.

Revista *Terapia Familiare*, Noviembre 1985, No 19.

Traducción: Elena Trufo

¿A cuáles conceptos recurre para definir la relación familia-individuo?¹ La investigación de nuestro equipo, dirigido por Mara Selvini Palazzoli, en los últimos años se ha orientado hacia una utilización de la metáfora del *juego*.*

En la fase inmediatamente posterior a su alejamiento del psicoanálisis ('72-'78), la Dra. Selvini, en efecto, y precisamente ante la necesidad de afirmar la novedad del modelo, había enfatizado todas las formulaciones descriptivas del sistema familiar que iban más allá del individuo para caracterizar a un número máximo de actores (posiblemente a todos). De aquí la preeminencia de todos los conceptos su-

praindividuales ante todo, el de estilo comunicativo, luego, los estructurales, y sucesivamente la homeóstasis, el mito, las reglas del lenguaje, la epistemología, etc. En los últimos años, reflexionando todo el equipo sobre nuestro trabajo terapéutico, nos dimos cuenta de cómo, *desde siempre*, aún si no lo admitíamos oficialmente, habíamos seguido usando hipótesis que contemplaban sentimientos e intenciones de cada uno de los miembros: por ejemplo, los comportamientos del paciente designado hacían intuir vivencias de rabia, y propósitos de venganza y punición hacia los otros miembros.

Precisamente por esto las intervenciones llamadas paradójales, que lo caracterizaban como santo y víctima, eran empujones violentos que lo inducían al cambio, puesto que implícitamente evidenciaban el fracaso de sus (ocultos) propósitos.

De aquí se desprende la primera hipótesis, no claramente formulada al principio, de *motivación interactiva*; el paciente designado es visto como el perdedor en una situación (juego) en la cual, siendo él mismo jugador, está buscando confusamente con el síntoma, de manifestar su protesta y la imposibilidad de mantener su posición (en el juego).

Poco a poco hemos tomado conciencia de cómo las hipótesis sobre los individuos son tan importantes como las hipótesis sobre el sistema de relaciones, del cual nos hacíamos la ilusión de referirnos exclusivamente.

Esto nos induce a pensar que una terapia no puede proceder sin modelos capaces de integrar los distintos niveles sistémicos: biológicos, individuales, familiares y sociales. Una guía para una mejor sistematización teórica de esta problemática, en continua fase de elaboración, nos ha sido

* Con respecto a este tema, ver lo que afirma Matteo Selvini en los comentarios del libro por él recopilado.

brindada por la lectura de Crozier¹ y de su concepto de *estrategia de actor*.

"Detrás de los hombres y de las relaciones afectivas que rigen el comportamiento día tras día, es en efecto posible para el analista descubrir algunas "regularidades", que tienen un sentido sólo si están referidas a una estrategia. Esta última, por lo tanto, no es nada más que el *fundamento inferido ex post de las regularidades de comportamiento observadas empíricamente*". (op. cit. p. 36).

Crozier propone recurrir al concepto de juego puesto que en él se integran las movidas de los individuos y las reglas generales (del juego). El concepto de juego puede hacer de red de empalme entre dos razonamientos (órdenes de análisis) fundamentales que se integran mutuamente:

- 1) el que se refiere a la estrategia del actor
- 2) el sistémico sobre vínculos y límites puestos al actor por los niveles sistémicos supraindividuales.

Lo que se subraya pensando en términos de juego es la atención (que hay que prestar) a las movidas de los individuos. La hipotetización orientada a explicar los distintos comportamientos quedaría muerta si no estuviera en grado de comprender lo específico de las ideas, de las tácticas, de los objetivos de los diferentes actores (o sea sus estrategias).

Esta interpretación de la metáfora del juego, con la revaloración de la hipotetización sobre las estrategias individuales corre el riesgo de ser confundida con un "revival" intrapsíquico y el abandono de una epistemología sistémica. En cambio, es justamente lo contrario. En efecto, sólo de esta manera el paradigma sistémico se vuelve coherente, superando aquel lími-

te característico de un pasado reciente, en el cual se contrabandeaban (se hacían pasar por) como "sistémicas" hipótesis que ponían siempre y de cualquier forma, el síntoma del paciente designado en conexión con un único nivel: el microsocio familiar. Superar tal reduccionismo familiar no significa sólo ensanchar el campo de observación/hipotetización hacia las familias extensas, hacia el contexto socioeconómico, hacia la cultura, etc. (en el sentido de tomar en consideración sistemas más amplios que contengan a la familia), sino también considerar que el individuo tiene también una finalidad propia, su estrategia, aunque indisolublemente interdependiente con el juego que actúa a nivel familiar y a niveles superiores.

Cada nivel mantiene una autonomía relativa, una parcial independencia: así los mecanismos genéticos, la fisiología del cuerpo humano, la identidad individual, la familia, etc.

El hecho de que se tomen en consideración, junto con las reglas estructuradas de las relaciones del sistema en su evolución temporal, también los aspectos biológicos y las motivaciones de los distintos jugadores, no significa que consideremos tales motivaciones independientes de la constante influencia del juego interactivo. Desde nuestro punto de vista es verdad tanto que un individuo hace cierto juego porque tiene ciertas motivaciones, como que tiene ciertas motivaciones porque participa en un determinado partido que le permite solamente determinadas movidas.

Con esto no consideramos para nada que los jugadores individualmente persigan siempre fines bien definidos: ellos no tienen ciertamente la omnisciente racionalidad de los jugadores de von Neumann.

Pero se hace esencial tratar de compren-

der los fines interactivos que, aunque confusamente, mediando entre distintas finalidades (implícito en la participación simultánea en varios juegos) persigue cada actor.

¿El paciente designado era perdedor en la competencia con el hermano?

¿La madre está siempre en la persecución de un cónyuge desapegado y fugitivo?

¿El hermano trata de mantener el rol prestigioso que ha adquirido en la familia, mientras, al mismo tiempo, comienza a sentir el peso que ello implica?

¿El paciente designado le da mucha importancia al poder que le deriva de su designación de *enfermedad*, pero está furioso porque ese poder deriva sólo de la *enfermedad* y no de la estima que le es dada al hermano sano?

Estos son algunos ejemplos de hipotetización sobre estrategias y motivaciones de cada uno de los actores.

De lo dicho hasta aquí resultará evidente que nuestro trabajo terapéutico está fundado esencialmente sobre la metáfora del juego.

Juego es considerado por nosotros sinónimo de *modalidad de organización de las relaciones entre los individuos participantes, la cual evoluciona en el tiempo*.

El momento en el cual la familia pide ayuda y/o entra en tratamiento coincide con una evolución de su juego que ha puesto a uno o más de sus jugadores en una posición intolerable. Nuestro deber de terapeutas es por lo tanto el de conseguir dar forma (modelar) rápidamente el juego en acción, para poder intervenir, para hacer imposible la prosecución.

Las respuestas que siguen a los puntos sucesivos derivan de esta premisa.

¿Cómo insertas, en el encuentro con la familia, acciones, emociones, pensamien-

tos de cada uno de sus miembros?²

Todo lo que conseguimos poner en relevancia (y que convencionalmente definimos acción, emoción y pensamiento de cada miembro) nos sirve para controlar o testear la hipótesis planteada por nosotros sobre el juego en acción. Particularmente tales relevamientos nos ayudan a representarnos sea la posición que cada miembro ocupa en el "tablero" del juego, sea la posición que ellos creen que ocupan, o ambicionarían ocupar.

Para conseguir modelar rápidamente una hipótesis sobre el juego en acción es indispensable poseer técnicas sofisticadas para alcanzar en el menor tiempo posible un nivel muy elevado de informaciones (relacionales) adecuadas. En nuestra conducción terapéutica la recolección de las informaciones precede a las movidas decisivas de la terapia, cuya eficacia depende eminentemente de lo apropiado de las informaciones obtenidas. Justamente porque movidas decisivas se imponen en las fases iniciales de una terapia, entramos a la primera sesión con una ficha telefónica detallada, confeccionada en un horario especial por un terapeuta experto. Esto nos proporciona un nivel de informaciones estándar prácticamente exhaustivo y un nivel de informaciones relacionales bastante alto. Todo esto, sumado a la experiencia adquirida con otras familias, nos permite formular en una pre-sesión, una o más hipótesis sobre el juego en acción.

Una hipótesis de juego relacional pasa por la identificación de la estrategia de cada uno de los actores: finalidades, pensamientos y sentimientos en base a los cuales ellos organizan su accionar recíproco. Pero, al mismo tiempo, para comprender la experiencia subjetiva de cada actor debemos individualizar los juegos en los

que está involucrado en el presente e inferir los aprendizajes determinados por los juegos precedentes.

Jugando un juego se generan pensamientos y sentimientos y afectos que, a su vez, condicionan las sucesivas estrategias, y así sucesivamente, en un proceso en espiral.

¿Qué cosas privilegia? ¿O por el contrario, piensas que privilegiar acciones, emociones, pensamientos, se relaciona con distintas fases del proceso terapéutico?²⁻¹

Tomamos en consideración *todo* lo que nos puede ayudar a elevar nuestro nivel de información.

Cada información es utilizada para modificar contemporáneamente el accionar, el sentir y el pensar de la familia. Por ejemplo, el terapeuta se dirige al paciente designado como a un individuo competente, al mismo nivel que a los otros; el hecho de que el experto se dirija al paciente tratándolo como una *persona* cuyos comportamientos tienen intencionalidad y significado bien precisos pone en discusión las convicciones de los familiares relativas al paciente.

En una fase sucesiva de la terapia, la alteración de las precedentes atribuciones de significado permitirá al terapeuta proponer y obtener la ejecución de deberes, prescripciones y rituales. Este tipo de cambio en el plano de la acción producirá y/o consolidará nuevos pensamientos y sentimientos.

Resumiendo; los datos traídos por la familia (hechos, acciones, interpretaciones, emociones, etc.) sirven al terapeuta para hipotetizar un juego que, una vez identificado, actúa para modificarlo. Tal modificación, introducida por la manera de "actuar" del terapeuta, prosigue con la

prescripción de un "hacer", que tiene como finalidad el cambio de juego, y por lo tanto, implícitamente, del accionar, del pensar, del sentir de cada uno de los miembros.

¿Qué parámetros utilizas para considerar la relación inicial entre tú y la familia?³

El hecho de pedir ayuda a un experto representa para nosotros la última movida, en el tiempo, del juego en acción en la familia. Y por esa razón es el momento más peligroso, por cuanto el terapeuta corre el riesgo de asociarse sin darse cuenta, precisamente a aquellos *pattern* interactivos que, en la familia, mantienen la disfunción (y por lo tanto los "síntomas" del paciente designado). Por este motivo, antes de entrar a la primera sesión con la familia, nos preocupamos por poseer ya un nivel adecuado de informaciones sobre su propia manera de funcionar, o sea sobre su juego, con el fin de no caer en los *pattern* disfuncionales. Pero no sólo eso. Si luego de la elaboración de la ficha telefónica, precedentemente a la primera sesión, o entre una sesión y otra, nos llega una llamada de algún miembro de la familia (o amigo, o pariente, o enviado) nosotros consideramos esta llamada como la información privilegiada (¿esta sí que es privilegiada!).

¿Y por qué? Porque es la última en el tiempo, y por eso es la que nos pone al día sobre el *hic ed nunc** del juego (en el caso de sesiones sucesivas a la primera, incluimos el juego con nosotros). Contrariamente a la creencia de muchos terapeutas que buscan las claves de los comportamientos en el pasado, el *hic ed nunc* está en el *nivel superior de complejidad* porque con-

* Del latín: el aquí y ahora.

tiene el pasado y metacomunica sobre el pasado.⁴ Sistemáticamente, en efecto, es lo más complejo que explica lo menos complejo y no viceversa. Además, antes de declarar la indicación de terapia familiar, generalmente al finalizar la segunda sesión realizamos una indagación sobre las motivaciones que llevan a la terapia familiar, interrogando uno por uno a los distintos miembros.

Hemos inventado una batería de preguntas: ¿Quién tuvo la idea de consultarnos? ¿Quién vino con más ganas, quién con menos, quién espera más, quién espera menos? (también cruzando las preguntas en forma circular). Las respuestas nos ayudan sea a representarnos las posiciones de los individuos en el juego, con una cierta aproximación (en general el que se cree "ganador" no recurre a un experto), sea la actitud de los individuos hacia la terapia.

Podemos resumir de esta manera los parámetros que nos guían en la aproximación terapéutica inicial:

a) Análisis minucioso del contexto en el cual se debe actuar (imagen, expectativas conexas, tareas con las que se vincula, etc.);

b) primer contacto (generalmente telefónico); por medio de éste se recogen informaciones sobre la naturaleza del problema por el cual se solicita la intervención; sobre el solicitante y su posición en el sistema familiar; sobre la persona que lo envía; sobre la composición del sistema familiar. La finalidad operativa más inmediata es la de decidir a quién se convoca para la primera sesión de consulta, una movida terapéutica de esencial importancia. Ya desde la llamada/ficha es necesario formular hipótesis y evaluar el importante aspec-

to pronóstico de la subordinación a los requerimientos del terapeuta, a la convocatoria, a la praxis propuesta.

La ausencia de tal subordinación supone importantes interrogantes para indagar en la sesión de consulta;

c) la sesión de consulta. Con los datos ya surgidos, la fase de consulta tiene la finalidad de verificar hipótesis de dos órdenes: 1. sobre la solicitud de terapia (relaciones entre la familia y la persona que la envía, ésta y el terapeuta, la familia y la terapia); 2. sobre el juego intrafamiliar (posición del solicitante, relaciones familiares extensas y familia nuclear, relaciones internas en la familia nuclear). Al finalizar la consulta (una o dos sesiones como máximo), se ofrece/rechaza la terapia con una intervención adecuada de tipo desorganizativo del juego en acción.

Los feedback con dicha finalidad constituyen datos que orientan al eventual accionar terapéutico sucesivo.

¿Cuáles parámetros utilizas para evaluar la evolución de dicha relación?³⁻¹

Nos basamos sobre todo sobre elementos concretos: ausencia o casi de insubordinaciones en sesión,⁵ aceptación de las citas sin excesivas discusiones o postergaciones, cumplimiento de las órdenes prescriptas, modificaciones o desapariciones del síntoma, cambios en los comportamientos familiares, etc.

¿En el trabajo familiar insertas tu relación con cada uno de los miembros? ¿De qué manera?⁴

En el pasado, Mara Selvini Palazzoli y sus colaboradores atribuían la máxima importancia, durante todo el tratamiento, a una rigurosa actitud de neutralidad por parte del terapeuta con respecto a cada uno de los miembros de la familia.³

Esto no significaba sin embargo —como alguna vez se ha creído— que el terapeuta tuviera que asumir una posición distanciada o un tono burocrático. Por el contrario, el terapeuta se pone siempre en actitud de comprensión del punto de vista del que habla: la neutralidad, en efecto, no puede excluir la alianza terapéutica, pero sí la coalición con un miembro de la familia contra otro.

De todos modos, en el período del artículo citado, se entendía por neutralidad la resultante igual a cero de la suma algebraica de las eventuales alianzas individuales con los miembros de la familia en el curso de la sesión.

Actualmente la neutralidad se mantiene rigurosamente sólo en el curso del contacto telefónico; esto depende del hecho que en ese momento el equipo no ha decidido aún con quién trabajará: se convocará a las familias ampliadas, a la familia nuclear, a un subsistema en ella... También en la sesión de consulta conservamos en general una actitud neutral, que se manifiesta por ejemplo en el respeto del organigrama formal presentado por la familia: se da la palabra primero al padre que no ha hablado por teléfono, luego a los hijos; cuando éstos son adultos, puede ser más oportuno escuchar primero al paciente designado, si en el teléfono tuvimos a uno de los padres.

En la misma sesión de consulta, sin embargo, la actitud de neutralidad es interpretada de una manera diferente que en el pasado. Ahora es vista como la suma algebraica igual a cero no sólo de las movidas de alianza explícita del terapeuta con los distintos miembros, sino también de las movidas de provocación del terapeuta hacia cada uno de ellos. O sea, no consideramos más la connotación positiva un requi-

sito indispensable de la neutralidad, sino que distribuimos también connotaciones negativas, a veces pesadas, pero que se hacen aceptables por el clima de empatía o de risueña bonanza.

Siguiendo una tendencia, en el curso de todo tratamiento, las distintas movidas de alianza y de ataque por parte del terapeuta tratarán de distribuirse en modo equilibrado, de tal manera que nadie saldrá de la terapia castigado, o burlado para ventaja de los demás, puesto en condiciones de inferioridad o culpabilizado.

Otra línea a lo largo de la cual se ha modificado la actitud de neutralidad terapéutica es aquella de la delimitación del sistema que se elige trabajar. Se trata de evitar que los miembros excluidos luego de la primera consulta sean despedidos luego de un ataque, de manera que no tengamos "en casa" potentes e incontrolables enemigos de la terapia antes de haber estrechado una sólida alianza terapéutica con aquellos con los cuales se elige trabajar.

Pero tal alianza terapéutica, en ausencia de los excluidos, será estrechada, en buena parte, a través de una alianza explícita entre los presentes, contra la interferencia de los ausentes.

Un ejemplo típico está constituido por las sesiones que siguen al despido de una abuela temida y prestigiosa, que paraliza a los padres en el ejercicio del propio rol educativo y mina el acuerdo de la pareja criticando fuertemente con un cónyuge lo actuado por el otro.

El objetivo de restituir a los padres el poder educativo y de remozar la cohesión de la pareja se persigue dando coraje a los padres para que se resistan a las interferencias de la abuela y a sus críticas. Si se trabaja correctamente, el resultado al cual se

llega no es el del descrédito o distinción de la figura de la abuela ante los ojos de las futuras generaciones, sino el de obtener que éstas prueben hacia la madre y suegra y abuela un sentimiento de compasión por su soledad, por sus dificultades personales, las problemáticas de su edad, en lugar del temor irrealista de su juicio y la sensación de impotencia frente a su tiranía.

Existen también otras situaciones en las cuales ponemos especial atención a la relación del terapeuta con cada uno de los miembros. Por ejemplo, estamos particularmente atentos ante las exhibiciones de apego, de confianza y de obediencia de un miembro de la pareja conyugal, que contrasten con el mal humor o la reticencia del partner, por cuanto son fenómenos reveladores de la tentativa de *aspirar* al terapeuta en el juego de la pareja, neutralizando el poder terapéutico. En efecto, estamos convencidos de que el terapeuta debe tener siempre conciencia de que eventuales movimientos de un miembro de la familia con respecto a él (ataques, seducciones, insubordinaciones, etc.), deben ser interpretados, por lo menos preliminarmente, como dirigidos a provocar un efecto sobre uno de los familiares presentes. Así, un miembro de la familia puede mostrarse seductor hacia el terapeuta para dar celos a su cónyuge, o mostrarse insubordinado con él sólo porque los demás se muestran obsequiosos.

El psicoanalista habla de movimientos transferenciales del paciente con respecto a él, por cuanto considera que reproduce con él actitudes originariamente asumidas con otros, y que no tiene "realmente" determinados sentimientos hacia él.

En nuestra aproximación terapéutica, estando presentes los familiares del sujeto

que nos ataca, que nos acaricia o que nos provoca, nosotros partimos en cambio del presupuesto de que tales comportamientos son primariamente una comunicación dirigida a los familiares. Es deber de los supervisores que están detrás del espejo, advertir al terapeuta de este aspecto cada vez que él, involucrado en el acercamiento provocado por el clima de la sesión, tienda a reaccionar emotivamente ante determinadas movidas, como si estuvieran primariamente dirigidas a él.

¿Favorece el encuentro entre una persona y su familia dentro de una sesión terapéutica? ¿Cómo procedes?⁴⁻¹

¿Te sucede a menudo de elegir trabajar con un solo componente en presencia de los otros? ¿Cómo procedes? ¿Con cuáles objetivos?⁴⁻²

En nuestro modo de conducir la sesión mantenemos la centralidad del terapeuta por lo cual no estimulamos *nunca* los intercambios entre miembros de la familia. Hay casos en los cuales el terapeuta decide interactuar con un miembro de una familia de una forma totalmente opuesta a la típica de aquel tipo de organización familiar; el ejemplo más elemental es el de tratar con respeto y consideración a un padre que ocupa una posición de estúpido e incapaz.

El objetivo de tal comportamiento del terapeuta es simple doble: observar las retroacciones de los distintos miembros ante tal comportamiento suyo y desalojar a ese miembro de una posición que perpetúa el juego disfuncional.

Comúnmente trabajamos con sólo un miembro durante un cierto arco de tiempo en una determinada sesión porque lo consideramos apto para que nos provea de muchas informaciones. Así, en la primera sesión con miembros de familias ex-

tensas, por ejemplo abuelos, trabajamos prevalentemente con ellos.

¿Prevees en tu trabajo interno con la familia, tomar en consideración también a una sola persona, excluyendo a las demás? En tal caso, ¿en base a cuáles consideraciones haces esta elección? ¿Qué haces en el encuentro con este miembro? ¿Cómo lo insertas en el trabajo con la familia?⁴⁻³

La elección de una persona, en una terapia familiar, excluyendo a las otras, es una elección que hemos hecho raramente y por consideraciones siempre distintas. En un caso, con una familia que presentaba a un hijo esquizofrénico, luego de dos sesiones plenarias y dos de pareja, parental, el mismo terapeuta siguió trabajando sólo con la madre que demostraba ser la única que estaba motivada.

El resultado fue óptimo. En otros casos se ofreció la terapia a un miembro de la fratría que aparecía como el miembro clave en el mantenimiento del juego, y que no era el paciente designado.

Consideramos muy poco auspiciable el caso de una terapia familiar que se concluya (o se prolongue) con una terapia individual del paciente designado, puesto que es un signo del fracaso de la estrategia terapéutica con la familia.

¿Consideras que hay fases del *ciclo evolutivo o situaciones relacionales* en las cuales parece útil, oportuno o necesario elegir como unidad de intervención al individuo, aunque manteniendo una óptica sistémico-relacional? En tal caso, ¿en base a qué parámetros haces esta elección? ¿Cómo procedes?⁵

A un joven adulto, que no presenta síntomas psicóticos o anoréxicos, y vive con su familia, que solicita terapia familiar, no se la concedemos. Consideramos en efecto, que la convocatoria de toda la familia

sería un riesgo que entorpecería su proceso de emancipación, testimoniado por la capacidad de iniciativa expresada al formular el pedido en primera persona. Proponemos por ende indicar una terapia individual. En caso de padres que solicitan terapia familiar por un hijo adolescente, que en sesión creemos que presenta comportamientos *entre* los límites de la "normal" crisis de la adolescencia, luego de la primera sesión no sólo no proseguimos con la terapia familiar, sino que concluimos la relación con un comentario específico que consideramos terapéutico. También se da el caso de padres que solicitan terapia familiar con la finalidad de re-involucrar en sus problemas a sus hijos que se están desenganchando; en este caso, luego de un comentario oportuno, ofrecemos entrevistas a los padres solos.

Existen pacientes adultos crónicos (psicóticos y anoréxicos) cuya familia no está dispuesta al tratamiento, con los cuales se está estudiando (Viaro) una determinada modalidad de tratamiento individual en la óptica sistémico-relacional. Finalmente, si la que pide ayuda es una pareja que se lamenta de la dificultad de su relación, no aceptamos la dupla como tal, sino que sistemáticamente exploramos, antes de decidir, niveles superiores de complejidad: si hay hijos los convocamos ya para la primera sesión, así como también exploramos prolijamente las relaciones de cada cónyuge con las dos familias de origen. Esto en base a la hipótesis (obligatoria) de que el malestar relacional pueda ser un aspecto emergente de un juego que incluye hijos y/o miembros de la parentela.

En cambio, en el caso de la pareja que solicita ayuda para un cónyuge sintomático, luego de haber explorado como ya dijimos, los niveles superiores de compleji-

dad, adoptamos modalidades terapéuticas distintas, según las que nos parezcan más aptas para romper el juego específico en acción.

A veces trabajamos con la pareja. A veces separamos tácticamente a la pareja, quizás designando paciente al cónyuge que se presenta como acompañante sano, o recibiendo a los dos cónyuges separadamente durante un ciclo de sesiones, o tomando en terapia solamente al cónyuge sintomático con la finalidad de hacerle conocer estrategias relacionales más productivas que el "poder patológico" al cual se había aferrado.

¿Cómo afrontas el tema de las responsabilidades individuales (responder por lo que uno hace, piensa, siente) dentro de una óptica sistémica? ¿O, por el contrario, piensas que es un tema que desvía?⁶

No es para nada un tema que desvíe, al contrario, es esencial. El concepto que hemos adoptado de un individuo en el juego —y que hemos tratado de aplicar— le confiere al individuo *su* responsabilidad. El individuo es responsable, aunque lo sea de forma contingente, en el sentido que él es simultáneamente dependiente del contexto de las oportunidades y de las obligaciones en las cuales interactúa, pero también *indeterminado*, nunca de una manera totalmente previsible, en cuanto es capaz de calcular y de manipular, que se adapta e inventa en función de las circunstancias y de las estrategias de su partner.

Existe por lo tanto una responsabilidad individual, aunque esté limitada por la supra determinación de los juegos, o en otros términos, por la inclusión del indivi-

duo en la red sistémica.*

Nota agregada por la Dra. Selvini, en el trabajo que envió al Dr. Loketec en enero de 1987:

Como conclusión: Mediante el concepto de juego nosotros vemos cada comportamiento del individuo como la movida de un juego en acción, entre varios jugadores.

Con este concepto nosotros pensamos que *evitamos el error cartesiano de las separaciones conceptuales*. Separación del individuo de los otros (psicoanálisis); y separación del sistema de los individuos que los componen, cayendo en una especie de "antropomorfismo" sistémico, en el que se habla de la familia como si fuera una persona (holismo sistémico derivado de la física y de la biología). El hombre no es un átomo, ni una estrella ni una célula sino un ser autoreflexivo, y por lo tanto estratégico.

BIBLIOGRAFIA

1. CROZIER, FRIEDBERG: *Attore sociale e sistema*, Milano Etas Libri, 1978.
2. SELVINI, M.: (a cura di) *Cronache di una ricerca. L'Evoluzione della terapia familiare nelle opere di Mara Selvini Palazzoli*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1985.
3. SELVINI PALAZZOLI, M.; BOSCOLO L.; CECCHIN G.; PRATA G.: *Ipotizzazione, circolarità e neutralità*, *Terapia Familiare*, 7, 1980.
4. SELVINI PALAZZOLI, M.: *The problem of the sibling as the referring person*, *J. Marital Fam. Therapy*, II, 1, 1985.
5. VIARO, M.; LEONARDI, P.: *Le insubordinazioni*, *Terapia Familiare*, 12, 1982.

* Para la utilización estratégica, en consulta y terapia, del problema de la responsabilización de los familiares del paciente designado, véase

M. Selvini en la obra citada, en el párrafo "Responsabilización: el delicado equilibrio entre imputación y lo no atinente".



OLGA SILVERSTEIN

12/13 de Octubre (9:00 a 12:15)
TALLER CLINICO
INNOVACIONES RECIENTES
Observaciones en vivo (20 vacantes)

12/13 de Octubre (15:30 a 18:30)
SEMINARIO

MAS ALLA DEL SEXISMO EN LA TERAPIA

Presentará sus reflexiones sobre un modelo de terapia no sexista, revisando el rol del terapeuta.

14/15 de Octubre (9:00 a 12:00/14:00 a 17:00)

SEMINARIO
SU VOZ TERAPEUTICA

Presentará paso a paso su modelo clínico, ilustrándolo.

Olga Silverstein es docente en el Ackerman Institute for Family Therapy de New York, codirectora del Proyecto de Terapias Breves, directora de numerosos programas de entrenamiento, co-autora del libro The Therapeutic Voice of Olga Silverstein, autora de numerosos artículos, fundadora del Women's Project in Family Therapy, enseña en Estados Unidos, Europa y México regularmente. Dicen de ella Bradford Keeney: "...su estilo clínico es brillante. Carlos Sluzki: "...Olga es una clínica excepcional.

CARLOS SLUZKI

29 de Noviembre al 2 de Diciembre
TALLER CLINICO

LA ORGANIZACION DEL DISCURSO EN TERAPIA FAMILIAR

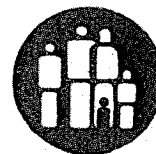
3 de Diciembre
SEMINARIO

CELOS: DE LOS ESCOZORES MENORES A LAS PASIONES ASESINAS

**CURSOS INTRODUCTORIOS INTENSIVOS Y AVANZADOS
EN TERAPIA DE PAREJAS Y TERAPIA FAMILIAR
EN EPISTEMOLOGIA SISTEMICA CIBERNETICA.**

iiINTERFAS
INSTITUTO DE TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA
Directora: Dra. Dora Fried Schnitman

Informes e inscripción en INTERFAS
Av. Figueroa Alcorta 3085 Piso 5 Apartamento B Teléfono 802-0312
Capital Federal (1425)
de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 horas
Inscripción en Librería Paidós
Las Heras 3741 Local 31 Teléfono 801-2860 Capital Federal



CENTRO DE
INVESTIGACION
FAMILIAR

Directora:
WANDA SANTI

"SEMINARIO TEORICO-CLINICO CON EL DR. REYNALDO PERRONE"

*Dir. del IFATC, Instituto de Formación y
Aplicación de Terapias de la Comunicación.*
SAINT ETIENNE - FRANCIA.

14 y 15 de Noviembre. Abierta la Inscripción.

"TALLERES DE PROFUNDIZACION CLINICA"

*Para terapeutas familiares con experiencia
teórica previa. Tratamientos familiares "en vivo".
Pre-post sesión. Ateneo clínico.*

"DEPARTAMENTO DE EXTENSION COMUNITARIA"

*Asistencia psicoterapéutica GRATUITA, para Parejas y Familias
de bajos recursos. Consultar en Secretaría.*

CHARLAS TEORICAS los 3er. jueves de c/mes a las 11:30.
Entrada libre.

AZCUENAGA 964 2º "C" - 1115 Capital - TE.: 961-4295 - 11 a 18

Carlos Srebrow y Asociados

Asesores en análisis y desarrollo organizacional

COUNSELING GRUPAL (Grupos de asesoramiento y desarrollo compartido)
Dirigentes de Empresas Familiares - Dueños de Empresas Unipersonales - Directivos de Instituciones y Asociaciones - Líderes y Conductores de Grupos de Trabajo - Profesionales Independientes.

CONSULTAS Y ASESORAMIENTO
Pequeña y Mediana Empresa
Empresa Familiar
Asociaciones e Instituciones
Persona y Rol Profesional

GRUPOS DE ESTUDIO
Introducción al Análisis Organizacional
Teoría y Práctica del Análisis Organizacional - Escuelas y Marcos Conceptuales del Fenómeno Organizacional
Empresa y Familia.

CAPACITACION
ORIENTACION OCUPACIONAL
SUPERVISION
INTERCONSULTAS

NUEVA DIRECCION

Avda. Raúl Scalabrini Ortiz 2255
(1425) Bs. As. - Tel. 72-3866

Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux

Directeur des cahiers
Mony Elkaïm

Responsables de la coordination
Edith Goldbeter & Eric Trappeniers

Pourquoi ces cahiers?

Etait-il nécessaire d'ajouter aux multiples revues de thérapie familiale une nouvelle mouture française?



Nous souhaitons répondre à 3 types de préoccupations:

- Ouvrir un débat théorico-technique sur nos pratiques en thérapie familiale
- Elargir ce débat à tous ceux qui, de différentes manières, remettent en question les institutions et les pratiques actuelles dans le champ de la santé mentale
- Mettre à disposition du public francophone des documents internationaux concernant ce domaine.

Ces cahiers sont réalisés en collaboration avec les revues "Family Process" (New York) & "Terapia Familiare" (Rome) et paraissent deux fois l'an.

Pour toute demande d'abonnement, écrire à:
Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux
Editions Privat

14, rue des Arts / 31068 Toulouse Cedex / France

Prix de l'abonnement pour deux numéros:
190 FF (France) ou 240 FF (Etranger)

Somme à envoyer au CCP Toulouse 1172-40B avec la mention:
"Abonnement aux cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux".

La inclusión de la historia en un modelo de terapia sistémica

ADOLFO LOKETEK

Médico Psiquiatra. Director General del Centro de Familias y Parejas (CEFYP). Billinghurst 1867, Buenos Aires, Argentina.

Conferencia leída en las 1as. Jornadas Interhospitalarias de Terapia Sistémica, el 7 de Junio de 1987, en el Hospital Zonal General Cirujano Mayor Diego Paroissien (Hospital de La Matanza).

... Porque la idea que nunca dejé de desarrollar, es que, al fin de cuentas, cada uno es siempre responsable de lo que se ha hecho de él —incluso si no puede hacer nada más que asumir ésta responsabilidad. Creo que un hombre siempre puede hacer algo con lo que se ha hecho con él. Es la definición que daría hoy de la libertad: ese pequeño movimiento que hace de un ser social totalmente condicionado una persona que no restituye la totalidad de lo que ha recibido de su condicionamiento; lo que hace de Genet un poeta, por ejemplo, aunque haya sido rigurosamente condicionado para ser un ladrón...

("El Escritor y su lenguaje"
de Jean Paul Sartre)

INTRODUCCION

El tema que abordaré hoy tiene que ver con el modelo Clínico-Teórico que esta-

mos desarrollando, algunos de cuyos aspectos presenté hace dos años.

Tomaré como guía una consulta en sus primeras entrevistas, su análisis y el lugar del Terapeuta (su "objetividad" a partir de las premisas básicas del modelo propuesto).

ASPECTOS TEORICOS

Las hipótesis que manejamos frente a una entrevista familiar derivan de nuestra epistemología relacional sistémica-organizacional-estructural a partir de la cual "percibimos" estructuras y nos consideramos involucrados en las mismas. En la medida que consideramos el lenguaje como metáfora de la realidad, hablar de estructura y juego son sinónimos para nosotros. Ambos conceptos remiten a un conjunto de participantes que interactúan con movidas —pensamientos-acciones-sentimientos— redundantes en un tiempo/espacio definido, cumpliendo reglas, cuyo significado y objetivo no está claro para los participantes.

Permítanme algunas aclaraciones sobre estos términos:

En lo que respecta al "juego" dicen Pallazzoli y otros:

"... es una modalidad de organización de las relaciones entre los individuos participantes, la cual evoluciona en el tiempo..."

"... un individuo hace cierto juego porque tiene ciertas motivaciones, como que tiene ciertas motivaciones porque participa en un determinado partido que le permite solamente determinadas movidas.

Con esto no consideramos para nada que los jugadores individualmente

persigan siempre fines bien definidos, ellos no tienen ciertamente la omnisciente racionalidad de los jugadores de Von Neuman.

Pero se hace esencial tratar de comprender los fines interactivos, que aunque confusamente, mediando entre distintas finalidades (implícita en la participación simultánea en varios juegos) persigue cada actor. . .”.

En lo que respecta a “Estructura” dice Poullion:

“... la estructura pues es lo que revela el análisis interno de una totalidad: los elementos, las relaciones entre estos elementos y la disposición de estas relaciones entre sí. . .”.

“... la estructura es entonces la regla de las transformaciones históricamente reales, la explicación de un funcionamiento y de un devenir. Es cierto, se ha vinculado primeramente al estudio de organizaciones sincrónicas y sistemas cerrados. Pero su historia muestra que no hay razón alguna para condenarlo a ello.

Un conjunto social no es una simple suma, sino una combinación compleja que sólo puede entenderse por el análisis de las relaciones interestructurales. Por otra parte, tanto una relación estructural interna como una relación interestructural pueden ser una contradicción. . .”.

Pensamos que la misión del terapeuta es denunciar en palabras el juego en acto, a diferencia de la denuncia sintomática. Esta denuncia del juego, así como la participación individualizada de cada jugador con su jugada es la función específica del Terapeuta, función que sólo podrá llevar

a cabo una vez que sea aceptado por la familia (Acoplamiento estructural). Creo importante enfatizar lo obvio de toda psicoterapia: solamente desde una relación empática nuestras intervenciones serán vividas como perturbaciones y no como destructivas.

Ahora bien, si aceptamos estas premisas, la situación terapéutica adquiere una complejidad mayor, desde la necesidad de integrar los juegos en la familia, y los juegos en el sistema terapéutico. Si la estructura familiar tiene su devenir peculiar en cada integrante, el terapeuta como actor y observador de la estructura terapéutica necesitará un lugar para pensarse en el devenir de sus propios juegos.

EL TRABAJO CLINICO

Cuando la familia M. llamó a la Institución a pedir una hora, no mostraba ninguna urgencia. El problema de Marta (la hija) era crónico. Hacía 8 años que tenía un diagnóstico de Esquizofrenia o Psicosis Maníaco Depresiva; y a pesar de haberse intensificado las agresiones que siempre tenían como eje a Marta e incluían a Analía (la madre), a José (el padre), Marcelo (el hermano) y Guido (el otro hermano), la familia M. daba la impresión de poseer estrategias para controlar estas conductas.

Se resolvió el momento de la citación luego de algunas transacciones con respecto a la fecha y horario.

Cuando aparece la necesidad de negociar, pensamos que hay sectores de la familia que están de acuerdo y otros no con respecto a la ayuda terapéutica y que siempre el que llama está de parte del “si necesitamos ayuda”. La pregunta que nos

hacemos es ¿por qué?; suponemos que es el que está más “hostigado” por el juego, el que tiene que enfrentarse con una conducta “nueva” para la cual no está determinado estructuralmente. En el caso de la familia M. el llamado fue hecho por Analía.

Una vez evacuada la utilidad de hacer una entrevista familiar (condiciones necesarias y suficientes) pasamos a recortar la Unidad Sistémica Inicial (USI) que incluye a todas las personas involucradas —familiares, terapeutas, maestros, jueces, etc.— tomando como eje el motivo de consulta, entre los cuales hacemos el recorte de la Unidad Sistémica de Citación (USC).

Esta 1ª Citación, así como las posteriores si fueran necesarias, tienen como objetivo, llegar a clarificar un problema relacional necesario de ser ayudado y el tipo de ayuda específica.

Para ello nuestros elementos son: la entrevista relativamente reglada (Despliegue-Foco-Cierre) y las fichas.

Volvamos a la Familia M. Durante la 1ª Entrevista a la cual concurren los cinco integrantes, todos estuvieron de acuerdo que el problema era Marta y sus agresiones y la relación más preocupante Marta-Analía.

La definición de Marta como psicótica clarificaba y justificaba todas las explicaciones relacionadas con los problemas de la Familia M.

Sin embargo, ¿cómo debíamos entender este nuevo pedido de ayuda en una situación crónica, con repetidas tentativas terapéuticas fracasadas?

Creo que todos podemos acordar que cuando en un sistema familiar existe un problema crónico, también tienden a cronificarse los lugares que ocupan los demás

miembros familiares y que el nuevo pedido de ayuda denuncia la aparición de una amenaza a esa cronicidad insatisfactoria estable (Jackson).

El nuevo pedido es fervientemente respaldado por aquel que se ve amenazado, en el caso de la Familia M. ¿cuál era la amenaza para la madre?

De cualquier manera la aceptación de Marta al pedido de consulta de la madre, el acompañamiento escéptico del padre, el venir resignado de Marcelo y el venir forzado de Guido, me mostraban un cuadro de lucha intrafamiliar que creo de vital importancia para la indicación, y como un momento óptimo para el cambio, dadas las contradicciones del sistema y cierto nivel de hastío de los protagonistas.

Durante los primeros momentos de la entrevista José me observaba intensa y desconfiadamente, Analía más suelta, los hijos sin merecer ningún comentario especial.

José a mi pedido inició el relato de los problemas con un tono medido, claro, formal y distante.

Yo percibía que me estaba estudiando. Muchas veces he vivido la misma experiencia con familias graves; si soy llamado en un momento de urgencia la entrega es total, la exigencia es por aliviar la situación inmediata. Si el llamado es en otro momento la exigencia se centra en el cuidado por no irritar las “consignas” oficiales de la familia; éste era el caso de la Familia M.

Este sentimiento de ser estudiado, investigado, puesto a prueba, es de una intensidad especial en las familias graves en los momentos de no urgencia, el pasar esta prueba, implica una aceptación, que entraña un nuevo riesgo, el de ser anulado

en mi función de terapeuta.

En el caso de la Familia M., el examinador mayor era José.

Una de sus técnicas examinatorias pasaba por el idish; si yo entendía lo que él hablaba, yo era judío y por lo tanto le producía una enorme tranquilidad.

El fraude consistía en que él me avisaba de esta maniobra después de utilizarla; jugadas que hablaban del fraude y de la denuncia del fraude, como movidas propias de una estructura que quedó subrayada en mi análisis de la Familia M. El juego propuesto era *te pongo a prueba - si pasás - explícito la maniobra*. Para poder jugar este juego hacen falta los siguientes jugadores: un examinador - un examinado - un contenido a examinar.

Obviamente un juego es una estructura percibida por un observador (el terapeuta) y traducida semánticamente de una serie de conductas acaecidas en el sistema terapéutico.

La correlación debería darse en el lenguaje utilizado por la familia para describir sus propios movimientos. La correlación entre percepciones de distintos subsistemas nos permitirá posteriormente algún tipo de hipótesis (ligadura semántica de dos descripciones).

La estructura enunciada por mí, de mi relación con José debería repetirse entre José y Marta, entre José y Analía u otros.

Y así en un nivel sincrónico José era el gran examinador familiar, Marta la examinada y permanentemente reprobada en su capacidad, su afectividad, su corporalidad.

¿Habría otra figura examinada...?

En nuestra hipótesis, en el momento de consulta alguien amenaza no continuar con sus jugadas, necesarias para la prosecución del juego.

En el caso de la Familia M. sería ¿que José se había hastiado de ser el examinador, o Marta de ser la examinada, o Analía y José habían exagerado su jugada, o había alguien que había denunciado el juego y los jugadores no sabían qué hacer con el intruso?

Mi respuesta afirmativa al idish de José permitió creo, mi entrada a la Familia M., la aprobación del examen; el desafío ahora era cómo redefinir las "consignas" oficiales, sin caer en una interacción destructiva, ni dentro del margen de equilibrio del sistema.

En otras palabras, si el juego descripto hacía a la organización del sistema ¿cómo estimular la aparición de otros juegos, los no jugados, los prohibidos de jugar?

¿Cómo salirse del examinador - examinado a examinar?

Estos primeros contactos son fundamentales. El terapeuta ha de ser aceptado siempre y cuando acepte el juego de la familia y las reglas (lenguaje, metalenguaje, relaciones, etc.) y por otro lado mantenga su autonomía, su capacidad de pensar, su metanivel. La familia lo pondrá a prueba una y otra vez.

En esa 1ª Entrevista yo utilicé la palabra *guerra* para definir las agresiones, rápidamente fui corregido por José, quien muy gentilmente me pidió que hablara de irritación o intolerancia. Pero una semana más tarde al tener que llenar una ficha, utilicé *guerra* para describir las hostilidades familiares. Estas oscilaciones del signifiante me daban una pauta de la inestabilidad de las normas que imposibilitaban cualquier acuerdo sobre qué debía cumplirse. Esta imposibilidad es lo que le permitía a José ocupar la función de jefe.

Analicemos estas primeras jugadas y podremos deducir que así como yo podía

jugar el lugar del examinado también debería ser el examinador en cualquier momento inmediato.

La intercambiabilidad de los lugares dentro del juego es una característica de los sistemas.

El objetivo siempre es mantener el juego, la estructura actual.

¿En la Familia M. era posible pensar que esta situación de examen era organizacional? ¿Cuándo podemos definir un juego, una estructura como perteneciente a la organización familiar?

Según Edgar Morín: "... la organización es la disposición de relaciones entre componentes o individuos que produce una unidad compleja o sistema, dotado de cualidades desconocidas en el nivel de los componentes o individuos. La organización une de forma interrelacional elementos o eventos o individuos diversos que a partir de ahí se convierten en los componentes de un todo. Asegura solidaridad y solidez relativa a estas uniones, asegura, pues, al sistema una cierta posibilidad de duración a pesar de las perturbaciones aleatorias".

La Sra. Analía no era judía, era hija natural, había nacido en una provincia argentina, no pertenecía a la clase social, ni económica, ni religiosa, ni cultural del Sr. José.

Ambos relataron que el padre de José (el Sr. A.) nunca la aceptó y que José tuvo que luchar mucho frente al padre para imponer su elección de pareja.

Este padre era judío, bastante tradicionalista y siempre preocupado por la religión de las parejas de su hijo.

Esta correlación entre mis observaciones de la estructura del sistema terapéutico, mis observaciones de la estructura actual de la Familia M., las observaciones

de José de su estructura histórica; me permiten hacer una hipótesis de lo organizacional.

Esta estructura examinador - examinado - a examinar viene dándose por lo menos desde la relación:

A / José

Analía

y sirve para mantener unido ese pasado con este presente y por lo tanto la sobrevivencia de la Familia M., mandato histórico de toda familia.

"... la naturaleza mortal busca, con sus medios, perpetuarse e inmortalizarse: el único medio de que dispone para su fin es la generación que perpetuamente sustituye al ser antiguo por uno nuevo. ... Tal es la estratagema por la que el mortal participa de la inmortalidad. ...". Platón, citado por E. Morín, *El Método* (La vida de la vida, Cap. II).

Aclaro además que el momento de la consulta coincidió con el hecho que Marta comenzaba a tener pareja.

Ahora, este mandato histórico de sobrevivencia ¿qué peculiaridad tenía en la Familia M.?

La peculiaridad debemos ir a buscarla en el discurso de los miembros actuales.

Si el Sr. José describe esa relación con A. como que éste lo investigaba, para luego no estar conforme y reprobarlo, para luego repetir el circuito investigador-investigado-algo a investigar, reprobado que permite tener que volver a dar examen, esta matriz debemos encontrarla o construirla en la relación José-Marta, con lo cual:



Este es un sistema de lugares intercambiables pero siempre presentes. Este juego de transferencias relacionales dentro del sistema familiar es habitual, pero el problema para la indicación es la detección de aquel subsistema que está en crisis a partir de la amenaza de no cumplimiento del mandato histórico.

Una interesante pregunta es por qué este subsistema con esta estructura se convierte en central para la identidad familiar de los M.

Para esta pregunta propongo una 1ª respuesta que se convierte en una nueva pregunta. ¿Quiénes han creado este juego?

En el caso de los M. parece claro que este juego proviene por lo menos de la generación anterior, puntualmente de la relación A.-José pero ¿por qué adquirió centralidad y jerarquía?

Creo que es válido suponer que entre A.-José quedó un conflicto, un enfrentamiento no cerrado, una deuda pendiente.

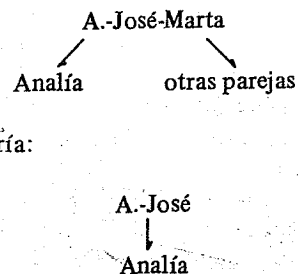
La muerte de A. selló ese no cierre en la relación A.-José.

Es posible pensar que esa estructura tiene que recrearse en la nueva familia, pero sin poder cerrarse.

Es decir que la recreación es total. La misma relación sin cierre (porque para que haya cierre debería ser absolutamente psicótica), José creer-se que Marta-José es A.-José que sabe y no sabe que no es.

Si Marta abandonara el campo, por creer, por una pareja, del conjunto recortado:

quedaría:



probablemente displacentera y amenazante para Analía.

De esto podemos deducir que entre Marta y Analía es necesario una unión muy intensa, tanto para que Analía no vuelva a un viejo lugar, como para que José mantenga el sueño del tiempo congelado.

Pero, ¿cuál ha sido la ventaja para Marta? pues yo creo que la de existir de alguna manera, frente al peligro más extremo de todo ser humano: "la de no existir".

¿Tenemos datos para aseverar esto? Mi hipótesis es que estos desafíos del existir, del no existir, del cómo existir dentro de la familia se definen y redefinen en cada momento en que un miembro entra o sale de un sistema (nacimientos - muertes - noviazgos - separaciones, etc.).

Si Marta dejó en algún momento de tener existencia propia, esta situación deberíamos buscarla en las entradas y salidas de miembros de la Familia M. como así también si ahora ella propone no jugar más, es posible que se estén enfrentando a una situación similar.

Como conclusión, estamos en condiciones de completar la fórmula anterior: el motivo de consulta nos denuncia la amenaza (alguna amenaza), a un juego organizacional del sistema familiar donde existe un amenazado (el que llama), de volver a ocupar un lugar del que pudo sa-

lir, lugar doloroso, displacentero, en un juego anterior.

Esta relación entre el paciente designado, el que pide la consulta, los juegos familiares y la historia, son importantes como guía para nuestras intervenciones.

EL LUGAR DEL TERAPEUTA

Ya algo comenté anteriormente sobre el lugar asignado y asumido por el terapeuta. Quisiera ahora retomar el problema. Dos de los principios básicos a los cuales adhiero fueron citados como postulados por Heinz Vön Foerster en su visita a Buenos Aires.

a) El Principio de Inclusión:

Yo soy parte del mundo.

b) El Principio del Devenir:

Yo soy producto de mi pasado.

Aplicados a nuestro quehacer terapéutico debemos entender que tenderemos inevitablemente a formar parte de los juegos de la familia, así como ellos tenderán inevitablemente a formar parte de nuestros juegos.

Podría entenderse esto como lucha por el poder, como quien ha de imponer el juego a jugar en la estructura terapéutica.

Mara Selvini dice: "... El poder puede ser una ilusión pero la lucha por el poder es una realidad. ...".

Es decir que mi ser parte de la estructura terapéutica determina mi participación activa y significativa; además solamente en la medida en que pueda ser significativo para el otro, mis intervenciones han de ser tenidas en cuenta y podrán tener algún efecto. Si el efecto está en relación directa con nuestra significación pa-

ra el sistema familiar, debemos ultimar los medios para existir dentro de la familia.

Por lo tanto la sesión tiene que movilizar, tiene que crear cierta tensión, tiene que provocar algún descubrimiento, tiene que estimular un trabajo intersesión.

No voy a referirme a las características de la sesión que fueron descriptas en un trabajo anterior y que seguimos utilizando todavía, me interesa enfatizar la presencia del terapeuta como la más significativa para el cambio.

El cumplimiento por la familia de todas las pautas del encuadre me sirvieron para considerar que yo existía para la familia en un lugar de significación.

El hecho que la Familia M. potencializaba en mí recursos no habituales, me estimulaba a escribir, me sentía en un desafío seductor con José, en una provocación ingenua con Marta, en una incógnita extraña con Analía, en un no sé qué con Marcelo y en una tristeza tierna con Guido, me daba la pauta que la familia y cada uno existían significativamente para mí. Este interjuego relacional forma parte de los elementos necesarios y suficientes para indicar la experiencia terapéutica.

Un terapeuta que percibe, escucha y conceptualiza de esta manera, tiene ciertas premisas, algunas de las cuales paso a enunciar:

Comprensión del fenómeno a estudiar

1. El ser humano se totaliza en sus interrelaciones;

2. esta totalización tiende a repetir estructuras incorporadas de las familias de origen;

3. algunas estructuras relacionales funcionan como mandatos y hacen entonces a la organización familiar (Identidad de Clase);

4. el problema puede ser visto en cómo reaccionan los individuos frente al no cumplimiento del mandato "... El hombre está siempre condicionado y siempre rebasa sus condicionamientos pero sólo para instalarse en otros que a su vez serán rebasados. ...", Sartre, citado por Poullion;

5. el castigo posible frente al que no cumple el mandato es el no ser en el sistema. El desafío para los custodios del mandato es el tener que redefinir su lugar.

Referente al proceso terapéutico

6. La descripción del juego no alcanza para el cambio;

7. la contradicción entre Cambio y no Cambio, entre seguir y no seguir sometido es el motor del cambio;

8. esta redefinición es la que aleja al sistema del punto de equilibrio;

9. la entrada y salida del Terapeuta son momentos de crisis fundamentales para el sistema;

10. la nueva estructura incluye cambios relacionales y como muchas veces hemos observado, la incorporación de nuevos miembros en una suerte de organización del movimiento de cambio. Todos hemos vivido tanto en nuestra experiencia terapéutica como sociales grandes emociones, cambios espectaculares, impresionantes movilizaciones, pero también sabemos que sin una adecuada organización posterior todo se pierde.

RESUMEN

Toda sesión de Terapia Familiar puede ser vista como un juego con movidas que llevan a cabo sus participantes. Movidas que

tienen que ver con la necesidad de mantener una estructura determinada por mandatos-históricos.

El momento de consulta denuncia la amenaza a esta estructura, amenaza que es vivida por alguien, generalmente el que pide la consulta como catastrófica. Las correlaciones entre el motivo de consulta, el contactante, la estructura actual familiar, la estructura histórica y la estructura del sistema terapéutico serán los elementos básicos para toda hipótesis.

Es importante descubrir el juego que desarrollan los participantes para mantener la estructura que se ha convertido en esencial para la identidad del sistema familiar. La esencialidad se constituye a partir de una "deuda" no saldada con miembros de la familia de origen. Estas premisas básicas requieren un terapeuta singular, algunas de cuyas peculiaridades se reseñan en este trabajo.

BIBLIOGRAFIA

- JEAN PAUL SARTRE: *El escritor y su lenguaje*, Edit. Tiempo Contemporáneo, 1969.
 MARIA SELVINI PALAZZOLI: *El problema del hermano como la persona que deriva*, en Revista Terapia Familiar, N° 16, pág. 73-100, Buenos Aires, Argentina.
 JEAN POULLION: *Presentación: Un ensayo de definición*, en Problemas del Estructuralismo, México 1966, Edit. Siglo XXI (1967).
 ANNA M. NICOLÒ CORIGLIANO: *La relación terapéutica en la terapia familiar*, en Revista Sistemas Familiares, Diciembre 1986.
 ADOLFO LOKETEK: *Algunos problemas técnicos en terapia familiar*, trabajo presentado en el III Congreso Argentino y I Panamericano de Terapia Familiar, Buenos Aires, Agosto 1985, Ficha CEFYP N° 229.
 EDGAR MORIN: *El Método*, Tomo 1, Edit. Cátedra (1977).
 H. MATURANA: *El árbol del conocimiento*,

Santiago de Chile, Edit. Universitaria, OEA 1984.

MARA SELVINI PALAZZOLI: *El individuo en el juego*, Revista Terapia Familiar, Noviembre 1985, N° 19.

COMENTARIO AL ARTICULO "LA INCLUSION DE LA HISTORIA EN UN MODELO DE TERAPIA SISTEMICA", DEL DR. ADOLFO LOKETEK

DR. ALFREDO A. CANEVARO

"Aquellos pueblos que no recuerdan su pasado, tendrán que repetirlo. ..."

Goethe

El trabajo de Loketek nos introduce en un tema fascinante. El interjuego entre organización, estructura, mandatos y libertad.

Todo esto referido básicamente al Proceso Terapéutico como ángulo de lectura del juego vital de la familia.

En cuanto al rol que juega la historia de una familia dentro de dicho Proceso, hay posturas muy diversas dentro de las escuelas de Terapia Familiar.

Dicen muy bien los interaccionistas que la historia está contenida en el aquí y ahora del interjuego de una familia, pero sabemos que con sólo corregir las disfunciones actuales no se reconstruye el sentido de la historia y mucho menos se le da una visión prospectiva que sirva como prevención primaria transgeneracional.

Por otro lado las escuelas de orienta-

ción psicodinámica, insistiendo en un causalismo unidireccional *buscan* en la historia las causas de la disfunción actual. En estos casos, la confusión de la técnica con la teoría es la fuente de muchos fracasos terapéuticos. Dentro del Proceso Terapéutico de una Familia, la reconstrucción de la historia viene *después* de la resolución de las disfunciones y emerge sola, va naciendo como producto de un buen proceso, no como resultado de una búsqueda. Surge como corolario de un movimiento natural de intento de significación del ser humano que sufre. Se impone como una sorpresa, como algo que estaba ahí sin que lo viéramos, *tanto* para el terapeuta como para los pacientes.

La aproximación ingenua del terapeuta, olvidando "momentáneamente sus teorías" es su contribución a crear el clima adecuado de acompañamiento emocional que permite estos descubrimientos compartidos. Es ahí cuando los pedazos del puzzle se juntan y cuando la integración de la historia compartida se acompaña del insight intrapersonal para crear juntos ese sentido de la historia que tenga valor terapéutico.

Aquí es donde la terapia familiar juega su papel quizás fundamental y pocas veces valorado (por no ser fácilmente demostrable), de prevención primaria transgeneracional, o sea, interrumpiendo una repetición estereotipada de los dilemas familiares entre los mandatos rígidos de busca de trascendencia por un lado y el caos natural de lo viviente por el otro. Es entonces aquí donde el terapeuta juega un papel clave, como pivote integrador no sólo de la historia (en el sentido diacrónico), sino también del presente (sincrónico), como representante de la sociedad (tiempo y contexto determinado).

Se destaca en el trabajo de Loketek el papel central del terapeuta como artesano que conoce su oficio, no dejándose llevar por modas que lo alejen del punto nodal de su quehacer clínico.

Junto con el aporte enriquecedor de las hipótesis constructivistas coexiste el peligro de un alejamiento del rigor clínico, que como brújula está basado en una

empatía profunda con aquellos que sufren. La difícil confrontación clínica de una "lectura de la realidad" que esté alejada de los objetivos terapéuticos, pueden distorsionar los aportes teóricos novedosos, sobre todo para los terapeutas noveles (y no tan noveles), quienes pueden refugiarse en la teoría como vallado ante una realidad clínica a veces sofocante.

CENTRO DE ESTUDIO DE TERAPIA FAMILIAR

(C.E.TE.FA.) Rosario

Director: Dr. Fidel Lebensohn

SEMINARIO INTERNACIONAL a cargo:

DR. MAURIZIO VIARO

NUOVO CENTRO PER LO STUDIO DELLA FAMIGLIA (Milán)

Directora: Dra. MARA SELVINI PALAZZOLI

Lugar: Asociación Médica de Rosario
Horario: de 9 a 12 y de 14 a 16 horas

Nuestro Centro tiene en esta ocasión una especial satisfacción de haber invitado al Dr. Maurizio Viaro, ya que conoce las cualidades del mismo por haber compartido y observado su trabajo en el Equipo de la Dra. Palazzoli, en ocasión de haber visitado dicho Centro en el año 1985.

Las nuevas ideas sobre los Juegos Psicóticos, como el tratamiento de las Anorexias Nerviosas Crónicas son dos temas en que el Dr. Viaro ha contribuido a elaborar en el Equipo de Milán de la Dra. Palazzoli; y es justamente de estos dos temas que se ocupará en el Seminario que realizará en nuestro Centro.

- Tema del Seminario: "Tratamiento Individual de las Anorexias Crónicas y Abordaje Sistémico de los Juegos Psicóticos". (Exposición Teórica - Mostración de Video de Sesiones Familiares en Castellano - Preguntas de los concurrentes).
- Inscripción: Cupo limitado estricto (haga su inscripción lo antes posible).
- Secretaría e Informes: Tucumán 1060 PB "A" - 2000 Rosario.
Tel.: 67-038 - Lunes a viernes de 16 a 20 horas.

CERF

*Centro para el estudio de
las relaciones familiares*

DIRECTORES

Psic. Olga Benzaón-González

Pisc. Alberto González

TALLER

Problemas que se presentan para la terapeuta mujer en la Terapia de Pareja.

Docente: Psic. Olga Benzaón-González

Duración: 8 clases. Setiembre/Octubre

CURSO INTRODUCTORIO A LA TERAPIA FAMILIAR

Docente: Psic. Benzaón-González y profesores invitados

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA

Terapias de Familias y Parejas (Aranceles institucionales)

PROFESORES INVITADOS 1988/1989

Dr. Harry Aponte (Filadelfia, USA) / Dr. Carmine Saccu (Roma, ITALIA)

Solicitar informes a:

SOLER 3765, 4to. PISO, "J", Nro. 18

TE.: 824-1188

Lunes a Viernes de 14 a 20.



LIBRERIA PAIDÓS

CENTRAL DEL LIBRO PSICOLOGICO

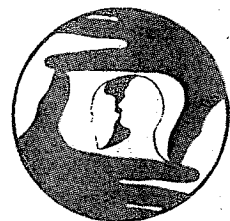
LE OFRECE: *TODOS LOS TEMAS
TODAS LAS REVISTAS
TODAS LAS EDITORIALES
TODAS LAS NOVEDADES*

PARA SU COMODIDAD
SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO
SIN CARGO ADICIONAL

**LAS HERAS 3741
LOCAL 31**

**801-2860
BUENOS AIRES**

CENTRO DE
FAMILIAS Y
PAREJAS



CENTRO DE
FAMILIAS Y
PAREJAS

CEFYP

ENCUENTRO INTERNACIONAL
24/25/26/27 DE OCTUBRE DE 1990

**"LA TERAPIA FAMILIAR EN LA ULTIMA DECADA
DEL SIGLO XX"**

— 11 ANIVERSARIO —

INVITADOS CONFIRMADOS:
DR. MAURIZIO ANDOLFI
DR. CARLOS SLUZKI

Director General: DR. ALFREDO LEKETEK
Directora de Asistencia: LIC. MARIA ROSA GLASERMAN
Directora de Docencia: LIC. ALBA SCHABAS

CURSO

SEXUALIDAD DE LA PAREJA

Coordinadora:
LIC. JOSEFINA RABINOVICH

Horario:
Viernes de 13:00 a 16:00 hs.
del 16 de setiembre al
4 de noviembre

DIRIGIDO A:
Terapeutas de
Familias y Parejas

CURSO

**LA TERAPIA FAMILIAR
De la Clínica a la Teoría**

Coordinadora:
LIC. ALBA SCHABAS
Colaboradora
PSIC. MARTA ALBARRACIN
Horario:

Viernes de 13:00 a 15:30 hs.
del 7 de octubre al
18 de noviembre

DIRIGIDO A:
Profesionales de la salud,
interesados en un acercamiento
a la terapia familiar

¿Por qué las llamamos todavía "paradojas"?

Ph.D. PAUL DELL

Profesor Asociado de Psiquiatría y Ciencias de
la Conducta, Eastern Virginia Medical School,
205 Business Park Drive, Virginia Beach,
V.A. 23462

Revista *Family Process*, Vol. 25, No 2, 1986.

Traducción: Inés Dates

terapeuta, parecería que deben fracasar (o aún empeorar las cosas). Y aquí, en esta última serie de intervenciones es donde esperaríamos encontrar las así llamadas paradojas. ¿Por qué? *Porque las llamamos "paradojas"*. Es poco probable que un terapeuta llame "paradójica" a una intervención si ésta es consistente con sus opiniones teóricas.⁴

Pero obviamente, muchos terapeutas que usan habitualmente paradojas dirían: "Pero yo *no* encuentro que estas intervenciones sean paradójicas o sin sentido. Pueden ser paradójicas para mis clientes, pero no para mí. ¿Por qué las usaría si no tuvieran sentido para mí?". Por el momento, mi respuesta a esta contestación muy justificada toma la forma de otra pregunta: ¿Si estas intervenciones *sí* tienen sentido, por qué llamarlas *paradojas*?

Mi intención, en este punto, es focalizar la atención en nuestro uso de esta palabra, "paradoja". Quizás, como dirían algunos terapeutas, usamos el nombre "paradoja" porque estas intervenciones son paradójicas para nuestros *clientes* (pero no para nosotros). Podría ser así, pero no estoy convencido. Primero, el término "paradoja" es usado por muchos terapeutas que no prestan ninguna atención al tema de si sus intervenciones "paradójicas" son o no paradójicas para sus clientes. Segundo, muchas de las así llamadas intervenciones paradójicas están explícitamente construidas para que las paradojas *tengan sentido para el cliente*. Y tercero, el término "paradoja" es usado frecuentemente en la literatura profesional (y coloquialmente en las discusiones entre terapeutas) para referirse a intervenciones que claramente no son paradójicas para el cliente. ¿Por qué, entonces, seguimos usando el término "paradoja"?

El pensamiento y la conducta de un terapeuta están guiados por un conjunto de supuestos y creencias sobre la naturaleza humana, la naturaleza de los problemas humanos, y la naturaleza de los mecanismos por los que corren cambios terapéuticos. Estas creencias generan un conjunto de intervenciones que "tienen sentido" (para ese terapeuta. En otras palabras, estas intervenciones "sensatas" son las que —dados los supuestos del terapeuta sobre los seres humanos, los problemas humanos y la naturaleza del cambio terapéutico— probablemente tengan éxito. Recíprocamente, los supuestos del terapeuta también especifican implícitamente una serie (mucho más amplia), de intervenciones que *no* "tienen sentido". Esta segunda serie de intervenciones son las que, por ser inconsistentes con los supuestos del

CREENCIA Y PARADOJA

Nosotros, seres humanos, parecemos estar poderosamente apegados a nuestras creencias y expectativas sobre el mundo en que vivimos. Cuando nos enfrentamos con la necesidad de *cambiar* una creencia —es decir, cuando los hechos dejan de verificar nuestras expectativas— a menudo parecemos más inclinados a invalidar los datos que se nos presentan que a invalidar nuestra creencia. Así, podemos considerar espúreos a los datos; podemos juzgar que la situación que está frente nuestro es defectuosa o funciona mal;⁷⁻⁸ podemos rotular el fenómeno observado como “paradoja”.

Cuando llamamos a algo una “paradoja”, podemos desear o no confrontarlo. Por un lado, podemos elegir confrontarlo al luchar con la diferencia entre: a) lo que nuestra creencia predijo que iba a ocurrir, y b) lo que realmente ocurrió (es decir, la paradoja). Por otro lado, podemos usar el término “paradoja” para *evitar* confrontar esta discrepancia. Cuando tomamos este último camino y evitamos enfrentarnos con la paradoja, ella queda enclavada en nuestra teoría como un quiste. Cuando esto ocurre, la creencia o teoría puede permanecer impermeable a la paradoja casi indefinidamente.

La ciencia está generalmente deseosa de confrontar sus paradojas. Cuando la comunidad científica identifica una paradoja, rápidamente se transforma en el blanco de considerable esfuerzo para reconciliarla con la teoría corrientemente aceptada. La física, por ejemplo, usa frecuentemente el término “paradoja” para identificar un fenómeno todavía no explicado. En consecuencia, se entiende que esta paradoja es el próximo enigma principal que debe resolver esa rama particular de la fí-

sica. En contraste con estos físicos, los psico-terapeutas pueden parecer menos deseosos de confrontar sus paradojas.

En general, los terapeutas están más atraídos (como es natural) por el asunto práctico de cómo usar paradojas que por el problema teórico de cómo explicarlas. De acuerdo con esto, han generado un amplio cuerpo de conocimientos sobre el uso clínico de estas intervenciones. En este sentido aplicado, clínico, los terapeutas “paradójicos” sin duda entienden lo que están haciendo, y por cierto, encuentran muy sensatas a estas intervenciones. De ninguna manera intento discutir esto.

Lo que este artículo intenta decir (en lo que se relaciona a las paradojas) es que nos falta una explicación adecuada y comprensiva de estas intervenciones. *Lo que se necesita es una teoría que integre tan bien a las paradojas con nuestra superestructura teórica más amplia que estas intervenciones no nos parezcan ya ni siquiera vagamente paradójicas.* Con la posible excepción de la explicación del MRI de que la solución mantiene el problema,²⁵ tal teoría no ha sido desarrollada todavía. En lugar de ello, la literatura sobre psicoterapia contiene ahora un número considerable de mini-teorías *post-hoc* sobre la paradoja que, como máximo, están sólo vagamente integradas con cualquier teoría comprensiva del ser humano, familias y terapia.*

De todo esto, extraigo dos conclusio-

* La paradoja y sus mini-teorías son probablemente un buen ejemplo de lo que Bateson¹ llamó “nociones explicatorias imperfectamente definidas” (p. xviii). Bateson sostuvo que las ciencias de la conducta han sido enormemente trabadas por su tendencia a generar “nociones imperfectamente definidas” (por ejemplo; ego, in-

nes. Primero, en contraste con mi pensamiento anterior,⁴ y a pesar de nuestras mini-teorías y habilidad clínica para aplicar estas intervenciones, estoy convencido ahora que *todavía* hay un sentido importante en el que las paradojas no son comprendidas. Es decir, que no habiendo encontrado ninguna razón convincente para llamarlas todavía paradojas, concluyo (a pesar de nuestra competencia en el uso clínico de estas intervenciones) que todavía —en algún sentido— nos parecen paradójicas. Segundo, nuestro fracaso para explicar completamente estas intervenciones (para que su paradójicidad se desvanezca totalmente) puede significar que estamos protegiendo (o, al menos, actuando de acuerdo con) algunos supuestos importantes. Si esto fuera así, entonces el concepto de “paradoja” —y sus mini-teorías acompañantes— puede en realidad estar al servicio de salvaguardar estos supuestos al confinar a las paradojas a un quiste relativamente estéril dentro del corpus de la teoría más amplia. Berenson,³ ha postulado que la rotulación y las mini teorías están protegiendo actualmente nuestros convencionales supuestos epistemológicos occidentales de una variedad de fenómenos teóricamente inquietantes (por ejemplo, hipnosis, conversiones religiosas, remisión espontánea, efecto placebo, paradoja, y otros).

Sólo por razones muy poderosas las paradojas (u otros fenómenos) son enquis-

teligencia, madurez, introversión y otras muchas), cada una de las cuales tiene su propio cuerpo de teoría e investigación pero están *minimamente relacionadas una con otra*. Como tal, la paradoja terapéutica puede ser definida más perfectamente sólo si es relacionada adecuadamente a una teoría más general o comprensiva.

tados vía este proceso de rotulación y mini-teorías. Típicamente, la razón reside en: a) la naturaleza convincente de nuestras experiencias pasadas, y b) la gravedad de la disrupción que estas paradojas causarían si nuestros supuestos básicos tuvieran que acomodarse a ellas.

La Paradoja Copernicana

El cambio en la visión del mundo que necesitó Copérnico fue enorme —tanto cognitiva como emocionalmente. Su impacto *emocional* fue enfatizado a menudo: “El heliocentrismo de Copérnico sacó al hombre del centro del universo brutal e insultantemente, y lo colocó en la periferia” (p. 29).¹³ La enormidad del cambio *cognitivo* que requirió el heliocentrismo se hizo aparente tan pronto como fue publicado *De Revolutionibus Orbium Coelestium* (1543). El mundo se dividió en dos campos: los que creían a Copérnico y los que continuaban creyendo que el sol gira alrededor de la tierra. Y esto no es nada sorprendente. El hecho sorprendente es que *durante años, aún los científicos que creían en Copérnico se referían a su modelo heliocéntrico como “la Paradoja Copernicana”!* Ver a la tierra girando alrededor del sol como “natural” y no como “paradójico” era demasiado para lograrlo rápidamente. Hoy, los que hemos crecido con el modelo copernicano vemos como natural el que la tierra gire alrededor del sol, a pesar de nuestra experiencia del sol levantándose en el este y poniéndose en el oeste, nos parece casi imposible ver el modelo copérnico como una paradoja.

Actualmente, los terapeutas parecen estar divididos en dos bandos en relación al tema de las intervenciones paradójales:

a) los que creen en (y predicen el uso de) paradojas, y b) los que no creen en ellas (y que, quizás irónicamente, desaconsejan su uso). Igual que los seguidores de Copérnico, que alcanzaron una comprensión inicial del sistema solar heliocéntrico, así también, los terapeutas paradójicos alcanzaron una cierta comprensión clínica de las intervenciones paradójicas. Por otra parte, sospecho que los terapeutas paradójicos encuentran que estas intervenciones son tan una paradoja como los tempranos seguidores de Copérnico encontraban la visión del mundo heliocéntrica paradójica. ¿Por qué? Porque, como los tempranos seguidores de Copérnico, los terapeutas paradójicos siguen usando el término "paradoja".*

Creo que cuando nuestras teorías se hayan acomodado completamente a estas intervenciones paradójicas (en el mismo grado en que nos hemos acomodado todos a la visión del mundo heliocéntrica), vamos a dejar de llamar "paradojas" a estas intervenciones. Además, creo que los terapeutas ya no vamos a ver el resultado de esas intervenciones como paradójicas en *ningún* sentido. En lugar de ello, veremos al mundo operar según lo que hayamos llegado a aceptar y entender como el orden "natural" de las cosas.

Conducta "sintomática" y selección natural

El principio de la selección natural es una

simple tautología: Los organismos que pueden sobrevivir en un medio particular sobreviven (y se reproducen); los que no pueden sobrevivir en ese medio mueren. El mismo principio puede aplicarse a la conducta. Una conducta que continúa siendo exhibida por un organismo es obviamente compatible con el medio en la que se manifiesta. Recíprocamente, una conducta cesará cuando el medio no sea ya compatible con ella. Compatibilidad está siendo definido de la misma manera empírica, tautológica, como se definió supervivencia y selección natural. Aquellas conductas que son compatibles con su medio sobreviven; las que no son compatibles, cesan.

El comportamiento sintomático de un cliente es compatible con el medio en que él vive —por definición. Si el comportamiento sintomático no fuera compatible, cesaría. Por lo tanto, cuando un cliente viene a ver a un terapeuta, el terapeuta sabe que no ha habido nada en el entorno del paciente incompatible con la continuación de la existencia de ese síntoma. Esto es necesariamente así. Si el entorno de la persona *fuera* incompatible con la existencia de ese síntoma, entonces el síntoma ya no existiría y la persona no estaría en el consultorio del terapeuta. Esta conclusión tautológica es obvia, pero no es trivial. No es trivial porque debemos suponer (a no ser que seamos proclives a un exceso de arrogancia) que el paciente y sus otros significativos han hecho lo posible para solucionar el problema del cliente. Han hecho lo posible para hacer que el entorno sea incompatible con la existencia conti-

nuada de la conducta sintomática del cliente. Y han fallado: cónyuges, amigos, hijos, padres, empleadores, policía, maestros, terapeutas anteriores y el o la misma cliente.

Cada una de estas personas tiene sus creencias sobre la naturaleza de los seres humanos, y sobre cómo uno resuelve esos problemas. Dado el número de personas que seguramente han estado involucradas, es probable que constituyan una muestra representativa de nuestras creencias culturales sobre la gente y la naturaleza de sus problemas. Este conjunto colectivo de creencias genera un conjunto de intervenciones que "tienen sentido" o son "lógicas". Si uno desea acreditar al cliente y a sus otros significativos un grado razonable de esfuerzo y persistencia, pueden decirse dos cosas interrelacionadas. Primero, que se ha probado que el conjunto general de creencias culturales (sobre cómo cambiar a ese cliente) es como mínimo inadecuado, si no directamente incorrecto. Cuanto más crónico sea el problema, más categóricamente podemos hacer la última afirmación. Segundo, casi todo lo que "tiene sentido" o es "lógico" probar ya ha sido ensayado con ese cliente —y se ha demostrado que no funciona. Otra vez, cuanto más crónico el problema, más seguramente se puede hacer esta segunda afirmación. Como último, quizás es humillante considerar que cuanto más crónico sea el problema, más seguramente se puede hacer la segunda afirmación sobre los terapeutas: Las intervenciones que "tienen sentido" para los terapeutas también han fracasado.

Si todo lo lógico ya ha sido probado y se ha comprobado que es inefectivo para un cliente, entonces ¿qué queda para probar? Lo que queda, por supuesto, son las intervenciones que no tienen sentido, las

intervenciones paradójicas.

Pero debemos admitir que esta afirmación —el que sólo queden intervenciones paradójicas— puede ser discutida por lo menos de dos maneras. Primero, se puede sostener que intervenciones que antes no parecían tener sentido son vistas ahora bajo nueva luz y vemos que tienen mucho sentido. De hecho, un número creciente de terapeutas: a) están tratando con éxito problemas crónicos con intervenciones que no tendrían sentido para los que antes estuvieron involucrados ayudando en el caso; b) están encontrando que estas intervenciones son eminentemente sensatas para ellos; y c) no llaman "paradojas" a estas intervenciones. Pero sin embargo, ¿cómo tenemos que entender el hecho que intervenciones exitosas son a menudo llamadas "paradojas" —aún por los terapeutas que las usan?

Segundo, se podría argüir que las intervenciones que todavía falta probar no son paradójicas, sino que, simplemente, son *desconocidas*. Se podría decir simplemente, "no sé cómo resolver este problema". Este argumento es bastante defendible, pero su aplicabilidad está severamente circunscripta. Específicamente, uno puede hacer esta afirmación (que las intervenciones que falta probar no son paradójicas, sino desconocidas) *sólo* si se admite que no sabemos qué hacer, *sólo* si se admite que nuestra teoría actual no funciona. Pienso que muy raramente concedemos la derrota de nuestras teorías. Podremos conceder la derrota en resolver el problema, pero tendemos a aferrarnos firmemente a nuestras creencias teóricas sobre cómo resolver ese problema.²⁵ Esto es tan cierto para nosotros los terapeutas como lo es para nuestros clientes y sus otros significativos (que están tratando de resolver el

* Esta afirmación no es completamente exacta. Un número creciente de terapeutas no convencionales están empezando a evitar el uso de la palabra "paradoja". Pienso que esos terapeutas

constituyen la avanzada de un cambio de paradigma que está ocurriendo actualmente en varios campos.³⁻¹¹⁻¹⁴⁻¹⁵⁻¹⁹⁻²²⁻²³⁻²⁴

problema del cliente). Mientras nos neguemos a admitir que el fracaso en la terapia cuestiona nuestra teoría, entonces las intervenciones exitosas, inconsistentes con nuestra teoría, deben ser consideradas paradójicas.

Entonces, ¿cuál es el fondo (*bottom line*) en cuanto a la paradoja en psicoterapia? Sugiero que los terapeutas actuales están siendo confrontados por anomalías (paradojas) que anuncian la necesidad de una revolución teórica.¹⁶ En particular, pienso que algunos fenómenos son implícitamente sentidos como paradójicos porque entran en conflicto con importantes supuestos básicos que tenemos. Así, aunque este trabajo es ostensiblemente sobre paradojas, realmente es sobre algo mucho más amplio. Entiendo que nuestra preocupación con las paradojas es tanto un síntoma como un indicador que señala el camino hacia ese tema más amplio.

DETERMINISMO ESTRUCTURAL

En lo que sigue, hacemos una suposición: Todos los sistemas vivientes se conducen de acuerdo con sus estructuras. Es decir, que cuando un organismo interactúa con algún aspecto de su entorno, la estructura de ese organismo determina cómo va a responder. De hecho, éste es el supuesto básico de la ciencia. La ciencia supone que, al sondearlo de una manera particular, un objeto va a revelar su propio y característico modo de comportarse (cuando es explorado de esa manera particular). Así, no es la prueba la que determina unilateralmente la reacción del objeto, sino el objeto que determina unilateralmente su reacción a la prueba. Maturana¹⁸ llama a este supuesto "determinismo estructural".

El principal correlato del determinismo estructural es que los objetos (incluyendo a los sistemas vivientes) no pueden realizar una "interacción instructiva".¹⁸ Es decir, la exposición de un profesor no determina lo que los estudiantes llegan a comprender; en lugar de ello, es la estructura de cada estudiante lo que determina la suerte de la exposición del profesor. Aunque hablamos de las exposiciones en las aulas en términos de "instrucción", tal instrucción no es lineal. El profesor no puede unilateralmente conseguir que los estudiantes comprendan su exposición. Igualmente, un ladrón con un revólver no causa unilateralmente que la víctima le de su dinero; algunas víctimas se desmayan, algunas gritan, algunas escapan, otras contraatacan. Lo que determina qué ocurre cuando el ladrón dice: "La bolsa o la vida" es la estructura de la víctima potencial. De esto, podemos ver lo siguiente: Aún si la víctima le da su dinero al ladrón, no está sufriendo una interacción instructiva; la víctima está simplemente comportándose según se estructura. La aparente ilusión de interacción instructiva está dada por nuestro éxito en calcular correctamente la respuesta determinada estructuralmente de un objeto (u organismo) a un acontecimiento particular en su entorno. Así, como sabemos que la inmensa mayoría de los seres humanos le van a dar el dinero a un ladrón, nosotros (y el ladrón) podemos sentir la ilusión de que es posible la interacción instructiva. No lo es.*

* En su último libro, Bateson² adaptó su concepto de "principio dormitivo" y lo usó para designar esas explicaciones que dan crédito a la posibilidad de interacción lineal, unilateral o instructiva.

Si fuera posible que nuestros clientes sufrieran la interacción instructiva, entonces la terapia sería una empresa sin esfuerzo: El terapeuta haría su intervención y todos los clientes responderían de manera idéntica a esa intervención. Desafortunadamente (o quizás afortunadamente) esto no ocurre. En lugar de ello, el terapeuta interviene y la estructura del cliente determina la suerte de la intervención del terapeuta.

Al observar la suerte de esa intervención, el terapeuta tiene la oportunidad de aprender algo sobre el cliente. Si su intervención tiene éxito, el terapeuta aprende que su visión del cliente era correcta: El cliente *es* modificado por ese tipo de intervención. Si la intervención falla, entonces el terapeuta podría aprender que su visión del cliente era incorrecta: el cliente *no es* modificado por esa intervención. Esta última lección, sin embargo, a menudo no es aprendida. A pesar de la evidencia visible de que la intervención no cambió al cliente, los terapeutas a menudo continuamos creyendo que esa intervención o cambiará o debería cambiar al cliente.

Como terapeutas, respondemos típicamente al fracaso de nuestras intervenciones en una de estas tres formas. Decidimos que nuestra teoría y visión del cliente es correcta, *pero* que: a) "Hice incorrectamente la intervención"; b) "No la hice durante suficiente tiempo"; o c) "Debería haber funcionado, pero algo está mal en el cliente" (es decir, el cliente no coopera, es resistente, patológico, no está listo para la terapia, y otras). En otras palabras, somos capaces de interpretar o descalificar los datos para que nuestros supuestos teóricos se mantengan. (Ver específicamente el trabajo de Shaw).²² Y, porque nuestras teorías permanecen intactas, después se-

guimos haciendo intervenciones que son especificadas por esas teorías. Watzlawick, Weackland y Fish²⁵ llaman a esto el fenómeno "más de lo mismo".

Este fenómeno "más de lo mismo", no está, por supuesto, limitado a nuestro funcionamiento como terapeutas. *Siempre* somos renuentes a abandonar nuestras creencias, especialmente esas creencias que son más importantes para nosotros. Max Plank sabía de qué hablaba cuando dijo que "una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes mueren gradualmente, y crece una nueva generación que está familiarizada con ella" (pp. 33-34).²⁰ Es inevitable que esta tendencia general a conservar nuestras creencias desempeñe un papel en aislar a los terapeutas del impacto (potencialmente) corruptor de las paradojas. Sin embargo, debe haber más que conservadurismo plankiano en la incógnita de por qué todavía llamamos "paradójicas" a algunas intervenciones. Este artículo va a argüir ahora que: a) la lentitud en normalizar (des-paradojizar) las "paradojas" terapéuticas se debe a nuestra creencia profundamente enraizada en la *objetividad*, y b) que nuestras dificultades conceptuales con la paradoja y la objetividad son debidas, a su vez, a nuestra tendencia a actuar como si fuera posible la interacción instructiva.

EL MITO DE LA INTERACCION INSTRUCTIVA

Maturana¹⁸⁻¹⁹ y muchos constructivistas²⁴ han proporcionado el último insulto epistemológico: Somos fundamentalmente incapaces de percibir objetivamente

te al mundo. Peor aún, no tenemos razones válidas para sostener que hay una realidad objetiva que existe independientemente de nosotros.¹⁴⁻¹⁵⁻¹⁸⁻¹⁹⁻²³ Como dijimos más arriba, el determinismo estructural implica directamente que somos incapaces de interacción instructiva. Y, porque somos incapaces de sufrir la interacción instructiva, es imposible para nosotros recibir información objetiva sobre el mundo que nos rodea. El mundo no determina cómo lo percibimos; en lugar de ello, nuestra estructura determina cómo percibimos o producimos a mundo. Así, no somos los recipientes pasivos e inocentes de "la" información del mundo. En un sentido, todos sabemos esto. Sin embargo, hay evidencia que *repetidamente parecemos olvidar que la interacción instructiva es imposible*.

Objetividad

El mundo que vemos no es un mundo que existe objetivamente; el mundo que vemos es el que nuestra existencia determinada estructuralmente produce.¹⁹ Aunque los humanos no pueden ver nunca un mundo objetivo, frecuentemente discutimos sobre lo que "realmente" ocurrió o quién vio "correctamente" las cosas. El quid del determinismo estructural es que cada persona ve las cosas "correctamente" —de acuerdo a su propia estructura— pero que no puede haber una visión absolutamente correcta. Cualquier opinión sobre la que se coincide como siendo la opinión correcta (u objetiva) es sólo eso —un acuerdo. Es un consenso.

Este tema de la imposibilidad de la objetividad no es ciertamente nada nuevo en sí mismo. La historia de esta posición

comienza por lo menos tan temprano como los pre-socráticos (si no más) y continúa hasta el presente en el trabajo de los constructivistas y otros (ver, por ejemplo, *La realidad inventada* de Watzlawick).²⁴ Dado la existencia de estos trabajos tan tempranos no es ciertamente mi intención afirmar que la imposibilidad de objetividad es una idea nueva. El mensaje esencial de este artículo reside en su doble denuncia-alegato sobre la imposibilidad de objetividad: 1) que todavía no hemos comprendido la amplitud de las ramificaciones ligadas a esta imposibilidad de objetividad;* y 2) que una comprensión fundamental del problema de la objetividad —uno que revele la extensión y penetración del problema— requiere el conocimiento de sus mecanismos subyacentes: a) el funcionamiento estructuralmente determinado de los observadores humanos que operan en acoplamiento estructural con el medio en el que existen, y b) la imposibilidad de interacción instructiva. La comprensión de estos últimos mecanismos sólo se ha hecho posible recientemente con la ontología biológica, radical, de Humberto R. Maturana.¹¹

* Von Glasersfeld¹⁴⁻¹⁵ se refiere a los que no toman en serio el problema de la objetividad como "constructivistas triviales". Los constructivistas triviales aceptan que nuestras percepciones y conocimiento del mundo puedan no ser objetivas, pero —al no tomar seriamente el problema de la objetividad— siguen tratando de encontrar la "verdad objetiva" sobre (lo que ellos creen ser) un mundo real que existe independientemente de cualquier observador. En contraste, los constructivistas radicales arguyen que no tiene sentido hablar de ninguna realidad aparte de las operaciones del observador.¹² Von Glasersfeld¹⁴⁻¹⁵ y Stolzenberg²³ nos proveen de reseñas especialmente claras de este último punto de vista sobre la realidad.

Comunicación

En tanto que lo que vemos u oímos sólo puede ser lo que cada uno produce singularmente en su interacción estructuralmente determinada con el medio en que existimos, entonces los desacuerdos sobre qué fue objetivamente comunicado (por ejemplo: "No oíste lo que dije"; "No estás escuchando lo que digo"; "Estás entendiendo mal lo que digo deliberadamente") revelan nuestra subyacente confianza en un mundo objetivo que de hecho no existe. Tal desacuerdo puede eventualmente tener como resultado que una de las partes entienda lo que la otra quiere que entienda, pero esa comprensión *no* establece la naturaleza objetiva de lo que fue comunicado. La comunicación exitosa es consensual, no objetiva.

Refuerzo

Los estudiosos ingenuos de la teoría del aprendizaje tienen problemas para comprender el hecho de que los refuerzos no tienen existencia objetiva. En lugar de ello, cada organismo responde a algunas contin-

gencias del entorno aumentando (o disminuyendo) la frecuencia de una conducta particular. El refuerzo que ocurre es, por supuesto, la *respuesta* del organismo a la contingencia; la contingencia es sólo un refuerzo *relativo* a la estructura de ese organismo. Un terapeuta conductista no puede ir a una tienda y comprar una caja de refuerzos. La penetración cotidiana de la creencia en refuerzos objetivos se revela por la frecuencia con la que padres y maestros continúan obstinadamente usando "recompensas" no recompensadoras y "castigos" no castigantes.

Información

El determinismo estructural implica precisamente, que nuestra comprensión convencional de la información está equivocada.¹⁸ Hablamos de maestros que tienen información que imparten a sus alumnos, pero esa información no puede tener existencia objetiva. Los maestros pueden percibir que la información es objetiva, pero tal objetividad aparente es de hecho una manifestación de su consenso en relación a tal información. "Información", cuando impartida a los alumnos, no determina lo que aprenderán; en cambio, sus estructuras determinan cómo van a responder (lo que harán con) a la información. Por las mismas razones, no puede haber algo como un *estímulo* objetivo. En un experimento que usa un estímulo standard, cada organismo en el experimento define la naturaleza de ese estímulo por cómo responde a él. Como notaron Ruesch y Bateson²¹ en relación a la comunicación, el significado de una comunicación es la respuesta que produce. Similarmente, la naturaleza de un estímulo es definida por la

Maturana, sin embargo, dice que él *no* es un constructivista por las siguientes razones: a) sostiene que un observador considera que la cognición ocurre en un sistema viviente toda vez que él o ella aceptan la conducta del sistema como la conducta adecuada en el dominio que él o ella especifican; b) que en cualquier instante producimos el mundo que producimos en los dominios sociales como el único que puede ser producido, y que todos los mundos alternativos sólo existen en nuestras descripciones; y c) que su explicación de la cognición no es un modelo —que es lo que von Glasersfeld considera que es el constructivismo radical¹⁵— sino una explicación ontológica.

respuesta que provoca —y es diferente para cada organismo, incluyendo al experimentador y cada lector de su artículo. Sin embargo hay (habitualmente) suficiente consenso en la comunidad científica sobre la definición operacional del estímulo, para que: a) pueda parecer objetivo, y b) pueda proseguir la investigación.

Respuestas Paradojales e Intervenciones Paradojales

Las respuestas son percibidas como paradójicas porque el observador (que considera que la respuesta es paradójica) cree que un estímulo particular es objetivo. Por ejemplo, el efecto calmante “paradojal” de los estimulantes en un niño hiperactivo es paradójico *sólo* porque el observador ha caído en creer que las anfetaminas son objetivamente estimulantes.* No lo son. El efecto de la anfetamina está determinado por la estructura del organismo, no por la anfetamina. De la misma manera, las intervenciones paradójicas son “paradojales” porque el observador (quien considera que esas específicas intervenciones son paradójicas) está creyendo en algún nivel que tales intervenciones son objetivas. No lo son. Por ejemplo, el efecto de decir a

una persona que practique su síntoma, está determinado por la estructura de esa persona, no por la naturaleza supuestamente objetiva o instructiva de la intervención (que podría llevarnos a pensar que practicar el síntoma podría hacerlo peor).

Resistencia

El concepto de resistencia, tal como es usado coloquialmente por la mayoría de los terapeutas, sólo es inteligible si se cree que la interacción instructiva puede o debe tener lugar. Es decir, la noción de resistencia supone que la intervención terapéutica (que supuestamente está siendo “resistida”) *debería* haber producido una determinada respuesta (o una clase determinada de respuestas). Cuando el cliente falla en manifestar esa respuesta determinada (es decir, cuando falla en ser correctamente “instruido” por la intervención del terapeuta), entonces se considera que el cliente está “resistiendo”. Por otro lado, si esta situación es considerada en términos de determinismo estructural, no hay resistencia: El paciente está respondiendo a la intervención de la única manera en que él o ella pueden hacerlo —de acuerdo con su estructura. Llamar “resistencia” a

* Se puede sostener que los físicos no creen realmente en que las anfetaminas son objetivamente estimulantes. Es decir, quizás llaman a la reacción del niño hiperactivo una “reacción paradójica” *sólo* porque esa respuesta difiere de la típica o esperada. Ciertamente es verdad que la respuesta no es la que se esperaría de una anfetamina, pero el término “estimulante” revela claramente que hemos objetivizado y hecho unilateral la supuesta habilidad estimulante del “estimulante”. Además —y más importante— el uso del término “estimulante” revela nuestra

forma de tratar con el mundo cotidiano y espereable. *Habitualmente reducimos las interacciones relacionales de las situaciones cotidianas (ej., la interacción anfetamina-organismo a la acción de agentes lineales (“estimulantes”) sobre recipientes pasivos.* Tales reducciones podrían ser, en realidad, una conveniencia taquigráfica, pero el hábito de estas reducciones nos lleva repetidamente a hablar y actuar como si la interacción instructiva fuera posible, y genera “paradoja” no bien la esperada interacción instructiva no ocurre.

esa respuesta es: a) negarse a aceptar que la estructura del paciente es como es, y/o b) insistir que la interacción instructiva debería haber tenido lugar pero que el paciente está impidiendo voluntaria o inconscientemente que ocurra, y c) dejar de advertir que uno ha usado una intervención inapropiada o inefectiva.⁶

Homeostasis

Un sistema que permanece sin cambios a pesar de determinadas intervenciones es llamado a menudo “homeostático”. Los así llamados sistemas homeostáticos pueden parecer estar manteniéndose a sí mismos iguales, o dicho de otra manera, pueden parecer estar resistiendo el cambio. Sin embargo, formular de esta manera la homeostasis es ver la homeostasis como una forma de resistencia. Hablar del sistema como manteniéndose igual a sí mismo (o como resistiendo el cambio) es implicar que el cambio hubiera debido tener lugar —pero que se impidió. Es implicar que la interacción instructiva hubiera podido o hubiera debido ocurrir.

La homeostasis no es una propiedad objetiva del sistema; es un fenómeno relacional.¹⁰ *Relativo* a un conjunto particular de intervenciones, un sistema —que se está comportando de acuerdo con su estructura— permanece igual. Relativamente a un *diferente* conjunto de intervenciones, el sistema cambiará.¹⁰ Describir un sistema como homeostático es decir de hecho que las intervenciones que uno había creído que cambiarían el sistema, no lo hacen.

Patología

Igual que la resistencia y la homeostasis,

la patología es entendida a menudo de forma que implica que la interacción instructiva hubiera podido o debido tener lugar. Sostener que un organismo es patológico —que hay algo mal en él— implica que el organismo debería estar respondiendo de forma diferente a como lo está haciendo. Implica que el conjunto de circunstancias ambientales presente *debería* provocar una conducta diferente del organismo. Pero ¿por qué debería comportarse de manera diferente? Cuando pensamos que el organismo debería comportarse de manera diferente, y cuando lo definimos como “enfermo” por no comportarse de otra manera, es claro que: 1) no deseamos aceptar la estructura del organismo como es (es decir, afirmamos que hay algo mal en ella), y/o 2) pensamos que hubiera debido tener lugar una interacción instructiva pero que el organismo fracasó en ser correctamente instruido porque es defectuoso. Este tipo de razonamiento es bastante evidente en lo que probablemente es el prototipo de comprensión de la patología en términos de interacción instructiva: el concepto psiquiátrico de *prueba de realidad*. Una persona que no ve “correctamente” el mundo (uno que fracasa en ser “correctamente” instruido por la “realidad”) se considera defectuoso o patológico. Sin embargo, la realidad no es objetiva. Es consensual.

EL PROBLEMA SUBYACENTE

Ahora vemos que la pregunta con la que comenzamos —“¿Por qué las llamamos todavía ‘paradojas’?”— ha desarrollado una veta más profunda: ¿Por qué creemos (o al menos actuamos como si creyéramos)

que es posible la interacción instructiva? Pienso que la respuesta es doble: a) nuestra experiencia lineal nos lo dice, y b) no queremos pagar el costo cognitivo y emocional que supondría para nosotros tal cambio en nuestra visión del mundo.

La validez experiencial de la interacción instructiva

Al dedicarnos a los problemas de la naturaleza de la paradoja, la objetividad, el determinismo estructural, la interacción instructiva, y otros, es crucial trazar una distinción entre el dominio de la *experiencia* y el dominio de la *explicación* (ver, por ejemplo Maturana¹⁹). Todos los conceptos —paradoja, objetividad, y así— son *representaciones* o *explicaciones* de la experiencia de los observadores. Sin embargo, en ningún caso puede ser reemplazada la experiencia por conceptos, representaciones o explicaciones. Estos son dominios fenomenológicos que no intersectan, que no pueden ser reducidos uno al otro. Sin embargo, teorías e hipótesis (que pertenecen únicamente al dominio de la explicación) pueden ser validadas empíricamente sólo en el dominio de la experiencia.¹⁹ Esto es, una hipótesis o teoría específica (al menos implícitamente) las operaciones que un observador debe llevar a cabo para obtener (para experimentar) la validación empírica de la hipótesis o teoría en cuestión (ver también Stolzenberg.²³ Así que la experiencia valida la explicación.

¿Por qué somos tan persistentes en creer en la objetividad y la interacción instructiva? Pienso que parte de la respuesta es que *nosotros tenemos la experiencia de un mundo objetivo*. Dicho de otra manera, nuestra experiencia del mundo que perci-

bimos es instructiva —y esto es necesariamente, porque la experiencia *sólo* puede ser experimentada instructivamente.

La experiencia es constitutivamente instructiva o lineal. Cuando alguien me golpea con una piedra, mi experiencia es que ese aspecto de mi experiencia —la piedra— unilateralmente (instructivamente) causa otro aspecto de mi experiencia —mi dolor.* De manera similar, si yo lanzo una piedra a través de la calle, mi experiencia es que mi lanzarla (que es un aspecto de mi experiencia) causa el vuelo de la piedra (otro aspecto de mi experiencia). En el dominio de la *explicación*, sin embargo, insistiré en que estos incidentes *no* fueron ejemplos de interacción instructiva o causalidad lineal, sino que fueron más bien interacciones determinadas estructuralmente entre mi cuerpo, la piedra, el campo de la fuerza de gravedad de la tierra, y así. Por lo tanto, aunque necesariamente experimentamos los acontecimientos de manera instructiva, nuestro uso del concepto de interacción instructiva (o causalidad lineal) para *explicar* esos mismos acontecimientos es inadecuado.

No obstante, nuestra experiencia lineal (instructiva) de un mundo objetivo es obviamente bastante adecuada para nuestra existencia como criaturas vivientes. Esto es, esta experiencia instructiva es la única

* La aserción de que la experiencia es constitutivamente lineal o instructiva sigue siendo válida aún si puede demostrarse que: a) la causalidad es una construcción genética del niño (como sostuvo Piaget), y b) la causalidad nunca puede ser lógicamente justificada por la secuencia de experiencias que nos lleva a hacer *post hoc ergo propter hoc* asunciones causales (como sostuvo Hume). Tanto Piaget como Hume se estaban refiriendo a la explicación más que a la experiencia.

experiencia que tenemos; nos permite vivir, funcionar, y hacer todas las cosas que hacemos. Nuestra experiencia instructiva es inadecuada sólo cuando la empleamos en el dominio de la explicación (y ello en el dominio de la explicación). Y sin embargo, nuestra experiencia instructiva de un mundo objetivo es absolutamente competente (obligatoria). Como resultado de ello, a menudo confundimos dominios al usar esta experiencia instructiva que nos constriñe para caracterizar o explicar el mundo que percibimos. Siempre que hacemos esto, sin embargo: 1) creemos en una realidad independiente; 2) lo que nos llevará a creer en extrañas nociones de comunicación, resistencia, homeostasis, y patología objetiva; y 3) nos circunscribiremos a luchar con un cada vez más retorcido conjunto de explicaciones que están intentando (sin éxito) explicar esas extrañas nociones objetivas de comunicación, resistencia, homeostasis y así.

Los costos de abandonar nuestra creencia en la objetividad

Los costos emocionales de abandonar nuestra creencia en la objetividad (y, por ende, nuestras “paradojas”) son que perdemos certeza, y que debemos asumir la responsabilidad por “el” (nuestro propio) mundo. Si adherimos a la tesis del determinismo estructural, debemos aceptar que la objetividad es imposible. Habiendo hecho eso, ya nunca podremos tener certeza; ya no podremos sostener que sabemos cómo es realmente el mundo. En compensación por esta pérdida de certeza, se nos dará el pesado regalo de saber que somos responsables por nuestras propias percepciones y reacciones (ver también Dell⁹)

Somos responsables de nuestras percepciones y reacciones porque *nosotros* —no un mundo supuestamente objetivo— las generó. Ya no podremos sostener que circunstancias objetivas nos instruyeron a comportarnos de esta manera: “Nuestro cómodo recurso de atribuir la culpa a los otros o a las circunstancias ya no estaría a nuestro alcance”.* (p. 327).²⁴

Los costos cognitivos de adherir al determinismo estructural son innumerables, pero pueden resumirse en una frase: Nuestra visión del mundo es cuestionada. Ya no podremos ver a la resistencia, la homeostasis, la paradoja y la patología de la misma forma. No podremos tener certeza sobre qué arreglar (es decir, patología) en la terapia y ya no podríamos usar la resistencia y la homeostasis para explicar por qué a veces fracasamos en lograr cambios. Normalizaríamos nuestras paradojas. Nos veríamos obligados a reconsiderar seriamente la naturaleza de la información, comunicación, y aún nuestra existencia en el planeta. Y, lo más importante de todo, el consenso se vería como un aspecto fundamental de la existencia más que como un mero fenómeno social negociado (ver Dell,¹¹ Maturana¹⁸⁻¹⁹).

Un Comentario Final

El lector puede no estar convencido por mi tesis de que llamamos “paradójicas” a

* Para mi conocimiento, tal ética de la responsabilidad fue primero presentada en una conferencia Wennwe-Gren sobre cognición en Chicago, Marzo de 1969, por Maturana.¹⁷ Desde entonces, esta ética ha sido articulada por von Foerster, von Glasersfeld, Varela, Watzlawick²⁴ y otros.

algunas intervenciones porque profesamos una creencia subyacente en la objetividad (es decir, en la interacción instructiva). Sea como sea, espero que al menos haya infectado al lector con mi pregunta: "¿Por qué las llamamos todavía 'paradojas'?" Pienso que nos debemos la respuesta a esa pregunta.

RESUMEN

El hecho de que los terapeutas califiquen a algunos acontecimientos como "paradójicos" podría sugerir que nuestros conocimientos y teorías actuales son limitados en su habilidad para dar cuenta adecuadamente de esos fenómenos. Se arguye que es nuestra subyacente creencia en la objetividad lo que rodea a las "paradojas" terapéuticas con una persistente aura paradójica, y lleva a confusión en la comprensión de una variedad de fenómenos. Las ideas de Maturana respecto el determinismo estructural, la interacción instructiva y los dominios fenoménicos son usados para sugerir una respuesta a esas dificultades.

Se sostiene que el status problemático de muchos conceptos teóricos (por ejemplo, comunicación, información, resistencia, homeostasis y patología), está revelando algo muy importante— que la validez experiencial de la interacción instructiva nos lleva repetidamente a emplear la implícita o explícitamente en un terreno donde nunca puede ser válida: el terreno de la teoría y la explicación. *Family Process* 25: 223-234, 1986.

BIBLIOGRAFIA

1. BATESON, G.: La ciencia de la mente y el

- orden. En G. Bateson, *Pasos hacia una ecología de la mente*. New York: Ballantine Books, 1972.
2. BATESON, G.: *Espíritu y Naturaleza: una unidad necesaria*. New York, E.P. Dutton, 1979.
3. BERENSON, D.: *El Workshop OUT*. Princeton NJ, Junio 1984.
4. DELL, P.F.: Algunos pensamientos irreverentes sobre la paradoja. *Family Process* 20: 37-42, 1981.
5. DELL, P.F.: Paradox Redux. *Journal of Marital and Family Therapy*. 7: 127-134, 1981.
6. DELL, P.F.: Beyond homeostasis: Toward a concept of coherence. *Family Process* 21: 21-41, 1982.
7. DELL, P.F.: Pathology: The original sin. Conferencia presentada en la Primera Conferencia Internacional de Epistemología, Psicoterapia y Psicopatología, Houston TX, Setiembre 1982.
8. DELL, P.F.: Clinical Epistemology: a psychology for networking. Conferencia plenaria invitada en el 21º encuentro anual de la Asociación de Psicología Humanística, Toronto, Ontario, Canadá, Junio 1983.
9. DELL, P.F.: From pathology to ethics. *Family Therapy Networker* 7: 29-31, 64, 1983.
10. DELL, P.F.: Why family therapy should go beyond homeostasis: a Kuhnian reply to Tyano, Carel and Ariel. *Journal of Marital and Family Therapy* 10: 351-356, 1984.
11. DELL, P.F.: Understanding Bateson and Maturana: Toward a biological foundation for the social sciences. *Journal of Marital and Family Therapy* 11: 1-20, 1985.
12. DELL, P.F.: Review of Paul Watzlawick's, *The invented reality*. *Family Process* 24: 290-294, 1985.
13. GELLNER, G.E.: *Legitimation of belief*. New York: Cambridge University Press, 1974.
14. GLASERSFELD, E. von: An introduction to radical constructivism. en P. Watzlawick (ed), *The invented reality*. New York: W. Norton, 1984.
15. GLASERSFELD, E. von: *Reconstructing the concept of knowledge*. Trabajo presentado en el Seminario sobre Constructivismo, Archivos de Jean Piaget, Ginebra, Suiza, 1984.
16. KUHN, T.S.: *La estructura de las revoluciones científicas*. (2da. edición) Chicago: University of Chicago Press, 1970.

17. MATURANA, H.R.: Neurophysiology of cognition. En P. Garvey (ed), *Cognition: A multiple view*. New York: Spartan, 1970.
18. MATURANA, H.R.: Biology of language: The epistemology of reality. En G.A. Miller y E. Lenneberg (eds), *Psychology and biology of language and thought*. New York: Academic Press, 1978.
19. MATURANA, H.R.: The biological foundation of self consciousness and the physical domain of existence. Unpublished manuscript, 1986.
20. PLANCK, M.: *Scientific autobiography and other papers*. Westport CT Greenwood Press, 1971.
21. RUESCH, J. y BATESON, G.: *Communication: The social matrix of psychiatry*. New York: W.W. Norton, 1951.
22. SHAW, R.: Principles of contextual therapy. Taller presentado en el Boston Center for Contextual Study, Boston MA, Octubre 1982.
23. STOLZENBERG, G.: ¿Puede una investigación sobre los fundamentos de las matemáticas decirnos algo interesante sobre la mente? En G.A. Miller y E. Lenneberg (eds), op. cit. (Reimpreso en forma abreviada en P. Watzlawick (ed) *La realidad inventada*, op. cit.).
24. WATZLAWICK, P.: *La realidad inventada*, New York: W.W. Norton, 1984.
25. WATZLAWICK, P., WEACKLAND, J. y FISCH, R.: *Cambio: Principios de formación y de resolución de problemas*. New York: W.W. Norton, 1974.

COMENTARIO AL ARTICULO: "¿POR QUE LAS LLAMAMOS TODAVIA PARADOJAS?", DE PAUL DELL

CUANDO LA EXCEPCION ES LA REGLA

FIDEL LEBENSOHN

Director del Centro de Estudio de Terapia Familiar (CETFA), Tucumán 1060 PB "A", Rosario 2000, Argentina. Teléfono: 67-038

Nosotros no vemos aquello que no vemos

Heinz Von Foerster¹

El artículo de Paul Dell siguiendo las bases del Determinismo Estructural de Hum-

berto Maturana, nos vuelve a replantear la Cibernética de segundo orden que nos sacó de nuestra tranquilidad, cuando conformes con la explicación de Whitehead y Russell² sobre los tipos lógicos, nos describieron a la Paradoja como la excepción que había que evitar.

Desde ese entonces nos propusimos cumplir fielmente la posibilidad de no confundir miembro y clase, como forma de mantener la "normalidad" en nuestro sistema de relación y así salvarnos del doble vínculo patogénico. Vivimos dando cuenta de la objetividad que estaba allí delante de nuestra observación, tratando de mantenernos separados de ella, interpretándola o explicándola.

Al día de hoy vemos que la confusión entre miembro y clase es la situación límite de todo acto creativo o de "coherencia", y que es la reentrada a la autoreferencia de cada ser, como no lo plantea Varela en su artículo "A calculus for Self-Reference"³, basado en las leyes de la forma de Spencer Brown⁴, en donde el autor valora las antinomias o paradojas como forma de romper la "Consistencia Epistemológica" o el empotramiento en una cultura que privilegia la estabilidad y el equilibrio homeostático o sea la Cibernética de primer orden.

Desde el trabajo esclarecedor de Rabkin R.⁵ sobre la diferencia entre el simple vínculo como el fenómeno universal en toda comunicación o sistema de relaciones, nosotros hablamos⁶ que la antinomia era la forma de espiralar la relación en donde no hay sujetos y objetos separados sino en un permanente fluir de mismidades en proceso por definir la relación y en juego de poder sin lucha.

Como en el ejemplo siguiente, cuando la madre le dice al hijo: "Yo quiero que

tú quieras libremente". El hijo le contesta: "gracias, haré lo que me dices pero a mi manera".

Si la madre lo acepta pasa a un meta-nivel de aprendizaje con el hijo en "Coherencia Epistemológica". Si la madre no lo acepta, crea un doble vínculo que mantendrá la "Consistencia Epistemológica".

Paul Dell nos demuestra desde su concepción cómo gracias a la Paradoja el observador se plantea su ignorancia y apertura, y cuán saludable es poder desencadenarla o percibirla en un sistema de relaciones, porque es lo que nos permite la autoreferencia, la observación de nuestra observación, por ende el desenvolvimiento de nuestra autoconciencia.

Por otro lado nos ubica en el verdadero nivel de la relación terapéutica, cual es poder perturbar y no instruir: Nadie entra en el otro absolutamente sino cada uno selecciona su posibilidad de acuerdo a su estructura.

De allí que todo proceso de relación tenga posibilidades de caer en paradojas o en núcleos paradójales, defendiendo la "Consistencia Epistemológica", cayendo en el error de la verdad en sí, momento privilegiado en que el sistema puede consultar.

"Los sistemas familiares como sistemas humanos oscilan dentro de un continuum que va de la "Coherencia Epistemológica" a la "Consistencia Epistemológica" entendiendo por Coherencia; conexión, enlace, relación, y por Consistencia; solidez, duración, equilibrio. El primer polo de este continuum pertenecería al dominio de la explicación, de la causalidad circular, al de la estética, mientras el otro polo al dominio de la descripción, de la causalidad lineal, de la pragmática.

Cuando un sistema familiar nos consul-

ta, consideramos que viene de un estado de "Consistencia Epistemológica", es decir que defiende la descripción redundante sintomatológica, buscando explicaciones lineales a la realidad que vive. Dependiendo del tiempo que el sistema ha cursado en la defensa de esta Consistencia, tratando de buscar el equilibrio para aceptar el cambio que se está operando o por operar.

Es decir, el sistema familiar que opera a través de fluctuaciones en su devenir en clausura operacional, autoorganizándose permanentemente no recibe instrucciones del exterior, sino las que selecciona y determina su propia estructura. Es un sistema disipativo alejado del equilibrio que ha estado moviéndose de la Consistencia a la Coherencia y viceversa a través de su ciclo evolutivo llamado Ciclo de Vida Familiar. Ahora bien, cuando debe superar en un metanivel integrador sus puntos de Consistencia o de equilibrio entra en situaciones de Coherencia, caos o inestabilidad, aumento de la fluctuación hasta un máximo punto llamado de bifurcación que es vivido por el propio sistema como una crisis de valores y normas, "crisis" de la visión del mundo que hasta ese momento tenía.

En términos generales podemos decir que esa visión del mundo en cuanto a normas y valores están anclados en el entrelazamiento de tres generaciones implícitas en el presente, por lo que interpretamos que cada "crisis" de Coherencia se tiene que enfrentar a esta complejidad interaccional generacional que llamamos "juego familiar".

Así vamos deduciendo que el ciclo de vida de una familia o juego familiar va pasando por crisis que son vividas y transformadas en metaniveles inéditos y creativos de nuevas estructuras que mantienen la organización invariante, en la que nunca

el sistema familiar se adapta al exterior sino que es perturbado por él y selecciona desde su propia estructura las conductas inéditas que quiere vivir o incorporar. Ahora bien, en algunos momentos estas crisis que amenazan la estabilidad y la objetividad de sus integrantes, en vez de dar paso a una nueva estructuración inédita, tratan de defender la estructura anterior, el caos de la Coherencia trata de ser homeostáticamente equilibrado en una Consistencia ya conocida, es cuando aparecen las llamadas paradojas.

Los integrantes defienden la objetividad de su realidad a ultranza, no pueden superar su momento de praxis redundante por una situación de verdadera creación estética, el síntoma en ese caso aparece como mensajero más estructurado y la familia consulta.

A estas demandas el terapeuta, que conoce este juego familiar no cae en la ilusión de la instrucción, y sabe que sólo puede perturbar manteniendo su "Coherencia Epistemológica". Realiza operaciones de distinción con su objetividad entre parénesis, dibuja y objetiva el dibujo familiar, pero siempre como instrumento que per-

mite observar la respuesta retroactiva del mismo, en un espiral permanente, la familia dibuja al terapeuta y el terapeuta dibuja a la familia permanentemente".

BIBLIOGRAFIA

1. HEINZ VON FOERSTER: *Cybernetics of Cybernetics*. Philosophical Aspects of Cybernetics. Schuster Eds. New York, 1979.
2. WHITEHEAD, A.N. y RUSSELL B.: *Principia Mathematica*. Cambridge: Cambridge University Press, 1910.
3. VARELA F.: *A Calculus for Self-Reference*. INT. J. General Systems, 1975. Vol. 2, pp. 5-24.
4. SPENCER BROWN, G.: *Laws of Form*, E. P. Dutton, New York, 1979.
5. RABKIN, R.: *Critique of the Double Bind*, Sluzky y Ransom editores, Double Bind: The Communicational Approach to the Family. New York: Grune y Stratton, 1976.
6. LEBENSOHN FIDEL y LEBENSOHN ELENA: Revista de Terapia Familiar N° 16, 1987. *Coherencia Epistemológica y Terapia Familiar Sistémica*.
7. LEBENSOHN FIDEL y colaboradores: *Funcionamiento del Gabinete de Terapia Familiar Sistémica del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Hospital Provincial del Centenario*. Rosario. Presentado a las Jornadas de Terapia Interhospitalaria Sistémica. La Matanza, Buenos Aires, 1987.

Sistemas Familiares

Directora: Lic. I. Cecile Rausch Herscovici

Revista
cuatrimestral



Algunos de los artículos que publicaremos en 1988, nuestro IV año.

- Un diagrama de flujo que presenta el proceso de toma de decisión del Centro de Terapias Breves del M.R.I. (M. Rosenthal y Z. Bergman)
- La persona y la práctica del terapeuta (H. Aponte y J. Winter)
- Organización y novela: las dos caras de la familia y de la terapia (F. Berceili)
- La desaparición del individuo. Una entrevista a Jay Haley
- Explorando situaciones psicosociales en geriatría: ciclos y fronteras. II parte (B. Montalvo y R. Thompson)
- La cibernética del absurdo. Un homenaje a Carl Whitaker (B. Keeney)
- El tratamiento de adolescentes suicidas y sus familias (J. Landau-Stanton y D. Stanton)

Comité asesor internacional

G. Altamirano (Chile), M. Andolfi (Roma), H. Aponte (Filadelfia), G. Bernal (P. Rico), J. Colapinto (Filadelfia), D. Efron (Journal of Strategic Systemic Therapies), M. Elkaim (Bélgica), C. Falicov (California), Ch. Fishman (Filadelfia), F. Kaslow (W. Palm Beach, Florida), J. Landau-Stanton (Rochester, N.Y.), I. M. Martínez (México), S. Minuchin (Nueva York), B. Montalvo (Albuquerque, N.M.), M. Rittman (Oakland, CA.), A. Serrano (Filadelfia), R. Simon (The Family Therapy Networker), C. Sluzki (Pittsfield, MA.), M. Duncan Stanton (Rochester, N.Y.), H. Stierlin (Alemania Occ.), S. Zambrano de Senti (Colombia).

- ☐ Vol I., 1985 (2 ejemplares) U\$S 10.-
- ☐ Vol II., 1986 (3 ejemplares) U\$S 15.-
- ☐ Vol III., 1987 (3 ejemplares) U\$S 15.-
- ☐ Vol IV., 1988 (3 ejemplares) U\$S 15.-

SUSCRIBASE

Nombre _____
Dirección _____
Ciudad _____ Estado - País _____ C.P. _____

Sólo se aceptarán cheques de bancos estadounidenses y librados a la orden de Pedro Herscovici. (No enviar giros postales.)

Enviar a: Billinghurst 1599 - 2º A - (1425) Buenos Aires, Argentina.

tempora

INSTITUCION
PSICOTERAPEUTICA

11 años en Salud Mental.

Espacio y clima adecuados para resolver a favor las situaciones críticas que motivan la consulta del paciente, su familia, su terapeuta.

Tempora es alternativa temporaria del vínculo familiar, al que respalda.

Tempora es apoyo de las soluciones abiertas por el profesional a cargo.

Tempora es opción que surge de una decantada práctica institucional.

- * Hostal
- * Residencia Terapéutica Intermedia
- * Internación
- * Comunidad del tiempo (Hospital de día)
- * Club de fin de semana

- * Internación domiciliaria
- * Acompañantes Terapéuticos
- * Emergencias domiciliarias
- * Asesoramiento en Salud Mental
- * Consultorios Externos
- * Docencia, Investigación y Prevención

TEMPORA

Centro Institucional y Consultas:
Soler 5961 (1425) Capital
Teléfonos: 771-8114/08

Directores
Dr. Felipe Díaz Usandivaras
Dra. Mirfa I. Méndez Puig

Coordinadores:
Lic. Enrique Goldengruss
Lic. Elsa Silvini
Lic. Virginia Martínez



FAMILIA
Y
SALUD

— Prevención
— Asistencias
— Investigación
— Docencia

PROFESIONALES TITULARES

Lic. Beatriz Barinboim	Lic. Susana C. Galperin
Lic. Mabel De Dionigi Ostrovsky	Prof. Raquel Kielmanowicz
Lic. Marta S. Donoso Calumite	Lic. Héctor D. Klurfan
Dr. Elías Entebi	Lic. Ana Ma. Sánchez Arnau
Lic. Oscar J. Galfre	Lic. Estela Tarrab Sucari

Fco. Acuña de Fugeroa 1620 CAPITAL Informes: TE.: 84-6864

boutique del libro

9 de Julio 397 - TE.: 743-2608 - San Isidro
Alvear 260 - TE.: 798-9073 - Martínez
Arenales 2048 - TE.: 792-0430 - Martínez

Y AHORA
A PARTIR DEL 16/9/88

BOUTIQUE DEL LIBRO "UNISHOP"
EN UNICENTER

PANAMERICANA ENTRE PARANA Y EDISON

PARA PUBLICAR EN ESTA REVISTA
LLAMAR AL TELEFONO: 572-0322
O DIRIGIRSE A JULIAN ALVAREZ 239
CAPITAL FEDERAL.

Descripción del proceso terapéutico sistémico como un juego de varios niveles: la Descripción de Nivel (DN)

ENRIQUE ESCOT
LINO GUEVARA

Codirectores del Centro de Terapia Familiar del
Neuquén, Juan B. Justo 574, CP 8300,
Neuquén.

Trabajo presentado en Abril de 1986.

Cuando nos avocamos a la descripción de los procesos terapéuticos, nos encontramos con dos tipos de problemas. Por un lado, si establecemos un "diagnóstico" descriptivo, éste tiende a congelar el movimiento continuo en que se encuentra todo suceder terapéutico y no puede incorporar el cambio que es una característica esencial. Por otro lado las descripciones que son capaces de incluir esta variable de movilidad continua, si bien tienen, por una parte, la "fluidez" necesaria, también tienden a ser demasiado ambiguas y resultan en la práctica poco formalizables. El modelo que proponemos y que llamamos Descripción de Nivel (DN), intenta resolver estas dificultades.

La DN, es una construcción teórica definida a partir de un conjunto de supuestos (ver más adelante), que utiliza algunos elementos de la teoría de los juegos y la teoría de los grafos para representar al sistema terapéutico* formalizándolo como un Juego (game).

Se describen en primer lugar algunos elementos generales de la teoría de los grafos aplicada en la DN, a continuación se explicitan los supuestos en los que se basa esta descripción y finalmente se expone la DN en su dimensión clínica. Se describen cuatro niveles, denominados: "Negociación", "Conflicto", "Síntoma" y "Paciente Identificado", con un grafo que los representa.

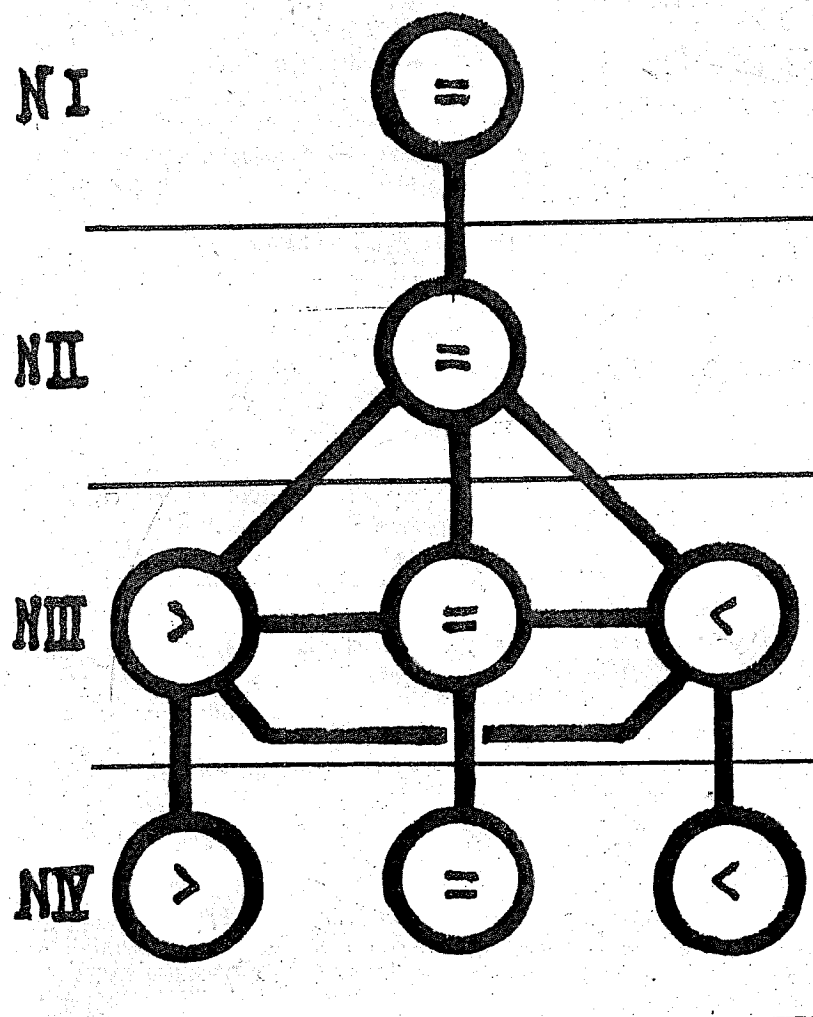
1) ELEMENTOS TEORICOS

Los grafos son uno de los modos utilizados para representar sucesos cambiantes. Un grafo es una colección de puntos llamados nodos, y de conexiones entre ellos llamados arcos que van de un nodo a otro (fig. 1).

El grafo que utilizamos para la representación de la DN corresponde a un juego de posiciones alternantes, donde cada nodo es una posición de este juego. En este caso cada nodo representa un estadio del sistema terapéutico. Cada estadio está

* El sistema terapéutico es un sistema compuesto por dos subsistemas: el subsistema de los consultantes (una persona, una familia o un grupo natural), y el subsistema del o de los terapeutas (el equipo terapéutico). El sistema terapéutico existe no sólo en los momentos en que se hallan reunidos ambos subsistemas durante la sesión, existe desde el comienzo de la terapia hasta el final de la misma.

FIGURA Nº 1



definido a partir de los supuestos que veremos más adelante. Los arcos son bidireccionales (ida y vuelta). Cuando atravesamos un arco vamos de un punto de un nodo a otro (del predecesor al sucesor). El grafo no tiene un punto de comienzo o un camino o un final preestablecido, y puede transitarse siguiendo los arcos (según lo indiquen los cambios observados por los terapeutas). Los nodos vecinos (potencialmente sucesores) y los arcos que los comunican con el punto actual, son las posibilidades o movimientos que ofrece el juego en ese momento. La sucesión de arcos y de nodos que se irán definiendo en el curso del tratamiento son una forma de representar la evolución del sistema terapéutico.

La hipótesis subyacente a la Descripción de Nivel es que un sistema (en este caso el sistema terapéutico), puede describirse funcionando con una serie de reglas generales que permiten categorizar diversos modos de funcionamiento. Estas reglas generales provienen del exterior del sistema (supra-sistémicas), de la sociedad, costumbres y cultura. Como estas mismas reglas se presentan en los diferentes sistemas (familias y pequeños grupos naturales), es posible la descripción de patterns de funcionamiento que tienen las mismas características. Está implícito en esto, que si cambian las reglas cambia el modo de funcionamiento del sistema, pasando a otro, en una sucesión de posibles modos de funcionamiento. Se pueden así establecer diferentes estados alternativos que son, en este contexto, situaciones predefinidas.

A partir de esta manera de describir es posible, como veremos, esquematizar la realidad terapéutica como un proceso. Este modo de representar el proceso tera-

péutico implica una conceptualización de la "enfermedad mental" como un proceso social basado en construcciones de la "realidad". La construcción es grupal pero las versiones que realizan los participantes del sistema terapéutico son consideradas, e incluidas en la versión que confecciona el terapeuta.

Nuestra propuesta está destinada a cumplir una utilidad práctica. La Descripción de Nivel es una aplicación de estos conceptos y su objetivo principal es el de ser un esquema orientador, una brújula diríamos, de la terapia. Por ello, su objetivo sobrepasa el de la mera descripción. Aunque apunta a la construcción de explicaciones y descripciones de la realidad terapéutica y familiar (hipótesis clínicas), también contribuye al diseño de intervenciones terapéuticas y a la "lectura" de la situación posterior (la respuesta a la intervención).

La descripción del proceso terapéutico en términos de la DN puede compararse con un juego de simulación, donde se representan los diferentes momentos o estados del juego, antes y después de cada cambio. De ese modo, se construyen versiones que describen los cambios del sistema terapéutico como cambios de posiciones dentro de un juego. Permite señalar, también, los posibles caminos por los cuales el juego puede continuar.

Podría objetarse que si la intención es la de describir movimientos que se dan en un proceso continuo (el proceso terapéutico), esto no puede lograrse con una descripción que ofrece una serie de estadios donde cada uno de ellos es una estructura estable y donde se da una discontinuidad entre ellos. Los nodos son en efecto estadios que se corresponden con descripciones estructurales del sistema terapéuti-

co. No obstante ello, pensamos que este modo de representación es válido en la medida que dimensiona a estos estadios en una serie, posible o real. Es decir que lo que transmite información sobre el cambio en el proceso no es tanto lo que acontece en cada estadio, sino el pasaje de uno a otro. Los arcos nos dan más información que los nodos, porque son una forma de señalar el camino de los sucesivos cambios.

Para poder definir el sistema terapéutico como un juego de varios niveles, es necesario primero establecer los supuestos en que nos apoyamos.

2) SUPUESTOS BASICOS DE LA DESCRIPCION DE NIVEL

Estos son:

a) Que toda interacción necesita de un contexto de significación al cual referirse. Esto implica encuadres (frames), que definen esa interacción, reglas, rótulos y valores, que remiten a un metanivel. No es posible describir conductas humanas sino se toma en cuenta a los significados implicados. Por lo tanto toda conducta o todo encuadre que permite la descripción de conductas, adquiere significado en relación a ese metanivel.

b) Toda conducta remite a una posible definición, que potencialmente o explícitamente, se hace de ella, y toda definición implica un predicción de conducta.

c) El metanivel, al que remite la significación de las conductas, se encuentra en los valores, mitos, normas, etc., pero también esta encarnado en personas que tienen la autoridad conferida de legitimar situaciones sociales. Legitimación está empleado en el sentido de Berger y Luck-

man (Construcción Social de la Realidad).

d) Todo grupo familiar tiende a equilibrar sus distintas versiones de la realidad, a partir de la definición de un contexto común. En ocasiones surgen desacuerdos en la familia (con respecto a cual es la "realidad" y cómo actuar en consecuencia). En ese caso el grupo necesita revisar las definiciones que comparte para lograr nuevos acuerdos.

e) Si estos acuerdos no se logran, la familia tratará de evitar las circunstancias que remiten a las diferencias. Si le es imposible evitarlas, entonces buscará arbitrajes, en el medio social determinado.

f) Si así tampoco la familia logra acuerdos, el sistema familiar se polarizará en dos subsistemas complementarios que tienen referencia a contextos significativos diferentes y por lo tanto sostendrán versiones de la realidad que son opuestas, pero que también son complementarias. Se establecen dos encuadres (frames) que aunque distintos entre sí, se incluyen uno a otro como elementos que forman parte de su versión. Queda implícito que ambos sistemas (o mejor subsistemas), siguen conservando ciertos acuerdos de base que les permitirán seguir juntos. Aún para no estar de acuerdo tiene que haber un mínimo acuerdo.

g) En términos generales, para sostener una visión del mundo, se necesita siempre una confirmación exterior. Supongamos ahora el caso de un grupo familiar, que está subdividido en posiciones antagónicas. Más que posiciones deberíamos hablar de dos construcciones de la realidad que son incompatibles una con respecto a la otra. Cada una pretende ser "la realidad tal cual es", y la otra sería sólo una "versión equivocada de los hechos". En esa situación, cada subsistema

"buscará" en las alianzas exteriores la confirmación de su versión. Al ingresar al campo nuevos participantes, el sistema se amplía y complejiza, dándose la posibilidad de nuevos equilibrios. Un sistema puede lograr estabilizarse en esta situación.

h) Cuando una de las versiones se "impone" sobre la otra, entonces pueden generarse cambios importantes en el funcionamiento del sistema. La versión de menos "fuerza" desaparece del nivel del intercambio significativo y da lugar a la aparición de un síntoma. Este conserva en su seno el sentido de la versión "perdedora", que no deja de existir, sino que sufre una doble transformación: por un lado, el significado queda limitado a su contenido icónico (por eso se lo puede considerar como si fuera una metáfora que expresa una versión de las circunstancias que no tiene ya cabida en el universo del intercambio), y por el otro lado, su manifestación se encuentra en el nivel de los hechos (existiendo como acción que genera cambios en la interacción).

i) El establecimiento de un síntoma se logra sobre la base de un nuevo tipo de acuerdo. El síntoma y su encuadre (frame), surgen del reservorio de situaciones predefinidas, que la familia toma de las que la cultura ofrece, para describir las conductas "problemáticas". En la medida que este nuevo acuerdo logrado pasa a primer plano y aliena la situación anterior, disminuye la tensión total del sistema, porque brinda un encuadre conocido y aceptable por todos, donde cada uno conoce lo que puede suceder.

j) Para estabilizarse aún más, el síntoma necesita de una legitimación a cargo de personas que cumplen con diversos roles socialmente establecidos. Entre las autori-

dades sociales que tienen la facultad de rotular y legitimar se encuentran los terapeutas. El tipo de rótulo es el de "Enfermo Mental" (paciente identificado).

El modo de relatar el proceso terapéutico que proponemos, la DN, es también una manera de describir un sistema que incluye expertos (el sistema terapéutico). Necesitamos considerar a estas función rotuladora y legitimadora como una presencia (real o potencial), que está participando constantemente en el proceso terapéutico. Ahora bien, para entender cada uno de los estadios de la DN, a los supuestos considerados antes hace falta agregar algunos parámetros.

1) La estructura jerárquica interna de la familia. Consideramos tres niveles jerárquicos. Un nivel donde las relaciones son horizontales. Es el nivel "intermedio", que corresponde generalmente a esposos entre sí, padres entre sí, o hermanos. Otro nivel "inferior", corresponde al de los hijos que dependen tanto materialmente como espiritualmente de sus padres o tutores. Y por último, el nivel "superior", que es ocupado generalmente por los abuelos o padres de la pareja, que si bien, por un lado, tienen una jerarquía "moral" sobre sus hijos y nietos, no obstante están con respecto a ellos en algún tipo de dependencia con el nivel "intermedio". La definición de los niveles jerárquicos es a veces complicada, ya que puede haber situaciones que no son fácilmente esquematizables.

2) La relación de la familia con su entorno, donde la función rotuladora es ejercida por roles y autoridades del medio social inmediato.

3) La relación terapéutica. Una dimen-

sión fundamental de esta relación es la capacidad legitimadora y rotuladora que tienen los terapeutas y que se ejerce más allá de su voluntad, porque está definida socialmente y no individualmente. Una de las formas más poderosas de ejercerla es a través del diagnóstico, explícito o implícito.

3) DESCRIPCION DE NIVEL

A partir de este conjunto de supuestos pueden definirse cuatro niveles. Cada uno de ellos se refiere a un modo de funcionamiento del sistema terapéutico, que se caracteriza por sus propias reglas. Esta modalidad descriptiva es una versión de la realidad que incluye a los terapeutas. La utilidad que tiene está en función de la posibilidad de pensar los sucesivos pasos del sistema terapéutico dentro de un esquema que permita tener una comprensión global del proceso.

El ordenamiento de los niveles de I a IV, no surge de su sucesión temporal, sino que depende de sus diferentes niveles de complejidad funcional. Los niveles son los siguientes:

NIVEL I: NEGOCIACION

NIVEL II: CONFLICTO

NIVEL III: SINTOMA

NIVEL IV: PACIENTE IDENTIFICADO

En el grafo, además cada nivel está compuesto por tres posiciones (estadios), que se corresponden con la manera en la que el sistema se manifiesta (especialmente los síntomas), según el nivel jerárquico familiar.

Estos términos (Negociación, Conflicto, Síntoma y Paciente Identificado), tie-

nen en el contexto de este trabajo un significado particular que será definido, y que no se corresponde exactamente con el uso corriente. Son sólo nombres del modo de funcionamiento del sistema terapéutico. Por ejemplo el término "Paciente Identificado", no se refiere a las vicisitudes por las que atraviesa una persona, sino que es la denominación del tipo de funcionamiento del sistema. Este incluye a toda la familia, a uno o más especialistas que participan en la rotulación, diagnóstico y tratamiento de "un enfermo mental", (éstos generalmente no están en las entrevistas), y además a un (o más) terapeuta familiar. A fin de diferenciar el particular uso de los términos, se los transcribe con mayúscula. En el caso de estar escritos con minúscula, corresponde la acepción corriente.

NIVEL I, NEGOCIACION

Es natural que muchas diferencias surjan en el curso de la vida familiar. Generalmente permanecen y se resuelvan dentro de la red familiar, o sea, dentro de la familia nuclear, de la familia ampliada, o con las personas próximas a la familia. En caso contrario, la familia puede acudir a otras instancias que le ofrece la cultura, entre las cuales la terapia es una de ellas.

El Nivel I, que llamamos Negociación, es el nombre de un estadio del sistema terapéutico con una familia que está en la búsqueda de acuerdos en el marco de una terapia, es decir, con un "tercero" que es el equipo terapéutico. Una terapia no es un contexto óptimo de autoridad como puede serlo la propia red natural. Esta situación implica que la familia no ha en-

contrado en su medio la autoridad o bien los valores competentes para posibilitar un marco que le provea suficiente seguridad y guía para el logro de los nuevos acuerdos necesarios para la estabilidad.

Las características de este nivel son: a) existe reconocimiento, de parte de todos los clientes, de la autoridad del terapeuta, b) no hay búsqueda de coaliciones con el terapeuta, de parte de ninguno de los miembros, c) no hay alianzas significativas con el mundo exterior que apoyen a uno de los integrantes más que a otro, d) existe en la familia el reconocimiento del tema que genera la diferencia. En otras palabras, el sistema tiene un bagaje suficiente de acuerdos establecidos previamente, que permiten que la diferencia sea especificada sin que se convierta en un elemento de desequilibrio. Estos acuerdos se encuentran tanto en el área de las propias relaciones internas del sistema familiar, como en la de sus relaciones con su red inmediata. El problema que caracteriza al Nivel I, y justifica la terapia, surge frente a situaciones de la vida que son cualitativamente nuevas, que exigen el establecimiento de nuevos acuerdos para establecer nuevas definiciones y nuevos valores que las sustenten. La familia busca en la terapia, después de no haberlo encontrado en su red, un oficiante que consagre con su autoridad reconocida, las situaciones nuevas o las decisiones importantes.

Situaciones que consideramos de Nivel Negociación, pueden darse como última etapa de la terapia, previas al alta.

Otras veces es una familia que, terminado su tratamiento, sigue concurriendo a realizar consultas frente a nuevos eventos (enfermedad, muerte, nacimiento, casamiento, etc.).

La terapia ha pasado a ser parte de la

red "natural". El Nivel I, que parece tan benigno, se puede convertir en un problema si se cronifica y pasa a ser parte de la red sustituta de una familia que no la establece en su medio natural.

Otro ejemplo sería el de familias desarraigadas por una migración que no encuentran en su cultura de origen los valores adecuados para comprender la nueva realidad de vida, y tampoco disponen todavía, en su nuevo medio, figuras que satisfagan esa función. En estos casos un terapeuta puede constituirse en la autoridad sustituta que oficiará legitimaciones. Otras veces la necesidad de acudir al terapeuta está determinada por una modificación de la familia extensa, como en el caso de la desaparición de una figura familiar que funcionaba como una autoridad respetada. Esta necesidad de la familia de un tercero para intervenir consagrando redefiniciones (reframing), buscando un "oficiante", no debe considerarse negativa, en sí misma, si es una situación transitoria que permitiría a la familia hacer pie para continuar su camino. No es deseable que la familia recurra a una terapia sin antes haber agotado sus propios recursos. Tampoco lo es que se instale definitivamente en esa posición de dependencia.

NIVEL II, CONFLICTO

Las personas se influyen mutuamente, equilibrando y desequilibrando sus relaciones. Los acuerdos entre sus miembros dan lugar a un tipo de estabilidad que está basada en los significados compartidos por los miembros. En el caso que cambien las circunstancias de la vida, puede suceder que la familia intente nuevos acuerdos, pe-

ro no pueda lograrlos, o que no sean suficientes. Entonces no conseguirá una estabilidad satisfactoria. Se polarizarán las diferencias y el sistema, entonces, buscará la estabilidad en alianzas con "terceros", y así arribará al Nivel II, Conflicto. Este Nivel puede ser la consecuencia de un Nivel I que no aportó el reencuadre acertado para enfrentar la situación.

En este Nivel las reglas de juego han cambiado y el sistema familiar se manifiesta como dos subsistemas que "buscan imponerse" recíprocamente su propia versión de la realidad. La estabilidad que se puede lograr, no está basada en el diálogo, sino en un equilibrio de las "fuerzas" que participan. Son las alianzas con terceros, las que juegan un rol fundamental en la cuestión. En este caso, alianza es el compartir la misma opinión sobre cual es la "realidad" o el estar colaborando en la construcción de la misma.

Llamamos Conflicto a un estado del sistema terapéutico que se caracteriza por una polarización del sistema consultante en posiciones antagónicas. Este antagonismo, aunque se muestre como una diferencia sobre un tema explicitable, es en realidad un enfrentamiento entre dos subsistemas.

Ambos subsistemas han intentado demostrar que tienen razón en la definición de la situación (frame), que su versión de la realidad es la que debe imperar, y ahora buscan alianzas fuera del sistema familiar para aumentar el poder de su opinión. Pero en este nivel no lograrán desequilibrio hacia una de las versiones. En la terapia inicialmente buscarán este objetivo. Hay casos en que la diferencia se focaliza en un tema, pero esto no es más que una forma en que se manifiesta el antagonismo. El objetivo no es la resolución de ese te-

ma explicitado.

Es de notar que aquí no hay un problema a resolver, si no dos, ateniéndose a la visión del mundo que tienen los participantes, ya que cada uno sostiene una diferente definición del problema. Tampoco puede hablarse de síntomas.

El terapeuta es una autoridad con capacidad de diagnosticar (por una definición social y no personal), es decir de redefinir (reframing) y legitimar situaciones familiares, y como tal es capaz de inclinar la balanza hacia uno de los polos. En este Nivel, la función reclamada al terapeuta es la de aliado y no la de asesor, como en el nivel anterior. Aquí, en la práctica, su autoridad es frágil, porque no depende de un reconocimiento intrínseco de la misma, sino que depende en gran medida del apoyo que cada participante cree poder recibir del terapeuta para confirmar su propia versión.

En ocasiones el terapeuta puede quedar atrapado en este nivel por haber pasado a ser parte de la trama. Su participación, aliado con una parte del sistema, equilibra a éste y su retiro del campo parece agravar la situación desbalanceando al sistema. En realidad se ha constituido momentáneamente en sostenedor del problema.

En otras ocasiones, el estado, el estado de Conflicto puede evolucionar positivamente hacia el Nivel I, Negociación. Este paso se reconoce porque vuelve posible trabajar sobre el tema del desacuerdo que anteriormente permanecía subyacente.

Si en cambio el sistema se desbalancea y una de las partes logra mayor "poder" sobre las otras, es decir una de las versiones logra una mayor vigencia por el apoyo externo, entonces el sistema evolucionará buscando un equilibrio en un nuevo

estadio, con la presencia de un sistema y arribará al Nivel III.

En este trabajo, llamamos conflicto sólo a las dificultades críticas que se dan en el mismo nivel de jerarquía familiar. En el caso de una madre que tiene discusiones con su hija menor, consideramos que lo que manifiesta ante nosotros la familia, es un síntoma en la hija, caracterizable por ejemplo, como "trastorno de conducta". Se ubicará el problema en un Nivel III, Síntoma, y no en un Nivel II, Conflicto. Si esta misma situación se da entre una hija adulta y su madre, como sus niveles jerárquicos se han acercado, definiremos el Nivel como Conflicto.

NIVEL III, SINTOMA

Este nivel de funcionamiento del sistema terapéutico es siempre la consecuencia de un estadio anterior. Es de suponer que el sistema familiar se encontraba en un nivel de Conflicto que evolucionó hacia un desequilibrio, debiendo recomponerse en su estabilidad con el desarrollo de un síntoma.

Es necesario volver a subrayar que los Niveles que describimos son descripciones que realizan los terapeutas de los estados del sistema terapéutico, del cual forman parte. Pero a veces utilizamos la DN para descubrir los hipotéticos pasos del sistema familiar antes de ingresar a la terapia. En el caso de una familia que consulta y se establece un sistema terapéutico en Nivel III, Síntoma, está implicado una hipotética evolución de la familia antes de entrar en terapia, donde suponemos estados previos de Negociación y Conflicto que fueron ineficientes para lograr un equilibrio. A pesar que podemos suponer estas eta-

pas previas, no las incluimos en la descripción de la DN, que en este caso concreto comenzaría en el Nivel Síntoma, porque la DN sólo debe contener los sucesivos estados del sistema terapéutico actual.

En este Nivel III, vuelven a cambiar las reglas de juego. Una de las definiciones propuestas por uno de los polos en conflicto se ha impuesto como "la" descripción de la realidad. El síntoma es su contraparte, que en un nivel lógico confirma la versión mientras que en otro se opone a ella. Un síntoma es una forma de participación en el sistema, una forma que ha perdido su referencia al contexto de significación y como consecuencia, no está en el universo de los intercambios verbales. Se manifiesta preponderantemente en el nivel de los hechos. Si bien podría decirse que el conflicto persiste, éste ya no es viable porque el síntoma está en otro plano de significación, no se halla en un mismo nivel lógico que las formulaciones verbales. La diferencia generadora del conflicto se halla entre dos niveles diferentes. Por un lado está la definición de la realidad imperante en el sistema, que es una rotulación del síntoma y su portador. Esto se da en el nivel de los significados que se pueden acordar. Pero el síntoma en sí, no contiene el componente de significado interaccional que existía en el nivel anterior. Existe, fundamentalmente, con un valor fáctico, que confirma el diagnóstico.

Por otro lado el síntoma es una "imagen" (no es una metáfora que tiene un valor simbólico, porque no es "como si"), que conserva una real capacidad de significar, pero que permanece oculta, latente en el nivel inconciente. Se encuentra en otro nivel lógico, nivel que no forma parte de los intercambios generadores de

acuerdos.

De esta manera la tensión en el sistema disminuye porque el grupo familiar toma de la cultura el encuadre (frame) de enfermedad, que se constituye en explicación suficiente de la conducta problemática.

El estadio de Síntoma implica que uno de sus miembros considerado como un sistema terapéutico que está en el Nivel III, =. En cambio en la misma familia el desarrollo de la sintomas en uno de los niños será considerado Nivel III, < ("menor", de menor nivel, jerarquía). O si desarrolla un síntoma la madre del esposo que convive con ellos (en una situación de dependencia afectiva), será considerado en la DN el Nivel III, >. Ver figura 1.

NIVEL IV, PACIENTE IDENTIFICADO

Si la estabilidad no se logra en el nivel anterior, el sistema nuevamente cambiará las reglas. Todo estadio de Paciente Identificado está precedido de un estadio de Síntoma, aunque muchas veces este paso sea muy rápido. Esquemáticamente podemos decir que, cuando en un estado de Síntoma el conflicto subyacente tiende a reactualizarse, la rotulación de la situación tiende a reforzarse. El estado de Paciente Identificado es el nombre de una situación del sistema terapéutico que incluye forzosamente a expertos que han sido convocados para reforzar la rotulación, mediante el diagnóstico de Enfermedad Mental. El centro de gravedad de la problemática en curso, pasa al exterior de la familia. En este nivel la familia ha logrado, o está en vías de lograr, la confirmación profesional del diagnóstico de Enfermedad Mental (Legitimación).

Notemos en el grafo cómo el nodo que

corresponda a este nivel tiene menos posibilidad de evolución alternativa (un sólo arco).

Lo que caracteriza la situación no es la "gravedad" de los síntomas, ni su aparatosis, ni siquiera la "clase psicopatológica" de los mismos, sino el funcionamiento del sistema. Es un sistema al cual para poder definirlo es necesario hacer un recorte que incluya, además de familia y terapeutas, al especialista rotulador (psiquiatra, psicoanalista, psicólogo, o terapeuta familiar), que convalida el diagnóstico. Lo importante no es la clase de diagnóstico que se ha establecido, sino la descalificación que implica para establecer versiones alternativas a esa versión "oficial" imperante en el sistema.

4. COMENTARIOS FINALES

La utilización sistemática de la DN en registros clínicos durante 1985 y 1986, (unos 1.000 casos en total; 600 en nuestra institución), nos permite hacer una primera evaluación sobre su valor clínico.

La construcción de la DN surgió de la confluencia de varios intereses clínicos.

En primer lugar estaba la conveniencia de sistematizar un conocimiento teórico del sistema terapéutico que fuera útil para su utilización en la clínica, la docencia y la investigación.

La necesidad de buscar una clasificación de intervenciones terapéuticas era para ello de primordial importancia. Muchas veces es necesario, durante una terapia, tener una idea global de las posibles jugadas alternativas que disponemos (aunque tal vez, sólo para olvidarlas acto seguido y recuperar la creatividad intuitiva). Pero no se dispone en la actualidad de una clasifi-

cación de intervenciones establecida sobre una base sistémica. Las clasificaciones existentes se basan sólo en algunos rasgos intrínsecos o superficiales de las intervenciones, y no tienen elementos en común a las cuales referirlas. Si queremos clasificar las intervenciones pensando sistémicamente, no podremos separarlas del sistema de las cuales ellas son parte. El valor de una clasificación de intervenciones estará en que nos permita resolver problemas del tipo: "dado un estado 1 del sistema, ¿cuál es la intervención que permitirá llegar con mayor probabilidad al estado 2?". Allí estamos relacionando las intervenciones con las hipótesis y los cambios posibles. Las respuestas que establecemos frente a este tipo de problemas es sobre todo intuitiva, adquirida con la experiencia, sin que sepamos explicar con claridad cuál es la razón para la elección de una u otra intervención. La DN con su descripción esquemática de los sucesivos "pasos" posibles del proceso, es una contribución para lograr establecer bases para esta clasificación sistémica de intervenciones.

Otra utilidad de la DN es la posibilidad que nos brinda de mejorar y simplificar los registros de nuestros casos. Las ventajas son: 1) La definición en pocas palabras de complejas situaciones clínicas para las que no teníamos nombres, 2) servir de modelo para registrar el proceso terapéutico, especialmente para realizar evaluaciones retrospectivas, 3) brindar un esquema guía para la construcción de hipótesis, su relación con otras hipótesis y un patrón para su registro.

En términos generales la DN nos resultó un conocimiento sistematizado útil para dar coherencia a toda la tarea clínica, docente y de investigación. Es esa clase de conocimiento que es necesario establecer,

para tenerlo como fondo más que como figura y para dejar de pensar en él, para pensarlo otra vez. Concebir el sistema terapéutico como un juego de varios niveles nos ayudó a tomar conciencia de que las intervenciones tienen que estar en relación con el Nivel en que la familia se encuentra en ese momento. La "misma" intervención en diferentes Niveles de la DN (prescripción del síntoma, por ejemplo), constituye una clase de intervención diferente y sus consecuencias también serán diferentes. Aprendimos a valorar y describir a familias que consultan y que no tienen síntomas (como en el Nivel I y II), o bien, que pueden no tener ni siquiera conflicto (Familia en el Nivel I), y que sin embargo para ellas la terapia es necesaria. Nos permitió diferenciar con mayor claridad el proceso terapéutico de una familia con un portador de síntoma de aquel con una familia con un paciente identificado.

Las limitaciones de esta DN son las de todos los esquemas y como tal debemos tomarla. Es parte de un proyecto que busca una mayor formalización teórica de nuestra práctica clínica. A pesar de que los objetivos propuestos al inicio no están totalmente logrados, sin embargo la DN en su estado actual es un pequeño paso en esa dirección, y un paso, como sabemos los terapeutas, puede ser el antecesor de muchos más.

RESUMEN

El artículo propone un modelo descriptivo del proceso terapéutico sistémico: la "Descripción de Nivel". Para ello, se utiliza algunos elementos de la teoría de los juegos y la teoría de los grafos.

Se describen cuatro niveles de funcio-

namiento del sistema terapéutico (familia + terapeutas). Estos niveles son denominados: "Negociación", "Conflicto", "Síntoma" y "Paciente Identificado", definiéndose las correspondientes acepciones. El modelo provee un esquema que enfatiza las condiciones de pasaje de uno a otro modo de funcionamiento, considerando a éstos, como momentos posibles del proceso terapéutico. Los modos de funcionamiento y sus cambios son representados en un grafo que tiene 10 arcos y 8 nodos.

A partir de los resultados de su utilización sistemática en la práctica clínica, son postulados las ventajas de la "Descripción de Nivel".

BIBLIOGRAFIA

- ANDOLFI, M.; ANGELO, C.; MENGHI, P.; NICOLÒ-CORIGLIANO, A.M., "Detrás de la Máscara Familiar: La Familia Rígida. Un modelo de Psicoterapia Relacional. Bs. As., 1985.
- APONTE, H.J., "The Negotiation of Values in Therapy", *Family Process*, 24: 323-338, 1985.
- BATESON, G., *Steps of an Ecology of Mind*, New York, Ballantine Books, 1972. (*Pasos Hacia una Ecología de la Mente*, Bs. As., Ed. Carlos Lohlé, 1972).
- BATESON, G., *Mind Nature: A Necessary Unity*, New York, Bantam Books, 1980. (*Espíritu y Naturaleza: Una Necesaria Unidad*), Bs. As., Amorrortu, 1980).
- BERGER, P., LUCKMANN, T., *La Construcción Social de la Realidad*, Bs. As., Amorrortu, 1968.
- BODEN, M.A., *Artificial Intelligence and Natural Man*, Brighton, The Harvest Press Ltd., 1977, (*Inteligencia Artificial y Hombre Natural*, Madrid, Tecnos S.A., 1984).
- CARL, D., JURCOVIC, G.J., "Agency Triangles: Problems in Agency-Family Relationships", *Family Process*, 22: 441-452, 1988.
- COLAPINTO, J., "Structural Family Therapy" en *Family Counseling and Therapy*, Horne, A.M. y Ohlsen, M.M., Itasca, Illinois, P.E. Peacock, 1982.

- COYNE, J.C., "Toward a Theory of Frames and Reframing: The Social Nature of Frames", *Journal of Marital and Family Therapy*, 11: N° 4, 337-344, 1985.
- HALEY, J., *Uncommon Therapy: The Psychiatric techniques of Milton Erickson, M.D.*, New York, Grune & Stratton, 1967. (*Terapia No Convencional: Las Técnicas de Milton Erickson*, Bs. As., Amorrortu, 1980).
- HALEY, J., *Leaving Home. The Therapy of Disturbed Young People*, New York, McGraw-Hill Book Co., 1980. (*Trastornos de la Emancipación Juvenil y Terapia Familiar*, Bs. As., Amorrortu ed., 1980).
- SCHANK, R.C., *The Cognitive Computer: On Language, Learning, and Artificial Intelligence*, Massachusetts, Addison-Wesley Pub. Comp. Inc., 1984.
- MINUCHIN, S. y FISHMAN, H.Ch., *Family Therapy Techniques*, New York, Harvard University Press, 1981. (*Técnicas de Terapia Familiar*, Bs. As., Paidós ed., 1984).
- MINUCHIN, S., *Family Kalidoscope*, Cambridge, Harvard University Press, 1984.
- SELVINI PALAZZOLI, M., BOSCOLO, L., CECCHIN, G. y PRATA, G., "The Problems of the Referring Person", *Journal of Marital and Family Therapy*, 6: 6-9, 1980.
- SELVINI PALAZZOLI, M., *Paradox and Counterparadox*, New York, Jason Aaronson, 1978.
- SCHWARTZMAN, J., (Eds.), *Family and Others Systems: The Macroscopic Context of Family Therapy*, New York, The Guilford Press, 1985.
- WINSTON, P., *Artificial Intelligence*, Reading, Massachusetts, Addison Wesley, 1984.

COMENTARIO AL ARTICULO:

"DESCRIPCION DEL PROCESO TERAPEUTICO SISTEMICO COMO UN JUEGO DE VARIOS NIVELES: LA DESCRIPCION DEL NIVEL (DN)", DE LOS DRES. ENRIQUE ESCOT Y LINO GUEVARA

LIC. RUTH DEL C. CASABIANCA

Directora del Instituto de la Familia y Terapias Breves. San Jerónimo 3011. (3000) Santa Fe.

No es tarea fácil para mí comentar un in-

tento serio y meticuloso de descripción y registro del proceso terapéutico, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque he contactado con la evolución de estas ideas en distintos momentos de su desarrollo. En segundo lugar, por mi interés particular en esta cuestión de formalizar registros del proceso terapéutico. La primera razón me acerca demasiado a las ideas de los autores, la segunda me amenaza con un exceso de crítica distante y perfeccionista.

De esta manera me siento en el lugar del terapeuta, que en la inter-relación con el paciente, necesita ir contactando con su mundo sin homogeneizarse con él ni tampoco diferenciarse excesivamente, para poder introducir diferencias en su versión. Pero al igual que en el proceso terapéutico, decido correr el riesgo...

Me gustaría comenzar destacando dos cuestiones metodológicas de este trabajo. La primera, referida a la coherencia lógica interna de las hipótesis descriptas conceptualmente como secuencias o estadios que se suceden en el tiempo, definidos por reglas de funcionamiento del Sistema Consultante y de la relación Consultante-Terapeuta. En esta elaboración de los autores, han confluído de un modo original conceptos de diversos Modelos de Terapia Familiar Sistémica, tales como: jerarquía, alianzas y coaliciones, niveles de significación de las conductas, tensión intrasistémica, y función delegada o esperada en el terapeuta, que configuran a la vez, una concepción de enfermedad mental en tanto construyen un modelo de lo que es la patología y con qué cualidades se presenta (tanto en el Sistema Consultante como en las relaciones con el terapeuta o equipo).

Al respecto, creo que convendría mo-

dificar el concepto referido a "sistema terapéutico" por el de "patterns posibles de la relación Consultante-Terapeuta" para cada nivel o estadio, en tanto si las reglas de funcionamiento operaran tal cual la descripción de los autores, corresponderían a situaciones de entrapamiento del terapeuta, que descalificarían per se la cualidad de "terapéutico" del sistema.

Dicho de otra manera, podríamos pensar los diferentes Niveles como estructuras en las que "tales reglas disfuncionales en el Sistema Consultante pueden disparar tales reglas disfuncionales en la relación Consultante-Terapeuta", en un ciclo recursivo donde la puntuación sería arbitraria. De esta forma, sería dable pensar que también "tales reglas disfuncionales en la relación Terapeuta-Consultante pueden disparar (o mantener) tales otras en el Sistema Consultante".

En segundo lugar —metodológicamente hablando— la instrumentación de un grafo como medio de representación visual del proceso desde las elaboraciones antedichas, tiene la virtud de simplificar una realidad compleja, haciéndola fácilmente accesible a la captación de las diferencias que definen ese proceso.

Desde un punto de vista meramente especulativo, esta descripción implica una serie de explicaciones referidas al sistema conceptual o metanivel de los autores que, no sólo les da coherencia, sino también *define* conductas de funcionamiento en cada punto del proceso, y a través de esto moldea las futuras... lo que obvia la pregunta siguiente: ¿Las familias (y en relación a ellas, los terapeutas) realmente (objetivamente) pasan por este juego alternante de estadios?

Pero más allá de las especulaciones, los terapeutas somos clínicos que nos encon-

tramos ante la tarea de responder y satisfacer demandas de alguien definido como "paciente", instrumentando nuestro arte y técnica psicoterapéuticos.

Desde este nivel de análisis, este modelo de Registro necesita ser, básicamente, una herramienta de trabajo que ayude al terapeuta a *ser terapéutico*, es decir a orientar sus acciones —y con ello las acciones del Consultante— hacia un fin u objetivo estipulado como solución, que desde este último consistirá en la desaparición o alivio de la o las situaciones traídas como problema, y desde el Terapeuta en la modificación (en el Sistema Consultante) o evitación (en el Sistema Terapéutico) de aquellas reglas de funcionamiento que caracterizan a los niveles o estadios descriptos siguiendo la sucesión hacia un supuesto "Nivel 0" (¿cuáles serán sus reglas?)... la "salud".

En este sentido, y a los fines clínicos, la Descripción de Nivel tal como está explicitada por los autores, es una grilla de lectura de la realidad terapéutica (como Modelo organizador de los datos desde el Terapeuta), que permite percibir ciertas cualidades de funcionamiento del Sistema Consultante en distintos momentos del proceso terapéutico, y los riesgos a que está expuesto el Terapeuta en cada uno de ellos.

Desde esta perspectiva clínica, el grafo es un instrumento útil en sus *nodos* a tres funciones simultáneas del terapeuta: *diagnóstico* del Sistema Consultante, *alerta* a la función demandada, y *orientador* de las intervenciones terapéuticas hacia un próximo Nivel de "menor grado de patología" donde dirigirse.

Los *arcos* —creo yo— servirían más a una función fundamentalmente de *super-*

visión, en tanto permitirían leer si los resultados de las intervenciones terapéuticas realizadas desde un Nivel o estadio, permitieron construir un sistema realmente terapéutico. Con esto quiero decir que la marcha de sucesivos puntos denotarían las modificaciones en las reglas de funcionamiento anteriores, implicando entonces que el equipo terapéutico ha podido zafar de las situaciones de entrapamiento o de las funciones a que lo tentaba el Sistema Consultante... de hecho, si no hay arcos contruidos, el Terapeuta jugó como el Consultante demandaba, y éste permanece en el mismo Nivel de patología.

Retomando las expresiones finales de los autores, me atrevo a pensar en un próximo paso de investigación: ¿cuáles serían las intervenciones que desde un determinado nivel de las relaciones Consultante-Terapeuta podrían ser terapéuticas?

Probablemente un sistema experto de computación nos las señalarían: "si está en el estadio tal, haciendo A ó B ó C conseguiría tal otro". Estas respuestas llenarían un buen manual técnico de "qué hacer desde dónde" en Terapia Sistémica, y entonces quizás ahí tendríamos que resignarnos a que:

a) Un manual de este tipo nunca puede enseñarnos cómo *in-formar* (dar forma) a las técnicas o tipos de intervenciones con imaginación, intuición o arte.

b) Necesitamos replantearnos si el arte terapéutico no califica a la técnica de manera tal que no puede soslayarse en un buen manual.

De todos modos, creo que en nuestro contexto socio-cultural donde se hace tanta terapia, un buen manual técnico sería —y este trabajo podría ser un capítulo— un interesante avance.



3er. CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE PSICOPATOLOGIA Y SALUD MENTAL

2do. SIMPOSIO SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

OBJETIVOS

27 al 30 de noviembre de 1988 ha sido la fecha elegida para realizar el nuevo encuentro propuesto por el III CONGRESO INTERINSTITUCIONAL DE PSICOPATOLOGIA Y SALUD MENTAL y II SIMPOSIO SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.

Han pasado tres años desde la última convocatoria y pensamos que ha llegado el momento propicio para detenernos un tiempo para reflexión, la comunicación y el encuentro.

La característica esencial de este Congreso fue la de posibilitar la reunión de todos aquellos trabajadores interesados en la Salud Mental que teniendo en común la experiencia de trabajar en Instituciones pudieran reunirse para intercambiar experiencias.

Psicoanálisis, Psiquiatría, Terapia Familiar, Enfoques Terapéuticos no tradicionales, Terapia ocupacional, Servicio Social, Temática Legal, tendrán cabida como enfoques múltiples que ocupan y preocupan a quien está abocado a la labor asistencial cotidiana.

El encuentro es propuesto por una Institución nueva que es el Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, inaugurado hace 5 años como División de un Hospital General y desde hace pocos meses ha sido elevado a rango de Hospital independiente, único en su característica en la Ciudad de Buenos Aires y está encontrando su espacio en el desarrollo de la atención de un aspecto específico como es la Emergencia Psiquiátrica.

Por otro lado, la convocatoria la realiza otra Institución que ha ido ganando lugar y prestigio en el mundo que es la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. 1982 y 1985, momentos de los anteriores Congresos, mostraban una actualidad distinta a 1988.

Los temas de Emergencia: Depresión y Prevención de la Violencia, Criterios de Atención, Teoría y Técnica en las Instituciones serán los temas centrales.

La propuesta está lanzada. El espacio será para todos.

Está Ud. invitado a participar.

ORGANIZA:

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIATRICAS
TORCUATO T. DE ALVEAR
SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA FAMILIAR

27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1988
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN
BUENOS AIRES

— DECLARADO DE INTERES MUNICIPAL —

INFORMES E INSCRIPCIONES:
SARMIENTO 1562, 4to. PISO E - (1042) BUENOS AIRES
TEL. 35-4437/6703

HOSPITAL ALVEAR: TEL. 51-0832/8985

Instituto de
Terapia y
Estudio de la
Familia

CURSO TEORICO - CLINICO

Formación de terapeutas familiares sistémicos
DURACION: 3 años.

ASISTENCIA DE FAMILIAS Y PAREJAS

DRA. RAQUEL R. DE ICIKSONAS
LIC. RAQUEL SALAMA DE MARCO DEL PONT
LIC. LILIA B. MERMIER DE RAED

Ayacucho 636 - PB - "A"
CORDOBA (5000)
TE.: 42-549

Ediciones
Nueva Visión



- PSICOTERAPIA BREVE DE ORIENTACION PSICOANALITICA
BRAIER, Eduardo
- PSICOTERAPIA DE GRUPO EN LA INFANCIA
SPEIER, Anny
- ANALISIS DE LA RELACION DE PAREJA
GONZALEZ, Alberto
- TEST DE LA PAREJA EN INTERACCION. TECNICAS
PROYECTIVAS GRUPALES
JURI, Luis
- ESTRATEGIAS EN PSICOTERAPIA GUESTALTICA.
PSICOTERAPIA DE GRUPOS, PAREJAS
ATIENZA, Marta
- SABER, PODER, QUEHACER Y DESEO
BAREMBLITT, Gregorio

Juegos psicóticos: ¿terapia o investigación?

CAROL ANDERSON

Profesora Asociada de Psiquiatría y Directora
de Family Studies and Social Work of Western
Psychiatric Institute and Clinic, University of
Pittsburgh, 3811 O'Hara Street, Pittsburgh
P.A. 152113

MARA SELVINI PALAZZOLI

Directora del Novo Centro per lo Studio della
Famiglia, Viale Vittorio Veneto 12,
20124 Milán.

VICENZO F. DI NICOLA

Departamento de Psiquiatría, Universidad de
Ottawa, Ontario, Canadá.

Artículo traducido de: *Terapia Familiar*, N°
25, Nov. 1987, traducido del *Journal of Marital
and Family Therapy*, Vol. 12, N° 4, 1986.

Traductora: María del Carmen De Lucía
Correctora: Paula Molinari

El debate suscitado a partir del artículo
de Mara Selvini sobre los juegos psicóticos
vuelve a poner en primer plano, junto a
los viejos temas, como el de la adecuación
del modelo y del método científico tradi-
cional, en el campo de las ciencias huma-
nas y la transmisibilidad de la experiencia
clínica en el seno de una comunidad cien-
tífica, otros, más específicamente ligados
a problemas aún sin resolver en el campo
de la terapia familiar, entre ellos el diag-
nóstico y el seguimiento.

Antes de introducirnos en la intrincada
red de interrogantes que estos temas susci-
tan, es quizás necesario presentar al lector
a la Dra. Anderson, o mejor aún su vincu-
lación con la esquizofrenia para favorecer
una mejor comprensión de los presupues-

tos desde donde surgen las críticas señala-
das al trabajo de Selvini.

"Psicoeducativo" es el término con el
cual Anderson y sus colegas definieron su
modelo operativo dirigido al tratamiento
de familias con un miembro esquizofrénico.
Este modelo ha sido utilizado en un
proyecto de investigación para evaluar su
eficacia en la continuidad del tratamiento
y en la prevención de las recaídas. Este
procedimiento que se articula en cuatro
fases, parte del presupuesto que las fami-
lias no causan la esquizofrenia, pero tienen
el poder de influenciar su desarrollo.

De aquí que se recogen informaciones
sobre la patología y sobre los comporta-
mientos que puedan favorecer una evolu-
ción positiva de la misma. La selección ini-
cial se efectúa en base al test de la "emo-
tividad expresada" (E.E.) en el cual una
tendencia excesiva a la crítica y a involu-
crarse son considerados como parámetros
significativos que van unidos a la posibi-
lidad de recaídas.

La investigación confronta cuatro mo-
dalidades diferentes de tratamiento, el gru-
po de control está constituido por pacien-
tes en terapia individual, con atención far-
macológica; un segundo grupo por pacien-
tes que, además de ser sometidos a trata-
miento farmacológico, son ayudados indi-
vidualmente a afrontar sus conflictos con
la familia y a desarrollar sus capacidades
con el objetivo de reinserirse en la socie-
dad; un tercer grupo recibe terapia fami-
liar, acompañada siempre con fármacos y
finalmente un cuarto grupo sigue todas
las fases previstas en el modelo: además
de fármacos, encuentros informativos so-
bre la patología en un contexto multifam-
liar, sesiones de terapia de familia y un
programa de inserción del paciente en la
comunidad, en el cual también participa

la familia.

Aunque sintéticamente, espero haber dado una idea del modo de abordaje de C. Anderson, basado fundamentalmente en la individuación y en el potenciamiento de los recursos de la familia y ausente de una lectura a partir de las resistencias y las manipulaciones: "Una respuesta negativa es considerada no como una resistencia sino como una indicación que marca un pasaje muy rápido a otra fase, o bien que la fase sucesiva aún es muy compleja". El panorama que emerge aparece sustancialmente diferente al presentado por Mara Selvini, que pone más el acento en los mecanismos de defensa, en las manipulaciones de la familia, en el control y en la superación de sus "juegos sucios".

Si no deseamos entrar en la polémica inútil mejor/peor, verdadero/falso, debemos decir que nos encontramos frente a dos modos diferentes de leer y por consiguiente, de intervenir sobre la misma realidad.

De aquí surgen los problemas más generales ¿Cómo es posible comunicar en el seno de una comunidad que posee el mismo objeto/sujeto de estudio y de intervención? ¿Es posible leer y evaluar las conclusiones obtenidas de la experiencia clínica de otro según los parámetros del modelo y del método científico tradicional, y por ende, según los parámetros de verificabilidad y reproducibilidad de la experiencia? ¿Cuál es el contexto del que se extraen estas conclusiones? ¿El contexto del descubrimiento, o el de la creación y de la construcción? ¿Nos estamos moviendo en el ámbito de una ciencia o en el ámbito de un conocimiento en el cual las teorías se refieren a procesos más bien que a eventos sustanciales, predecibles y cuantificables? ¿Tenemos que tratar con

hechos o con experimentos evaluables en términos de plausibilidad y coherencia?

Como ven ustedes la gama de interrogantes es amplia y comprometida. Quisiera agregar solamente algún elemento de reflexión, retomando algunos temas utilizados por los autores en sus críticas y en sus respuestas. Personalmente me ha impresionado la distinción entre terapeutas investigadores y terapeutas no investigadores que en este contexto permitiría reformular la distinción entre científico y no científico.

Creo que cada terapeuta es y debe ser inevitablemente un investigador. Investigador de una verdad, de una verdad narrativa, como subraya Spence. Su rol no es tanto el de descubrir, sino más bien el de contribuir a un proceso de búsqueda que lleve al paciente y a su familia a encontrar nexos que permitan ver nuevas posibilidades, devolviéndole así a cada individuo la dignidad de ser portador y creador de sentido. El objetivo de una metáfora, de una redefinición, de una interpretación, dependerá de cómo la familia les responde y de cuánto esto le permite percibir e integrar, de manera diferente, los datos de su historia y de sus relaciones, descubriendo y dando vida a nuevos significados. En este sentido Selvini nos señala que la metáfora del juego es útil para comprender los mecanismos de defensa de la familia y para comprometerla en una relación terapéutica. Es verdad que no nos dice cómo se articula su proceso de investigación con la familia. Pero esto quizás nos conduce al problema más general de cómo es posible comunicar una experiencia clínica y si es posible que una historia clínica se transforme en un "texto público" con el cual confrontarse para enriquecer el propio patrimonio cognoscitivo acerca de los proce-

esos evolutivos del individuo y de la familia, dando fundamento a una psicología relacional. Al respecto creo que la teoría familiar ha crecido lo suficiente para abandonar la etiqueta genérica de paradigma revolucionario y superar la genérica formulación que el comportamiento sintomático es parte de un juego relacional.

Quizás, sobre la base de la elaboración de la experiencia clínica, se puedan comenzar a formular los diagnósticos relacionales diferenciales (si es que de la diferencia nace la información) y mostrar cómo el trabajo con las familias puede ayudar a comprender cómo se forman y se transforman modelos y esquemas que guían al individuo en la construcción de una realidad relacional dotada de significado.

UN VIAJE MUY BREVE DESDE LA CONNOTACION POSITIVA A LA NEGATIVA

Carol M. Anderson

Cuando Al Gurman me preguntó si estaba interesada en exponerme y jugarle la cabeza, dudé en aceptar la oportunidad que se me ofrecía de criticar a uno de los líderes más originales y carismáticos de la terapia familiar. Los problemas que surgen del artículo de Mara Selvini son inquietantes. Cuando la escuché presentar su trabajo en el encuentro del AAMFT, me impresionó su encanto y su "presencia" pero me fastidió su modo de conducir estas familias. Pensé en el sufrimiento con el que las familias que yo había conocido trataban de afrontar sus problemas. ¿Qué habrían sentido si hubieran escuchado que se describían sus intentos desesperados como "juegos sucios"? ¿Cómo habrían

reaccionado al escuchar ser descriptos como "cómplices", capaces de utilizar "medios desleales; como engaños sutiles, engaños pesados, venganzas despiadadas, traiciones, manipulaciones, seducciones, promesas y trampas ambiguas"? ¿A dónde fueron a parar la connotación positiva y el mantenimiento de la neutralidad descriptas en los trabajos precedentes? No es necesario utilizar el "modelo de Milán" para saber que los conceptos de hipotetización, entrevista circular y connotación positiva son útiles.

Además estas precedentes técnicas parecían reflejar un genuino deseo de comprender a las familias, y al mismo tiempo, testimoniaban un respeto por sus necesidades y el compromiso de evitar cualquier condena. Este nuevo trabajo tiene un tono absolutamente distinto. Transmite una falta de respeto, a menudo muy difundida, en un ámbito que se declara guiado por una perspectiva sistémica "neutral" y al servicio del alivio de las disfunciones y sufrimientos. Aunque los términos usados provocan seguramente un cierto fastidio, el problema no es verdaderamente la utilización ni de estos términos, ni del modelo descrito por la Dra. Selvini, sino más bien el hecho que, en nuestro campo es necesario comenzar a examinar las comunicaciones de metanivel, de práctica y de procedimientos empleados.

Por ejemplo; recientemente he participado en un encuentro del National Institute of Mental Health en el que participaban parientes de pacientes crónicos y representantes de la National Alliance for the Mentally Ill. Su concepción de la relación terapéutica no es ciertamente atrayente. Los comentarios efectuados me hacían pensar en el impacto de ciertos procedimientos standard en el trabajo con

las familias, "coerción" para obtener el permiso para filmar en video y para la observación detrás del espejo, etiquetas peyorativas, objetivos establecidos unilateralmente, y en particular, intervenciones no claras, aunque sean muy ingeniosas.

¿Se trata de prácticas verdaderamente eficaces y, si lo son, son justificables si dejan a los otros miembros de la familia la impresión de estar alienados, atacados, censurados? ¿Contribuyen efectivamente a establecer una relación de colaboración con las personas que se dirigen a nosotros? ¿Cuál es el efecto de afirmaciones, como aquellas contenidas en este ensayo, de resultados asombrosos obtenidos con un nuevo método, cuando las pruebas que sostienen estas afirmaciones no son evidencias que surgen del trabajo referido? Afirmaciones no comprobadas pueden producir daño ya sea a los terapeutas como a las familias, que pueden experimentar su terapia como un fracaso personal si no logran obtener los mismos resultados. ¿Todo esto, no podría, en lugar de aliviar los sufrimientos, causar ulteriores problemas, suscitando esperanzas y expectativas irreales? ¿Por qué tomar una posición tan crítica al debatir este trabajo? ¿Después de todo, el campo de la terapia familiar está lleno de afirmaciones retóricas, redundantes y de presupuestos aún no argumentados? Existen pocas investigaciones serias y fundadas metodológicamente. Se discute poco sobre las ideas y sobre la práctica.

Existe una tendencia muy superficial a aceptar sin críticas las afirmaciones hechas con convicción por un líder. ¿Por qué Selvini tendría que ser diferente? Creo que las razones existen y son diversas. Ante todo este trabajo ha sido presentado como una investigación. Yo pienso que pue-

de representar el inicio de una nueva aproximación terapéutica a la familia, creativa y novedosa, pero, considerada desde el punto de vista de las reglas de la indagación científica, no es investigación, ni siquiera del género descriptivo.

Primeramente no se especifican algunos datos, al punto que no es posible conocer la población, las hipótesis, el tratamiento y los resultados. Y para evaluar la eficacia de una intervención es indispensable saber exactamente a quién está dirigida. Al respecto en el artículo de la Dra. M. Selvini no existe ninguna documentación, aunque queda claro que las personas tratadas no son un muestreo homogéneo, como requieren los criterios de una investigación. Si estos pacientes fueran "psicóticos" como afirma la autora (sin traer ninguna prueba de ello), esta etiqueta no nos permitiría definir a esta población como suficientemente homogénea para una investigación. Existe una amplia gama de fenómenos psicóticos: algunos transitorios y situacionales, otros crónicos, orgánicos y funcionales. Definir qué grupo se toma en consideración, no es un aspecto que haya que descuidar dado que algunas psicosis se resuelven sin intervención, mientras que otras resisten cualquier tratamiento.

Pero esto es sólo el comienzo. No existe ni siquiera una documentación detallada de la intervención, mientras se explicitan los presupuestos y las conclusiones sin pruebas que lo fundamenten. La autora afirma: "hemos empleado técnicas particulares para la conducción de la terapia, pero no podemos extendernos en detalles". ¿Por qué no?

El tiempo y el espacio pueden ser obstáculos para extenderse en explicaciones, pero no son un impedimento para presen-

tar los ejemplos que resultan indispensables. La presentación del método empleado no sólo es de extremo interés para el lector, sino también es indispensable para evaluar la intervención y hacer posible su reproducción.

De cualquier manera antes de abordar estos problemas, hubiera sido útil entender el pensamiento de la autora sobre los procesos fundamentales que se propone estudiar. La autora afirma "Hemos descubierto verificando una serie de hipótesis, los objetivos y las estrategias de los distintos actores. Era claro que cada miembro de la familia, como un jugador era parte del juego . . . Un aspecto muy importante del juego que se necesitaba individualizar era la secuencia temporal de los movimientos de los jugadores".

¿Qué hipótesis? No se explicitan nunca. ¿Qué estrategias eran interesantes y por qué eran importantes las secuencias? Tampoco esta información es proporcionada. Tomemos otra afirmación: "Estábamos firmemente convencidos que el comportamiento psicótico del paciente designado estaba ligado al juego específico que transcurría en el seno de la familia . . ." Pero ¿cuál es la naturaleza de esta ligazón?

¿Y dónde están las pruebas? Otra afirmación: "Se aclaró el juego familiar y las personas claves involucradas en el mismo". ¿Qué se aclaró? ¿Cómo son las personas claves involucradas? ¿Qué son efectivamente los "juegos sucios"?

Por otro lado aunque las descripciones del proceso permanezcan vagas, las afirmaciones de la Dra. Selvini sobre los resultados no son para nada modestas.

La introducción parece sugerir que el estudio se ha basado en el trabajo con ciento catorce familias, pero la descripción estadística se limita al uso inicial de la

prescripción invariante con diecinueve familias, de las cuales sólo diez aceptan y siguen la prescripción. Sobre la base de esta experiencia, la autora, concluye afirmando que la eficacia terapéutica de la prescripción ha sido "confirmada más allá de cualquier duda". Esta afirmación suena excesiva desde el momento que dos familias rechazaron la prescripción y fueron despedidas, cuatro familias se mostraron sólo en parte condescendientes, con pocos resultados, y tres afirmaron haber seguido las directivas, pero también en estos casos no completamente. Es particularmente ofensiva la conclusión extraída por la autora sobre este último punto: las últimas tres familias deben haber mentido porque no pudieron haber hecho tan poco como ellas sostenían. Usando esta lógica, ¿debemos concluir que algunas familias mienten cuando dicen haber seguido todo al pie de la letra?

Alguien ha afirmado alguna vez que un proyecto de investigación que no posee sólidas bases no vale nada. Es ciertamente verdad, pero no es éste el caso del trabajo de la Dra. Selvini. Sus ideas "no" son ciertamente banales. Justamente por este motivo, sus métodos merecen examinarse y verificarse rigurosamente. Esto no significa que el estudio explorativo de la Dra. Selvini debería seguir los criterios de la investigación experimental (o sea implicar pruebas de control clínicas).

No lo hace, pero ésta no es una crítica. Cualquier nuevo tratamiento, biológico, psicológico o también quirúrgico, se inicia con una investigación que incluye pruebas no controladas, es decir, con una investigación descriptiva.

En el campo de la salud mental, este tipo de indagación científica requiere la selección de un grupo homogéneo de pa-

cientes (anoréxicos, esquizofrénicos, depresivos), un intento de descripción exacta de una intervención específica y una evaluación detallada de su eficacia o ineffectividad. En este tipo de investigación, no existen reglas rigurosas que definan el número de sujetos, no es necesario un grupo de control ni tampoco un análisis estadístico de los datos. De hecho una investigación descriptiva concuerda particularmente bien con las necesidades actuales en el campo de la terapia familiar.

Permite el examen de una amplia gama de variables y de efectos sobre todos los miembros de la familia y sobre sus relaciones.

No hay necesidad de ser lineal o reduccionista.

La piedra fundamental de la investigación descriptiva es la *especificidad*. Se debe documentar detalladamente quiénes son los sujetos (incluyendo su historia, los diagnósticos y en el caso de una investigación sobre la familia, las características familiares relevantes), cómo han sido seleccionados, el tipo de intervención adoptada, los cambios producidos y finalmente sus efectos en el tiempo, son indispensables una observación y un informe clínico *detallado*, dado que este tipo de investigación es útil sobre todo si es considerada un paso importante y necesario hacia el desarrollo de ulteriores hipótesis y eventuales estudios de repetición. Las lagunas del trabajo de la Dra. Selvini en este área son evidentes. Resultan omitidos los aspectos más vitales de la descripción de cada una de las etapas de este proceso: medios específicos, hipótesis detalladas, pruebas que sostengan las conclusiones. Es inevitable, que en una presentación de una hora de duración, se sacrifiquen algunos detalles, pero sacrificar todo no es útil

ni para el lector interesado en la clínica ni para quienes desean verificar su trabajo.

En nuestro campo *debemos* plantearnos el problema de cuál podemos considerar sea una prueba aceptable de la eficacia de una intervención. Y cómo podemos obtenerla. Es vital que en el campo de la terapia familiar se estimule una consideración especial por la investigación y por los criterios de una indagación científica y un conocimiento de sus métodos fundamentales. Sin este conocimiento y este respeto, nuestra aproximación al tema no se desarrollará y no recibirá el sostén de las instituciones académicas y de los gobiernos, ni se le adjudicarán fondos para investigación.

Esto no significa que todos nosotros debamos *hacer* investigación, ni que sea necesario utilizar métodos empíricos que no reflejan un pensamiento sistémico. Significa, de todos modos, que todos nosotros debemos ser capaces de evaluar una investigación y atenernos a sus criterios. Debemos evaluarnos a nosotros mismos, a nuestros colegas y utilizar criterios rigurosos de investigación. De otro modo, no seremos diferentes a los psicoanalistas cuyos trabajos, en lugar de ser aceptados, han progresivamente perdido credibilidad. En una época en la cual el acento está puesto en la productividad del dinero y en la disminución de los recursos, si no logramos ofrecer pruebas de eficacia, aceptables para la comunidad científica, corremos el riesgo de desaparecer.

Otra razón de nuestras críticas reside en que la autora es una clínica de talento, que con sus colegas, ha enriquecido el campo de la terapia familiar con intervenciones creativas y útiles. De aquí que tenga una gran influencia en el modo en que la terapia familiar es conceptualizada,

practicada y enseñada. Probablemente lo que dice y hace la Dra. Selvini, está destinado a ser imitado, independientemente de que sea probada su eficacia. Por este motivo es particularmente importante que la Dra. Selvini y también otros que en nuestro campo pueden ser definidos como líderes eviten hacer afirmaciones y promesas infundadas. Todos nosotros podemos dejarnos llevar por esta tendencia, pero tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos y a las familias que nos debería llevar a ser más moderados en nuestras afirmaciones. Esto es especialmente válido en el caso de las familias que poseen miembros gravemente perturbados. Estas familias están dolorosamente conscientes del hecho que década tras década nosotros les hemos prometido mucho y hecho poco, que hemos hecho más cosas mal que bien, que hemos fallado en dar alivio y ofrecer soluciones. La Dra. Selvini tiene un largo currículum de nuevas contribuciones e importantes datos aportados a nuestro campo. Y probablemente seguirá teniendo una gran influencia sobre el comportamiento de los terapeutas aquí y en otras partes. No existe ninguna duda que su modo de pensar es intrigante, aunque en este caso particular no lo ha compartido con nosotros ofreciéndonos pocos datos para permitirnos una evaluación.

Dadas estas consideraciones, quizás es positivo que la descripción carezca de detalles necesarios para una reproducción. Las técnicas utilizadas podrían no ser útiles, o quizás dañosas, para las familias gravemente perturbadas si los clínicos trataran de imitarlas utilizando modalidades provocativas, conspirativas e irrespetuosas. En nuestras arduas tentativas de ayudar y/o curar familias perturbadas, debemos, al menos, estar atentos a no hacer daños.

Un colega, Sam Keith, jefe del sector que investiga la esquizofrenia en el National Institute of Mental Health, recientemente ha utilizado una analogía eficaz para comentar el proceso y los resultados de esta batalla. Recibiendo un mensaje de su comandante que le preguntaba "¿Cómo anda la batalla, Horacio?", éste último respondió "La batalla va bien, son las *tropas* las que sufren".

RESPUESTA A ANDERSON

Mara Selvini Palazzoli

Las críticas de Anderson a mi artículo parecen haber individualizado dos problemas fundamentales: la ética profesional y la metodología. Respecto de la primera, sus objeciones pueden resumirse a la orden de atenerse al viejo adagio: "primum non nocere" (primero no dañar).

Sobre este aspecto me complace estar en grado de tranquilizarla. Muchísimas cosas han cambiado desde los días de la "connotación positiva" pero una cosa que nunca se ha modificado es nuestro respeto por las familias. Sin embargo, lo que resultó más difícil fue lograr controlar un modelo tan íntimo y pleno de interacciones sin ofender a nadie, en particular a los padres. Difícil, pero no imposible. Podría decir que nuestro primer objetivo, como por otro lado el de todo terapeuta, es evitar (drop-outs) deserciones. Para nosotros es particularmente importante, dado que trabajamos en un Centro privado, donde las familias pagan de su propio bolsillo. Empujar a las familias a abandonar la terapia equivaldría liquidarnos a nosotros mismos.

Ahora pasemos a la metodología. An-

derson objeta que la población con quien hemos trabajado no ha sido suficientemente homogénea y, por lo tanto, inadecuada a los objetivos de la investigación.

Quisiéramos recordar que en el sistema psiquiátrico italiano nuestro Centro es considerado como el "último recurso" después que todos los otros han fracasado. Todos nuestros pacientes designados eran personas oficialmente diagnosticadas como psicóticos, tanto por médicos como por instituciones públicas y tratados rutinariamente con fármacos por años, sin resultados apreciables. Existía, de este modo, ya un diagnóstico y nosotros lo confirmamos.

Además debo subrayar que el diagnóstico de paciente psicótico no es adecuado en el caso en que esté comprometida la familia: esto significa que debemos tener criterios diagnósticos para la familia. Estos criterios claros y definidos aún no los tenemos, pero sabemos, a su vez, que un diagnóstico familiar adecuado es posible sólo a través de una hábil intervención terapéutica.

En lo que respecta a hipótesis e intervenciones, espero haber sido clara: la hipótesis es que el comportamiento psicótico del paciente está directamente ligado al modelo interaccional de la familia, y la intervención consiste en el uso, por primera vez en la historia de la investigación psiquiátrica, de una única prescripción invariante.

En relación a los comentarios críticos, me parece penosamente obvio que mi intervención en el encuentro del AAMFT, no hubiese transcurrido en un contexto que permitiese extenderme en detalles técnicos. Puedo haberme equivocado, pero como dije entonces, mi objetivo era pre-

sentar lo que consideraba el principal resultado de nuestra investigación, esto es, *el proceso de seis fases, como un modelo general de los juegos interactivos de la familia psicótica*.

Este modelo, que era el objetivo principal de mi intervención no apareció de la nada, ni era algo puramente teórico. Era el resultado de años de investigación. Me parecía que una descripción fase por fase de nuestro trabajo era clara. Comprendo perfectamente que es difícil captar exactamente cómo es nuestro modelo actualmente como resultado de nuestra investigación. He permanecido en silencio durante seis años, porque, si bien teníamos estas ideas en mente, todavía no teníamos claro el camino que estábamos transitando. Espero que el haber alcanzado el nivel actual, nos permita tomar un momento de respiro y describirlo, en un futuro próximo, apropiadamente y en detalle, utilizando nuestros videos, nuestro modo de trabajar y los resultados obtenidos.

Retornemos ahora a los problemas de una metodología correcta. Estoy convencida que el aspecto más importante relativo a este propósito ha sido el hecho que las familias, de las cuales hemos estudiado los juegos interactivos, nos han contratado para el tratamiento a través de una suerte de proceso auto-selectivo. Estas familias pueden ser definidas como "viscosas". Obviamente nosotros nunca hablamos de familias que rechazaban el tratamiento, esto es, de familias que "expulsaban" al paciente designado. ¿Estas familias juegan un tipo de juego diferente? No tenemos respuesta a esta pregunta. Existe otro aspecto que considero fundamental, o sea, aquel referido a las premisas epistemológicas en base a las cuales organizamos nuestro trabajo. No puedo ni siquiera

imaginar que alguien con alguna experiencia en nuestro campo pueda verdaderamente creer que un proyecto como el sostenido por Anderson, que se asemeja a un modelo bio-médico, se adecue a la tremenda complejidad de los fenómenos interactivos psicóticos, más aún porque la investigación inevitablemente está hecha por personas (o por computadoras programadas por personas) y nosotros sabemos bien que no se puede separar el observador como persona de sus observaciones. Esto se debe, además, al hecho que el observador no puede evitar tener en su mente una premisa fundamental. Es precisamente esta premisa la que se "unirá" con algún aspecto particular del problema que el investigador está estudiando. Partiendo de una premisa diferente, este aspecto particular del fenómeno no será significativo. He visto muchos ejemplos de esto y quizás el más apropiado es aquel que deriva de cuanto he observado en la supervisión de dos conocidos terapeutas familiares. Ambos eran psicólogos y habían trabajado por años en una institución de rehabilitación para niños discapacitados. El trabajo en esta institución, dirigida por un neurólogo, estaba basado en premisas bio-médicas y ambos psicólogos habían luchado como habían podido contra esa atmósfera totalitaria.

¿Qué he notado al efectuarles la supervisión detrás del espejo en su consultorio privado?

Cuando trabajaban con familias con un miembro psicótico, joven o adulto ambos demostraban ser observadores agudos e intuitivos, capaces de recoger los más sutiles indicios interactivos y de utilizarlos para formular hipótesis muy pertinentes. En cambio cuando trabajaban con familias con niños que "funcionaban" como retar-

dados mentales, parecían obtusos, sin intuición e imaginación. Retirándose de la sesión se preguntaban "¿Por qué ha sido derivada esta familia? El niño es un "caso orgánico", los padres no tienen nada de especial. Estamos frente a un niño 'irremediablemente retardado' ". Digo esto para demostrar que si un investigador buscara controlar nuestro modelo descriptivo partiendo de una premisa diferente, ignoraría todo aquello que está sucediendo en la familia en el nivel de las interacciones. Por lo tanto nuestra premisa inevitablemente es parte de aquello que nosotros observamos. Si para nuestra investigación acerca de los fenómenos psicóticos adoptamos una hipótesis interactiva, el comportamiento psicótico es simplemente una movida en un proceso de interacciones. Debemos identificarnos con ella, dejando de lado todo aquello que es ajeno a las interacciones. A menudo estamos tentados por toda una serie de datos que corresponden a otras puntuaciones, pero no debemos desviarnos. Debemos pues, atenernos fielmente a nuestra hipótesis, porque no contamos con otra cosa a la cual aferrarnos.

Esta es la primera regla fundamental en la investigación y éste es el modo con el cual nosotros nos defendemos de nuestro acérrimo enemigo, el eclecticismo, tan ampliamente difundido entre los terapeutas que no son investigadores.

Espero que nuestro modelo, aún con sus lagunas, abra un nuevo camino en nuestro campo, el referido a la investigación de familias que presentan miembros esquizofrénicos o psicóticos.

A menudo se tiene la impresión que los tiempos de Gregory Bateson y sus seguidores son sólo un glorioso recuerdo. La investigación en terapia familiar, que

pone el acento sobre una posible vinculación entre la organización relacional de la familia y el drama psicótico está claramente en quiebra respecto de la esquizofrenia. Considero esta tendencia muy grave y peligrosa. Desde mi punto de vista, sus consecuencias no sólo influirán en la terapia familiar y en la psiquiatría, sino también en las ciencias humanas en su totalidad. Está históricamente comprobado que muchas contribuciones al *Ecce Homo*, esto es, al conocimiento de cómo funcionan los seres humanos, han derivado del estudio del comportamiento disfuncional. En muchas familias transcurre una batalla campal y se manifiestan comportamientos particularmente violentos.

Consideremos, por ejemplo, los muchos niños que llegan golpeados hasta morir, cuyo número ha sido evaluado sólo recientemente. Pero existen interacciones íntimas, muy profundas, extremadamente poderosas que mantienen unidos a los miembros de una familia y condicionan su comportamiento. Y estas interacciones son cuidadosamente encubiertas y sus perniciosas consecuencias se deben precisamente a que están enmascaradas o negadas. Para un terapeuta investigador es extremadamente difícil penetrar en esta intrincada red de engaños y, si se recurre a los métodos tradicionales de conducción de la sesión, resulta absolutamente imposible. Estas modalidades pueden poner de manifiesto instrumentos muy eficaces con otro tipo de familias, pero no con las que nosotros estamos estudiando. Pueden también ser un excelente instrumento para quien posee otros objetivos en mente, pero no para este tipo de investigación. En lo que respecta finalmente a los juegos "sucios", honestamente vislumbro pocas pruebas de juegos "puros-puros" en lo

que está sucediendo cada día a nivel de la comunidad, de las naciones y de la sociedad en su conjunto.

AUN MAS SOBRE SELVINI

Vicenzo F. Di Nicola

Agradezco a C. Anderson por ser una de las primeras personas que explica con claridad una opinión contraria al trabajo de Selvini Palazzoli.

Las contribuciones del grupo de Milán han sido siempre recibidas con sentimientos contradictorios, aún cuando llegaban acompañadas de opiniones elogiosas. Paradoja y Contraparadoja¹⁰ fue recibida como una "hechicería" reconociéndose su poder pero, simultáneamente, se ponía en duda su origen. Una crítica abierta nos permitirá rever los problemas de un modo más articulado, en lugar de desenvolvernos en un plano puramente individual. Vivian Rakoff⁶ dirige una dura crítica al trabajo de Selvini Palazzoli, subrayando que aquel se basa especialmente en el modelo cibernético y en la metáfora del juego.

Aún cuando yo no esté de acuerdo con esta crítica, Rakoff ha sido más directa y puntual que Anderson, quien no ha logrado captar la metáfora central del nuevo método de Selvini, la referida al juego familiar. Tanto Anderson como Rakoff efectúan al trabajo de Selvini críticas acerca de la metodología.

Estas críticas plantean interrogantes que ninguna de las dos se hacen sobre la metodología de la investigación. Si el modo de pensar sistémico es un verdadero cambio en nuestra habitual forma de pensar los problemas relacionales, incluido

también el de la etiología (causalidad), ¿esta nueva metodología no requiere un nuevo método de verificación?

¿El método científico así como se aplica a las ciencias del comportamiento permite verificar las hipótesis sistémicas? Por ahora, parece que los métodos clínicos y las teorías de Selvini, están por encima de nuestra capacidad de verificación.

Anderson y Rakoff se lamentan por la falta de humanidad de este modelo considerado desde la perspectiva del trabajo clínico "este nuevo trabajo... transmite una falta de respeto por las familias", afirma Anderson. Rakoff, por su parte, observa "esta calculadora cibernética no sangra, no se sobresalta, no recuerda, no cede".

Dado que nunca he encontrado a las metáforas principales, derivados de la biología y de la física desde los tiempos de Freud, particularmente humanas y cálidas, las metáforas cibernéticas no me dejan ni frío, ni insensible. Los términos cibernéticos a menudo transmiten significados más precisos sobre el comportamiento humano. Debo recordar al lector que Norbert Wiener, que creó el término cibernética, escribió una famosa introducción al tema "The Humans Use of Human Beings?"¹¹

Piaget ha subrayado que de haber iniciado hoy sus investigaciones habría utilizado las metáforas provenientes de las ciencias de las computadoras, en lugar de las provenientes de la biología, para delinear su modelo de desarrollo cognitivo.

Maranhao,⁵ un antropólogo cultural, presenta interrogantes muy apropiados que individualizan los problemas en juego. Por ejemplo, se pregunta que ha sucedido con nuestros valores culturales: hace 30 años las comunicaciones ambiguas (los doble vínculos), eran conside-

rados como esquizofrenizantes (conceptos de los años '50 análogo a los "juegos sucios" de Selvini Palazzoli), mientras hoy los "vínculos positivos" de los años '80 son utilizados como prescripciones terapéuticas. ¿Qué nos sugiere todo esto en relación a la terapia familiar y a la moralidad de nuestra cultura? Maranhao considera que el resultado se volvió más significativo que el método.

El trabajo de Selvini Palazzoli siempre se ha centrado en la metáfora del juego familiar. Por ejemplo, en una reseña de su trabajo con familias anoréxicas Selvini Palazzoli⁸ se refiere a las movidas del juego familiar que llevan a construir el escenario anoréxico entre los miembros de la familia. También cuando expone su nuevo "método invariante", pone el acento⁹ en el juego familiar que aparece como el punto de apoyo en torno al cual se desarrolla el comportamiento psicótico. ¿Qué cosa quiere expresar con el término "juego" y qué problemas resuelve su utilización? Su definición de juego es "el tipo de organización relacional de una familia en la cual cada miembro ocupa una posición específica".⁸ Son varios los problemas que afronta: a) ofrece un lenguaje unificado para los intercambios relacionales, b) reúne muchos conceptos precedentes (reglas, rituales, mitos, alianzas, coaliciones), y c) ofrece definiciones significativas del individuo y del grupo familiar, tornando posible el diálogo entre terapeutas individuales y familiares. Aún planteando algunas propiedades formales de las movidas del juego familiar, Selvini Palazzoli, evita cuidadosamente definir los contenidos de los juegos específicos. Su nuevo método representa una seria utilización de la teoría para resolver problemas clínicos. Las objeciones pueden, en parte, deberse al acento con-

notativo del término "juego". Aún así lo que se ofrece es un constructo que permita organizar las informaciones en un nivel superior tornando a la teoría sistémica más específica en lo relativo a las propiedades formales de las interacciones de la familia, ofreciendo también nuevos instrumentos clínicos como por ejemplo, el método invariante. Se procura retornar a la eficacia conceptual presente en el pensamiento de Bateson sobre el doble vínculo.²

Anderson se admira que Selvini Palazzoli haya abandonado la connotación positiva transformándose en irrespetuosa respecto de las familias. No existe ninguna duda que este trabajo representa una evolución, no obstante, mantiene una coherencia con el de la connotación positiva. Como la interpretación de los sueños en Freud, la connotación positiva en Selvini es considerada un instrumento de indagación, no de modelo de problemas familiares. La propia autora sugiere esta analogía "La connotación positiva del comportamiento transactivo es... la llave maestra para entrar y ser libremente admitidos en el sistema".⁷ El paralelo con la famosa afirmación de Freud surge inmediatamente "La interpretación de los sueños es la vía regia para conocer la actividad inconciente de la mente".⁴ Mientras que en su trabajo precedente encontramos una serie de instrumentos para la conducción de la terapia y para hacer prescripciones, este último nos ofrece un modelo de las interacciones en la familia psicótica. En lo relativo a los "juegos sucios", este término señala un cambio en su actitud hacia el poder y las otras "fuerzas" no sistémicas en el trabajo con la familia. En los últimos tiempos, Selvini llega a ocuparse de los problemas de poder, tanto en la familia como en la terapia. En su discurso en

la Conferencia de la American Association for Marriage and Family Therapy de 1985, ha expresado su desacuerdo con Bateson, sobre este aspecto afirmando "El poder puede ser una ilusión, pero la batalla por el poder es un hecho". Selvini toma muy seriamente las consecuencias de los juegos familiares aún cuando recurre a conceptos como el de poder que contrasta con la teoría sistémica.

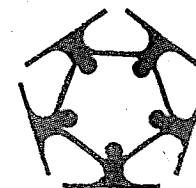
Para concluir deseo remarcar que el problema no se reduce sólo a las respuestas de la autora sobre su investigación, sino más bien a cuáles pueden ser los interrogantes científicos válidos. Mientras nos vamos con estas observaciones, Selvini nos provee, en vez, de algo más inmediato y más eficaz: un panorama, un mapa de los modelos, de los juegos familiares. "Hacia un modelo general de los juegos psicóticos familiares" es la propuesta teórica y clínica más ambiciosa de Selvini Palazzoli, que ofrece una metáfora fundamental y una clave de lectura de la variedad infinita de juegos interactivos en la familia.

En una ocasión ella misma la ha definido como "plano de la tierra de la esquizofrenia".

BIBLIOGRAFIA

1. ANDERSON, C.M., artículo tradotto.
2. BATESON, G. et. al., "Hacia una teoría de la esquizofrenia", en G. Bateson, *Pasos hacia una Ecología de la Mente*, Ed. Carlos Cohlé, Buenos Aires, México, 1976.
3. DI NICOLA, V.F., "Road map to Schizoland: Mara Selvini Palazzoli and the Milan model of systeme family therapy", in *Journal of Strategic and Systemic Therapies*, 3 (2), 50-62, 1984.
4. FREUD, S., *La interpretación de los sueños*, 1900.

5. MARANHAO, T., "Family therapy and anthropology" in *Culture, Medicine and Psychiatry*, 8, 255-279, 1984.
6. RAKOFF, V., "The necessity for multiple models in family therapy" in *Journal of Family Therapy*, 6, 199-210, 1984.
7. SELVINI PALAZZOLI, M., *L'anoressia mentale*, Milano, Feltrinelli, III ed., 1984.
8. SELVINI PALAZZOLI, M., "Anorexia nervosa: A syndrome of the affluent society" in *Transcultural Psychiatric Research Review*, 22 (3), 199-205, 1985.
9. SELVINI PALAZZOLI, M., "Toward a general model of psychotic family games", in *Journal of Marital and Family Therapy*, 12 (4), 339-349, 1986.
10. SELVINI PALAZZOLI, M., BOSCOLO, L., CECCHIN, G.F., PRATA, G., *Paradosso e Controparadosso*, Milano, Feltrinelli, 1975.
11. WIENER, N., *The Human use of human beings: Cybernetics and society*, New York, Doubleday, 1950.



INSTITUTO DE LA FAMILIA

Centro de Docencia, Investigación y Asistencia en Terapia Familiar
Director: Dr. Carlos María Díaz Usandivaras

CICLO 1988

CURSOS DE TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA

- A. Curso básico bianual para entrenamiento de terapeutas familiares.
- B. Curso básico bianual para asistentes sociales, abogados y funcionarios judiciales.
- C. Ciclo clínico en módulos temáticos mensuales.
- D. Grupos de supervisión médica.
- E. Cursos intensivos para profesionales no residentes en Buenos Aires.

ACASSUSO 907 - (1642) SAN ISIDRO - TEL. 743-8645 / 743-0797

YA APARECIO
EL PRIMER
NUMERO DE
PERSPECTIVAS
SISTEMICAS

Perspectivas Sistemicas

OPCIONES PARA EL CAMBIO
AÑO 1 • No. 1 • JUNIO/JULIO 1988 • A 10 -

AVENIDA
SANTA FE 3480
AVENIDA
SCALABRINI ORTIZ 2469
TELEFONO: 71-6218
BUENOS AIRES

¿La libertad es terapéutica?

Indocente y peligrosa / 10
ENTREVISTA

De ayer a hoy:
nada important

Cómo cercar un territo
en el ca

Breve
del matrimonio R

Un sistema cor
Hitler, art



EL SEGUNDO
NUMERO
APARECE EN
AGOSTO

CONSIGALA
EN KIOSKOS
Y LIBRERIAS

S. Baringoltz / P. Herscovici / H. Hirsch
S. Moreno / M.R. de Moyano / M.
Rodríguez Ceb / A. Vázquez

¿Las manzanas de Schiller?

ESTRELLA JOSELEVICH

Psicóloga. Aráoz 1978. (1425) Buenos Aires,
Argentina.

¿Predecir posibles direcciones de cambio en un proceso terapéutico? ¡No! concluye en su excelente presentación acerca de los Fundamentos de la Terapia Familiar, L. Hoffman (1981). Es difícil, improbable, ¡arriesgado! Por la sencilla razón que ignoramos más de lo que sabemos. Los sistemas vivientes son de tal complejidad que superan la visión que tenemos de ellos. Las familias son siempre más ricas que nuestra imaginación. La infinidad de variables se vuelve inmanejable. No se puede saber hacia dónde reestructurará un sistema, ¡el azar es rey! Es imposible saber qué oscilación amplificará. Las familias poseen singularidades que no podemos abarcar. Y podríamos seguir desarrollando argumentos a favor de la impredecibilidad básica de las líneas posibles de cambio desencadenadas a partir de un proceso terapéutico.

Pero, ¡ah! la irreverencia! Trataremos de fundamentar lo contrario. Desde lo modesto que necesariamente conlleva este tipo de actitud clínica, los motivos que

me llevan a intentarlo son dos: la falta de suficientes textos al respecto, y por el otro lado la constatación de que el ejercicio predictivo es usado por diferentes grupos de terapeutas, varios de los cuales son notables maestros en esta área. Me preocupa además una actitud ética de responsabilidad por nuestro accionar en el campo de la salud mental y sus resultados y, básicamente, en el enorme respeto y admiración por la aparición de lo nuevo, de lo improbable, de lo imprevisible. Allí es donde aprendemos.

La manera genial de trabajar de M. Erickson que incluye el predecir, pasando por un mucho más explícito, analítico y paciente desglosador de procesos terapéuticos e intervenciones como J. Haley, deteniéndose a ver las terapias breves estilo MRI en la claridad diáfana de muchas de sus formulaciones, o llegando del otro lado del mar hasta una Mara Selvini, encontramos anticipación. Observamos allí dos tendencias, una la encontramos buscando en los materiales clínicos, cual si sacáramos perlas del fondo del oscuro del mar, o sólo mirando, como si brillasen relucientes luces que claramente nos dicen: "mi discurso es éste". En este segundo caso las encontramos formuladas en las palabras del terapeuta, en lo que constituye un modelo explícito. En el primer caso, en cambio, el ejercicio de anticipación resulta borrosamente legible en el discurso. Es decir, funciona organizado en un modelo mental que queda implícito.

Entre aquellos que se oponen a la predictibilidad de las líneas de cambio* podríamos citar a un físico de la talla de I.

* Anticipación y predicción serán usadas como sinónimos en este artículo.

Prigogine quien afirma que es imposible saber hacia dónde reestructurará un sistema en equilibrio inestable, al cambiar. El azar interviene allí. No podemos predecir la línea del cambio. En terapia sistémica esta postura es compartida por diferentes terapeutas como por ejemplo M. Elkaim.

Dice Elkaim que la estructura se transformará de acuerdo a sus propias leyes, leyes que el terapeuta no puede adivinar ya que son parte de la singularidad de la familia. Sin embargo, hay algunos aspectos (leyes, valores, creencias, interrelaciones), de la familia que los terapeutas podemos recortar - conocer. Luego, no necesitamos sólo "adivinar". Mas bien quisiéramos plantear este proceso de movimiento entre familia/paciente y terapeuta como un andar con mutuos ajustes, reconocimientos y conocimientos.

También dice Prigogine en otro momento: "Muchas veces no podemos predecir lo que va a ocurrir, sólo ciertas correlaciones; no podemos describir las realidades individuales, sino cierto comportamiento global" (1985). Aquí está agregando ya una idea diferente. Dentro de un proceso terapéutico, con nuestra acción terapéutica facilitamos que el sistema se aleje del equilibrio y que alguna oscilación amplifique. Si bien en la vida existen cambios que se producen por ampliaciones de la desviación en forma azarosa, en la práctica clínica nunca sucede sólo al azar. El sistema pasa más allá de sus propios límites. Prigogine analiza particularmente la importancia del azar en la determinación de cuál es la inestabilidad que amplificará en un proceso de cambio irreversible, "casi mágico". Sin embargo, y muy acotadamente, en un proceso terapéutico mantenemos una actitud determinada e introducimos alguna intervención,

y ésta tiene que ver con la fluctuación que amplificará. Dicho en otras palabras, la intervención tiene que ver con la línea de cambio que aparezca. Y la intervención no es azar, es intervención. Claro que a su vez es también densa y no todas sus variables son claramente dilucidadas en el momento por el propio terapeuta. De modo que aquí, ¡otra dificultad! Subrayamos: El ejercicio predictivo es complejo, limitado. . . e indispensable. Otorga fecundidad al trabajo terapéutico. El ejercicio de anticipación facilita elementos para la toma de decisión del camino terapéutico. Nuestra tesis es que no sólo es posible hacer anticipaciones acerca de los posibles movimientos de un sistema, sino que de hecho lo hacemos. Lo hacemos en forma acotada y con peso o fuerza débil, en términos de clases de conducta —y no de conducta específica*.

¿PODEMOS FUNDAMENTAR ESTO METODOLOGICAMENTE?

Conocemos ciertos aspectos y leyes generales de los fenómenos de cambio de los sistemas vivientes. Sin embargo, en nuestra tarea clínica no nos alcanzan. Debemos, aquí, agregar otras ideas. Así como O. Varsavsky (1982), se refiere a que los modelos de trabajo en ciencias sociales pueden ser específicos, tal vez nosotros podamos pedir prestado ese concepto y asumir que es válido y útil trabajar con modelos específicos. El avance del saber puede ser lento, pausado, o dar grandes

* Este y otros conceptos ya fueron desarrollados en un trabajo anterior con Hugo Hirsch: "El uso de predicciones en terapia familiar".

saltos cualitativos gracias a los descubrimientos de algún investigador genial, como fueron en nuestro campo S. Freud, G. Bateson, M. Erickson. Hasta que lleguemos a ser geniales proponemos conformarnos con el saber paciente y curioso.

Desde el punto de vista metodológico podemos hablar de predicciones fuertes y/o predicciones débiles, como claramente lo explica Schuster (1982). En este artículo vamos a hablar de predicción en el sentido de *predicción débil*.

La estructura lógica que presentan ambas se mantiene semejante, pero en la anticipación blanda se debilita la conexión lógica general. La probabilidad de ocurrencia disminuye, se pierde el sentido pesado. Las afirmaciones y enunciados se conectan de modo inferencial. No conforman una conexión deductiva, que es más sólida.

Hay enunciados con fuerza legal que por inducción confieren confiabilidad a lo que se anticipa. Entendemos por deducir: sacar consecuencias de un principio, proporción o supuesto. Inferir, por su lado, se refiere a sacar consecuencias de una cosa. Esto puede expresarse mediante un enunciado que sugiere algún tipo de modificación en las clases de conductas futuras.

Podemos relacionar esto al concepto de modelo específico tal como fué explicado por O. Varsavsky. Si pretendemos una respuesta de predictibilidad fuerte, llamada "dura", no creo que podamos predecir. Si pretendemos una respuesta de predictibilidad débil, con carácter inductivo* inferencial y de bajo peso, en cam-

bio podemos predecir, —y de hecho lo hacemos en la práctica clínica. Trabajamos con hipótesis parcialmente corroboradas que no alcanzan nivel de leyes generales.

Trabajamos con "Información Mínima Necesaria y Suficiente" para el tratamiento de una disfunción, sin intentar aprehender la totalidad de las variables del sistema.

La predicción tiene un carácter "blando" ya que explícitamente eludimos todo esfuerzo de computar el máximo de variables y fenómenos para nuestra predicción, la que se apoya sólo sobre aquellos datos que decidimos tiene relación con el problema en cuestión y tienen una vigencia limitada en el tiempo.

Cuando hago una predicción puede que sea validada por los hechos observados posteriormente. Esto no excluye que también exista la posibilidad — ¡frecuente! — de que una situación ofrezca una refutación a la anticipación. Esta refutación, en tanto información novedosa permite el desarrollo de estrategias alternativas dirigidas al cambio. Al decir de Popper, aprendemos de nuestros errores.

La riqueza de la posible refutación de la anticipación por el error facilita el reelaborar estrategias y la nueva anticipación, tomando en cuenta la información agregada.

menos, hechos o casos, a la ley o principio que virtualmente los contiene o que se afecta en todos ellos uniformemente.

Dedución: Lóg.: Método por el cual se procede lógicamente a lo particular.

Deducir: Sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto.

Inferir: Sacar consecuencia de una cosa.

* Inducir: Filos.: Ascender lógicamente al entendimiento desde el conocimiento de los fenó-

UNA MIRADA A LO PREVISIBLE Y LO AZAROSO EN LA CIENCIA Y EN OTRAS DISCIPLINAS

En el desarrollo de estos argumentos nos damos cuenta que estaremos transitando con libertad inusitada desde un dominio científico, desde una disciplina, a otros, lo cual implica usar ideas o metáforas tal vez con exceso de despreocupación y riesgo. Quisiéramos subrayar que nos damos este lujo para usar este artículo como un gran borrador donde dibujar a mano alzada un diseño de caminos del pensamiento.

En rigor, ¿qué es esto del azar? A pesar de sus propias opiniones en otros momentos más enfáticos, dice el propio Prigogine (1985): "Sobre la cuestión ¿qué es el azar?, es decir, desde el punto de vista de la definición, diré que no lo sé. No tengo definición".

Sin embargo, mucho se ha dicho. Existen dos grandes conceptos diferenciados y que implican dos posturas ideológicas diferentes: el azar ontológico, "intrínseco" de la naturaleza, y el azar relacionado con nuestra ignorancia.

Esto último liga los sucesos azarosos a la falta de información del observador-terapeuta. Esta falta de información, ¿se debe a nuestros escasos recursos para llegar a conocer mejor los datos en la teoría que manejamos? ¿o a que nuestra teoría aún no puede dar cuenta de dichos hechos? ¿o a que la teoría que utilizamos es aquí inadmisibles o inconsistente? ¿o a que no contamos con instrumentos de lectura "adecuados" a nuestra visión? Porque en todas estas situaciones, falta de información es sinónimo de ignorancia.

En defensa de la postura del azar relacionado con nuestra ignorancia, G. Lud-

wig (1985) insiste: "Pero 'accidente' o 'azar' no es un concepto científico". Y propone, con bastante humor, cambiarlo por "acción de un fantasma".

Volviendo a la diferenciación entre azar ontológico y azar de la ignorancia, esto se toca, y de cerca, con la posición constructivista y los conceptos de la cibernética de 2º orden tan en boga hoy en día entre los terapeutas sistémicos.

Ahora bien, ¿dónde entra el azar en la terapia propiamente dicha? Estamos hablando de conceptos de aleatoriedad relativa, donde una clase de hechos puede ser más o menos azarosa que otra en un futuro cercano.

Se trata de establecer ligaduras entre un momento determinado en el campo terapéutico y alguna de las evoluciones virtuales, posibles de anticipar. De ninguna manera estamos hablando de que esta clase de actitud clínica lleve a una unicidad de soluciones posibles. Más aún, conviene diferenciar las evoluciones virtuales para nosotros más cercanas a lo posible, del resto de la inmensidad de las evoluciones virtuales.

Lo que hacemos solamente es eliminar en nuestro pensamiento alguna de las evoluciones virtuales. Y esto ya es una expresión de determinismo.

Es decir que, dentro del conjunto terapeuta-familia, desde el costado del terapeuta, algo de lo que él va haciendo disminuye o restringe la evolución virtual "espontánea" del sistema. Las intervenciones clínicas pueden facilitar aperturas al cambio y simultáneamente son restrictivas. Esto lo desarrollamos más adelante.

También es cierto que la estructura de la predicción en un sistema viviente que conforma una máquina no trivial se rompe porque se trata de un fenómeno o pro-

ceso disipativo, de dinámica expansiva. Aquí el ejercicio anticipatorio se vuelve más difícil.

Parte de nuestra renuncia a predecir se debe a que nos manejamos con una acumulación de información. Afortunadamente para nosotros, terapeutas sistémicos, esta es mucho más acotada y específica en una comparación general con algunos otros marcos referenciales terapéuticos, como por ejemplo el psicoanálisis. Salvo excepciones, como sucede en ciertas situaciones de terapia focalizada (Winnicott, 1971, Balint, 1971, Fiorini, 1973).

La acumulación excesiva de información dificulta la descripción, impide conservar un registro preciso, el operador no entiende los datos y, claro está, renuncia a diseñar cualquier ruta. "El sistema se nos muestra con una confusión extraordinaria que solemos calificar de indeterminación o de caótica" dice Margalef (1985). Y continúa: "También me pregunto si el indeterminismo no será la propia desesperación que nos embarga cuando entender o explicar la complicación requiere una información a la que no accedemos". Nos muestra cómo, en biología, el dominio científico en que "nosotros analizamos nuestros datos es limitado y pequeño". Siempre queda algo indeterminado dentro de este universo explorable, pero que sí es explicable desde afuera. Aquí entonces estaríamos ante un indeterminismo aparente, de un azar por ignorancia.

Paralelamente, se pregunta Margalef: "... si el determinismo no será una abstracción y una simplificación (por lo demás muy humana), que practiquemos para hacer inteligible la complejidad cotidiana y actuar con ella. ... Es cierto que el científico tiene una posición determinista a

efectos prácticos, pero, precisamente debido a que su propia investigación va desplazándolos, el científico también es consciente de aceptar una y otra vez el indeterminismo efectivo". Situaciones semejantes se nos plantean en algunos aspectos de nuestra actitud clínica.

Avancemos un paso. Salta a la luz una conocida diferencia para nosotros: la discriminación de Proceso y Pattern en los sistemas naturales vivientes.

El proceso implica alto dinamismo y alta energía, movimientos de organización y regulación. En el pattern, por el contrario, se trata de mantener la organización o información con un mínimo cambio relativo de energía. Se trata de mantener la regulación y el equilibrio. Hay menos energía libre para el cambio. Hay más repetición.

Por las características de los sistemas vivientes en un estado de crisis propiamente dicho podemos hablar de elevado dinamismo o estructuras disipativas. Estamos aquí haciendo referencia a los procesos, no a las configuraciones establecidas en patterns. Cuando hay un pattern más organizado, podemos hablar de dinamismo amortiguado, y de información —pattern— de exagerada complicación en el detalle.

¿Estaríamos aquí ante el azar "domesticado" hasta cierto punto, como postulan expertos desde la física cuántica?

Muchas de las consultas que habitualmente recibimos caben en esta última categoría. Y esto, nuevamente, nos acerca a una idea del sistema viviente en una consulta como una máquina parcialmente trivializada.

La aplicación de estos conceptos del campo de la biología al revisar un sistema y sus procesos desde el punto de vista de

lo psicológico, será válido siempre y cuando aceptemos ciertos isomorfismos entre ambas unidades de análisis.

Es obvio para nosotros que las familias, en un período de tiempo dado, no cambian totalmente, sino que mantienen ciertos aspectos en equilibrio. Habría partes del sistema en no-equilibrio (proceso) y otras partes en equilibrio (pattern).

Con lo cual el ejercicio anticipatorio se nos complica más aún. ¿Cómo hacer para discriminar qué cambiará y qué no? Y si realizamos ciertas intervenciones, ¿cómo sabemos qué tocarán? ¿Cómo proteger aquello que no debemos tocar ya que configura un pattern adecuado para el funcionamiento de la familia, o un proceso con espontánea evolución satisfactoria?

¿QUE PASA EN OTROS CAMPOS?

Desde la metodología y la postura de los economistas cuando analizan macrosistemas en situaciones de "alta turbulencia", por ejemplo, nosotros podemos aprender cómo consideran ellos el ingreso de variables móviles, imprevistas. Y aún allí podemos descubrir que si bien son procesos inestables no evolucionan por puro azar.

En este sentido creo que tales modelos de pensamiento y trabajo son más útiles para nosotros que los de los meteorólogos. Ellos también tratan con su objeto de estudio inestable, pero poseen instrumentos y técnicas para mediciones de las que nosotros carecemos. Y si bien el clima, como objeto de estudio, es altamente cambiante y sin configuraciones estáticas, la utilización de aparatos computados para medir y evaluar las variables en juego, determinan una situación significativamente diferente a los que nos movemos con fa-

milias y donde nosotros mismos somos nuestro propio instrumento-operador.

Es interesante tener bien presente la metodología de trabajo que utilizan en el área empresarial los expertos en construcción de escenarios alternativos. Se utiliza para el proceso de toma de decisiones en evaluación y planificación de productividad. En base a la creación de todos los escenarios posibles, se anticipa la posibilidad de venta de un producto específico. En relación con variables endógenas y exógenas se estudian todas las posibilidades de la siguiente manera: "¿Qué puede pasar si se mueve esta variable en tal o cual dirección?". Se ensayan los diferentes escenarios imaginables alternando las diferentes variables.

Obviamente la calidad y cantidad de escenarios posibles es enorme. A partir de allí se subrayan los más probables de acuerdo a los escenarios más factibles de acontecer. Se puede hacer una gradación desde los más posibles hasta los más improbables. Obviamente, al decir de E. Morin, "lo realmente importante en la investigación es lo imprevisible. Hay que saber en todo momento adaptarse a ello. . ." (Prólogo a Science de la Vie et Société. La Documentation Française, 1979). Obsérvese la similitud entre este planteo que deben hacerse los empresarios y los terapeutas.

¡ALERTA A LOS TRASPIES!

Sabemos que el estudio de las condiciones iniciales es fundamental para evaluar una dirección de posible cambio y, más aún, que esto debe hacerse con un claro modelo teórico y utilizando un potente ordenador. Esto puede contribuir a disminuir el error. Sólo que eliminar el error aquí es

casi imposible. En la práctica, a esta altura de nuestro conocimiento, el chequeo constante acerca de errores desde el ordenador-terapeuta es una tarea minuciosa y constante. Esta tarea es imprescindible ya que los errores iniciales corren, en caso contrario, peligro de multiplicarse hasta llevarnos a comportamientos erráticos o a que el sistema corra riesgo de entrar en estampida.

Ciertos puntos del cuidado de la situación inicial están contenidos en ciertos resguardos que deben mantener los terapeutas. Pensemos en el rastreo atento de la construcción de los "Libretos" entre terapeuta y familia que hacen C. Ravazzola y G. Mazieres (1986)*. O en la atención de C. Whitaker por la así llamada "batalla por la estructura" en el comienzo de un proceso terapéutico. O en el prolijo registro acerca de "quién está más motivado al cambio" en Weakland o Watzlawick.

¿COMO EXPLICAMOS LA APARICION DE UN FENOMENO DE CAMBIO?

Si deseamos anticipar la aparición de una línea posible de cambio hacia nuevas clases de conductas, debemos tener más claro cómo describimos un fenómeno de cambio. Nosotros construimos explicaciones del tipo de "condición suficiente para. . ." la aparición de un suceso (von Wright,

1979). Es decir, que encontramos hasta aquí dos pasos: describir, explicar.

Con esto quiero decir que no estamos hablando de la ya ganada batalla por reconocer la causalidad circular además de la causalidad lineal. Ni tampoco estamos hablando de causa (Russell, B., 1912). Estamos hablando de sucesos que son condición de. . . otros. Más aún, de sucesos que pueden ser condición suficiente para la facilitación de la aparición de otros. Dice von Wright que si abro la ventana y entra una brisa en la habitación, no podemos decir que el viento entra porque abrí la ventana, como si esto fuera la causa directa. No. Pero sí, que el abrir la ventana facilita que entre el viento que circula afuera.

Un buen ejemplo de esta afirmación lo constituye la aparición y evolución de ciertas enfermedades. Debemos diferenciar allí condición necesaria además de condición suficiente, como por ejemplo la predisposición orgánica de hipersensibilización inmunológica que facilita la aparición de asma, en un miembro de una familia con las características de interacción familiar que lo favorecen.

Sí podemos usar un pensamiento del tipo de: "es posible que tal intervención terapéutica en esta familia sea condición para permitir el surgimiento de lo nuevo, en tal posible dirección". La dirección del cambio no se debe al azar, sino a la intervención del terapeuta.

Sería también el caso de la investigación con la aplicación de la prescripción secreta a los padres en familias con un hijo esquizofrénico que utilizan Mara Selvini Palazzoli y colaboradores (1987). Los terapeutas esperan que tal aplicación de lugar a una mayor autonomía entre los miembros de la familia. Esta es una clara

* Es interesante que Ravazzola y Mazieres tratan de anticipar —para sí mismos— el libretto que se hace la familia de ellos, es decir, qué expectativa se ha formado la familia de lo que ellos harán, dirán, etc. Y tratan de no quedar apresados en un pattern repetitivo. Y así poder conservar el proceso como tal. Insisto, como proceso que está más libre para el cambio.

direccionalidad del cambio.

J. Haley ya hace años, trabajaba con la idea de que el cambio debe producirse por etapas. El describió los sucesivos pasos a lograr en un proceso terapéutico para "mover" a un sistema hacia su mejoría. "Es improbable, si no imposible, que un sistema pueda pasar de 'anormal' a 'normal' en un paso". Y explicó en qué consistía cada uno de dichos pasos (1976). Se observa nuevamente el ejercicio anticipatorio que realiza el terapeuta con respecto a la línea de cambio.

Steve de Shazer escribió mucho más recientemente: "La intervención simplemente necesita encajar dentro del pattern del paciente (tal como es graficado en un mapa por el terapeuta), de tal forma que el mapa señala el camino de salida de la oscilación" (1985).

EL TIEMPO Y LA ANTICIPACION

El tema del Tiempo en los procesos terapéuticos es de extraordinario interés y abarca una complejidad que supera los límites de este artículo. Sin embargo, quisiera tocar algunos aspectos.

Tiempo en intervenciones

Una herramienta terapéutica que ha probado ser eficaz dentro de la terapia sistémica es la redefinición.

Miremos este instrumento desde la lente de la anticipación. Al redefinir, lo que suele suceder en un vínculo terapéutico es que la redefinición resultante actúa como un mensaje en metanivel. Así, aún cuando el terapeuta lo haga desde una posición *one down*, el mensaje está orientado hacia

una posición meta, que transita "por arriba" de aquella conducta a la que se refiere la redefinición. Se re-significan y esto favorece el cambio.

La redefinición tiene una cierta perduración temporal para las personas, lo cual facilita además que las conductas que dependen de ella —en el sentido de nivel lógico abarcativo— queden reforzadas en lo novedoso.

Otra herramienta eficaz de la terapia sistémica puede ser una tarea como intervención. En una tarea directa para ser realizada por los miembros de una pareja fuera de la sesión, dicha tarea es planificada en el *tiempo* por los terapeutas y, obviamente, en una cierta *dirección*.

Por ejemplo, en una pareja donde se busca invertir una regla para lograr que el hombre satisfaga a la mujer. El cumple la actividad conjuntamente planeada de comprarle algo de comer a ella. Sólo que le compra salado y a ella le gusta lo dulce. La terapeuta aumenta la presión en lo acordado anteriormente con ambos, sugiriéndole con humor "va más por el lado de lo dulce". El cumple la tarea a partir de lo cual se redefine entre ellos que él sí satisface.

La anticipación de los terapeutas fue que él sí la complacería. Debería además observar las reacciones de ella "como información" (objetivo indirecto de los terapeutas: lograr que ella también se ablandara y aceptara el cambio). A su vez, ella comentaba que muchas veces sentía ganas de comer algo en especial (fideos, milanesas, etc.), y sin embargo, nunca satisfacía su deseo. Se le indicó entonces que cada vez que sintiera deseos de comer algo en particular, fuera a la cocina, dispusiera los elementos, prendiera el fuego y luego interrumpiera, dejara de cocinar y guardara todo nuevamente. Lo que se buscaba

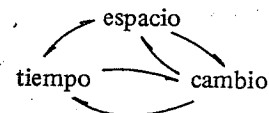
aquí era aumentar su deseo en la cercana realización de dicho deseo e interrumpirlo, para ver si lográbamos, manejando el freno nosotros, que ella —paradójicamente— reaccionase y lograra "comer lo que quería". Nótese en este ejemplo la importancia del factor tiempo en las tareas.

TIEMPO Y EJERCICIO PREDICTIVO

Obviamente al anticipar, anticipamos fenómenos en un tiempo prospectivo inmediato o mediato. El terapeuta debe saber manejarse con el tiempo, dimensión vasta, amplia y factible de ser desplegada en lo concreto. Por ejemplo, en lecturas de feedback mediato o de feedback inmediato. Pero anticipar evoluciones virtuales posibles implica para el terapeuta disponer de tiempo para hacerlo. Más o menos tiempo, según los terapeutas y el conjunto terapeuta-familia que se constituya.

Aquí se complejiza aún más la situación porque como bien señalaba H. Maturana (Rosario, 1983), mientras el terapeuta se toma tiempo para describirse, explicarse la situación de la familia, elabora la estrategia de intervención y vuelve a la familia, ésta tal vez ya cambió en algo.

La frecuencia conveniente para mantener las sesiones es otro factor confluyente a la evolución y evaluación del proceso de cambio. Al hablar de frecuencia obviamente hablamos de tiempo. Podría graficarse:



La alta o baja frecuencia de sesiones que establece un terapeuta está muchas

veces en relación directa con la evaluación que realiza de cómo y cuándo se irán produciendo cambios en el sistema: ¿Por qué tres veces por semana? ¿Por qué una vez por mes?

En la anticipación de las líneas posibles de cambio se piensa o evalúa acerca del movimiento del sistema en una o varias áreas. Haremos una breve y parcial puntualización de algunos de esos objetivos a predecir.

Tomaré sólo dos grandes situaciones:

1. Anticipación básicamente mantenida dentro del equipo terapéutico.
2. Anticipación explícita a la familia.

1. ANTICIPACION BASICAMENTE MANTENIDA DENTRO DEL EQUIPO TERAPEUTICO

A. Anticipación de líneas posibles del cambio

- a) Anticipación de líneas posibles del cambio hacia una mejoría. Sirve como organizador del campo durante el proceso terapéutico.
- b) Anticipación de líneas posibles de empeoramiento.
- c) Anticipación de un fracaso posible.*
- d) Anticipación de efectos o meta-efectos negativos de alguna intervención específica.
- e) Anticipación de efectos o meta-efectos negativos del modelo de intervención que se usó.

Consideremos brevemente este último

* Tema trabajado en: "Entre la Omnipotencia y el Fracaso en Terapia Familiar Sistémica", de Cristina Ravazzola y Estrella Joselevich.

aspecto: el proceso terapéutico y los modelos que transmite. Y especialmente en la anticipación y el metamensaje, en los efectos "secundarios" de los procesos terapéuticos.

e) Anticipación de efectos o meta-efectos negativos del modelo de intervención.

El proceso terapéutico en sí mismo contiene muchos mensajes y es a su vez un metamensaje. Dicho de otra forma, trabaja a dos niveles diferentes, uno es el de los mensajes que llegan a los pacientes —no importa aquí que sean directos o paradojales— y otro es el nivel de los mensajes que llegan como metamodelo.

Por ejemplo, ¿qué pasa como metanivel con el interrogatorio circular, donde el terapeuta pregunta sistemáticamente a una persona qué cree o piensa u observa de lo que sucede entre otros dos o más? ¿Y mientras los demás escuchan, miran sin poder responder (por las instrucciones del terapeuta)? ¿Qué implica movilizar interrelaciones en la familia? ¿Qué les queda a ellos de eso como modelo de intercomunicación familiar? O tal vez, si se practica muy brevemente, ¿queda como algo acotado a una situación extra-ordinaria, como es una sesión, y no incorporada como un modelo activo en la vida? Para nosotros, esta pregunta no tiene aún una respuesta suficiente. No olvidemos que Buenos Aires tiene una subcultura en la cual el exceso de "psicologización" y de deformaciones a partir de confusión sesión-vida es habitual.

Creo que debemos hacer prevención de salud mental y en ese sentido nada cambiaría si la moda dictase ahora que los miembros de la familia se hablasen con connotaciones positivas, se diesen tareas de intención paradójica o se autointerroga-

ran circularmente. Sería un espectáculo dantesco. Sin embargo, es común toparse en ciertos grupos sociales con un discurso saturado de interpretaciones burdas y descontextualizadas y, por eso mismo, altamente peligrosas.

Confundir terapia y vida es un tema serio. Por suerte, todavía la vida pasa por la vida y no por la terapia. La vida es inmensamente más rica que cualquier terapia. Invadir las relaciones entre las personas mediante el uso del código del accionar sistémico en terapia constituye un peligro y una deformación potenciales. Nuestro temor es la contaminación.

Sintéticamente, estoy hablando de anticipar qué "residuos" puede dejar o provocar un proceso terapéutico.

Hace muchos años, y dentro de otro marco referencial, A. Freud alertaba ya, dentro del psicoanálisis, acerca de los peligros del exceso y la inadecuada verbalización en el análisis de niños. Hoy, nos debemos preguntar qué aprende y aprende a aprender la gente con nosotros, y qué efectos puede ello producir.

No debemos ignorar que manejamos instrumentos potencialmente tan ricos como poderosos, que si no son bien usados, pueden volverse iatrogénicos y peligrosos.

2. ANTICIPACION EXPLICITA A LA FAMILIA

Anticipación explícita a la familia:

anticipación	[	de repetición de cambio de los riesgos del cambio
prescripción		
predicción		
contenido		

Anticipación y unidad de trabajo

Anticipación realizada a partir de unidades de trabajo diferentes:

- Sistema familiar completo (nuclear) presente.
- Algunos miembros presentes, para que estos a su vez pongan en marcha conductas diferentes con miembros ausentes en la sesión.

b) El campo potencial de trabajo es aquí más complejo. Un caso típico son las entrevistas con padres para la reestructuración de ciertos vínculos con los hijos y alivio de ciertos problemas que estos presentan. Ofrecer la riquísima y cuidada posibilidad de ayudar a que los padres potencien su función. Durante años de trabajar con familias con niños he observado que brinda mucho espacio de maniobra cómoda con los padres sin que estos queden expuestos a situaciones de impotencia o fracaso con los niños durante la sesión. Da posibilidad de trabajar sus altibajos como padres más confortablemente y asimismo fortalecerse. Las dificultades y limitaciones de este trabajo son también significativas. No nos explayaremos ya que esto fue muy bien trabajado antes por otros terapeutas. Sólo queremos mostrarlo desde el ejercicio anticipatorio que aquí se complejiza.

Anticipación, familias de alto riesgo y contexto complejo

En el caso de una familia proveniente de una ciudad del interior que no cuenta con terapeutas sistémicos, y dado que se trataba de una situación de alto riesgo con

varios tratamientos previos, se arma un entramado de atención. Consiste en una sesión mensual prolongada, que se entrecruza con dos llamadas telefónicas —a tres teléfonos simultáneos de los pacientes al terapeuta. Esta trabaja con un terapeuta "puente" de la ciudad adonde viven los pacientes, que está completando su formación y que atiende a la familia semanalmente en la ciudad. Dicho terapeuta mantiene un intercambio telefónico semanal con el terapeuta a cargo de toda la red de asistencia. Recibe además al cassette grabado de la sesión mensual. Oportunamente el terapeuta viaja a la ciudad y da allí una sesión a la familia junto con el terapeuta puente. Esta compleja y útil red terapéutica funcionó adecuadamente. Es cierto que, en nuestra experiencia, esto supone un intenso stress para el terapeuta a cargo en el tolerar la ambigüedad y sorpresa de este tipo de asistencia que, sin embargo, resulta factible en muchos casos. Exige armar un grillado de variables en juego muy delicado, un ejercicio anticipatorio cuidadoso de "estampidas" posibles del sistema y/o de filtraciones hacia un fracaso terapéutico. Por supuesto, requiere teléfonos que funcionen!

Obviamente, al decir de Reichenbach, estamos haciendo una apuesta y, agregoyo, corremos un importante riesgo. En esta difícil tarea de la psicoterapia nos hace falta bastante humor y capacidad de juego. Juego "para jugar" con diferentes alternativas, juego para movernos con más libertad interna (Bally).

Así, el proceso terapéutico pasa a ser un difícil y sutil juego, a nuestro juicio, de responsabilidad, no de azar.

Armamos una grilla donde entran las variables pertinentes del conjunto terapeuta-familia.

Una grilla donde entran nuestras intervenciones.

Una grilla donde entran todas nuestras preguntas acerca de la posible evolución del sistema.

Desde otros ángulos describimos,
explicamos,
anticipamos.

CONVERSANDO

Hace poco tuve el privilegio de conversar con H. von Foerster, quien me pareció un hombre de sabiduría. Hablamos acerca de este tema, de lo factible y lo no factible de la anticipación; de hacia dónde y de qué manera se reestructuran o cambian-mutan los sistemas vivientes.

Von Foerster opinaba que considerando que el hombre es básicamente una máquina no trivial, es imposible anticipar sus comportamientos o respuestas. Y recalca-ba cuán hermoso es lo espontáneo. Acoté entonces que cuando en la clínica vemos a una familia o persona que consulta por alguna disfunción, esa "máquina" se ha trivializado en alguna medida. Cuánto mayor es la disfunción, mayor la trivializa-ción. Que por otra parte, en el intercam-bio que se da en la clínica, el conjunto terapeuta-familia también —en una medi-da muy acotada— se transforma en una máquina trivializada.

Insistió en lo hermoso de lo que surge novedoso, insospechado. Respondí que precisamente por eso, con la aparición de lo improbable se torna así más hermoso y nos permite acceder al terreno del descu-brimiento.

La discusión floreció hasta que final-mente von Foerster comparó los ejerci-cios anticipatorios con las manzanas que

Schiller utilizaba para escribir.

Cuando asombrada pregunté cómo era eso de las manzanas para escribir, explicó que Schiller no podía escribir sin un par de kilos de manzanas muy maduras en el cajón entreabierto de un mueble. El per-fume que emanaba le facilitaba la crea-ción. Y que así yo utilizo el ejercicio de predicción para favorecer el clima de cam-bio con el paciente.

A diferencia del perfume de manzanas en un cajón semicerrado del escritorio, que se percibe, casi de adivina, yo intento abrir y explícitamente desglosar ese per-fume. Algo así como ser catador de fra-gancias y emanaciones.

Me complace sentir esta actividad co-mo la percepción de un suave ronroneo de fondo, más allá de las emanaciones. Y más aún, como una clara mirada anticipa-toria que implica una actitud explícita, responsable y activa del terapeuta en la toma de decisiones cuando trabaja. En lo que no pudimos o no supimos anticipar, aparecerá la "magia de lo desconocido". Asombro.

RESUMEN

El tema del cambio en un proceso terapéu-tico es obviamente fundamental. Este ar-tículo trata acerca de la posibilidad de predicción de la dirección general del cambio en/del sistema terapéutico.

Como psicólogos clínicos pensar que la orientación de la reestructuración del sis-tema durante un proceso terapéutico se dé "al azar" —como algunos científicos afirman— nos produce escalofríos éticos y ataques de responsabilidad profesional.

Decidimos tomarnos una avioneta y viajar por otros campos, como por ejem-

plo el del diseño de escenarios alternati-vos realizado por los asesores en planifica-ción empresarial, o el de la anticipación en situaciones de "alta turbulencia" en ma-croeconomía, o el de la reestructuración de los sistemas vivientes vista por biólogos. Nos encontramos con aspectos de la me-todología de la ciencia y de la lógica. Con algunas herramientas prestadas, aterrizamos nuevamente en el ejercicio predicti-vo en psicoterapia, tendiendo a construir hacia la Teoría de la Clínica.

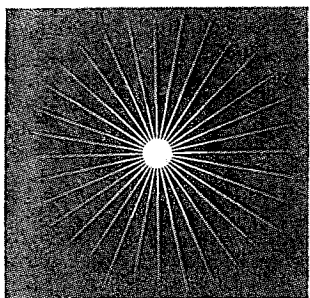
En psicoterapia, no es interesante lo que conocemos, sino lo que hacemos jun-to con la gente en relación con lo que me es posible, nos es posible, y ellos pueden, hacer.*

* Tomado de: "En física no es interesante lo que conozco, sino lo que hago en relación con lo que me es posible conocer". G. Ludwig, fí-sico.

BIBLIOGRAFIA

- BALINT, M., ORNSTEIN, P., BALINT, E.: *Focal Psychotherapy*, Tavistock Publications, London, 1972.
- BALLY, G.: *El juego como expresión de Liber-tad*, Fondo de Cultura Económica, Méxi-co.
- BATESON, G.: *Pasos hacia una ecología de la mente*, Ed. Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1976.
- *Espíritu y naturaleza*, Ed. Amorrortu, Bue-nos Aires, 1983.
- PRONOWSKI, J.: *The Aspect of Man*, B. Broad-casting Corp., Londres, 1973.
- CAPRA, F.: *The Tao of Physics*, Bantam Books, New York, 1975.
- DE SHAZER, S.: *Keys to Solution in Brief The-rapy*, W.W. Norton, New York, 1985.
- EINSTEIN, A.: *Cómo veo al mundo*, Ed. Siglo Veinte, Buenos Aires, 1980.
- ELKAIM, M.: "From General Laws to Singula-

- rities, en *Family Process*, Vol. 24, Nº 2, Nueva York, 1985.
- FIORINI, H.: *Teoría y técnica de psicoterapias*, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1973.
- HALEY, J.: *Problem Solving Therapy*, Josey-Bass publ., San Francisco, 1976.
- HIRSCH, H., JOSELEVICH, E.: "El uso de predicciones en terapia familiar" en *Estra-tegias psicoterapéuticas institucionales*, Na-dir Editores, Buenos Aires, 1987, pp. 83-95.
- JOSELEVICH, E., RAVAZZOLA, C.: "Entre la omnipotencia y el fracaso en terapia fami-liar sistémica" en *Sistemas Familiares*, Año 1, Nº 2, Buenos Aires, 1985, pp. 18-27.
- HOFFMAN, L.: *Foundation of Family Thera-py*, Basic Books, Inc., New York, 1981.
- LANDSBERG, P., LUDWIG, G., THOM, R., SCHATZMAN, E., MARGALEF, R., PRI-GOGINE, I.: *Proceso al Azar*, Tusquets Editores, Barcelona, 1986.
- MATURANA, H.: *Comunicación personal*, Ro-sario, 1983.
- MAZIERES, G., RAVAZZOLA, C.: "Una me-táfora de la relación terapeuta-familia: Co-autores de nuevos libretos" en *Siste-mas Familiares*, Año 2, Nº 3, 1986.
- MORIN, E.: *La Methode: La Nature de la Na-ture*, Ed. Du Seuil, Paris, 1977.
- REICHENBACH, citado en VARSAVSKY, O.: *Obras escogidas*.
- RUSSELL, B.: *On the Notion of Causa*, 1912, citado en VARSAVSKY, O.: *Obras esco-gidas*.
- SALOMON, M.: *El futuro de la Vida*, Ed. Pla-neta, Barcelona, 1982.
- SELVINI PALAZZOLI, M.: "Hacia un modelo general de los juegos psicóticos en la fami-lia" en *Sistemas Familiares*, Año 3, Nº 2, 1987, pp. 29-43.
- SHELDRAKE, R.: *A New Science of Life*, J.P. Tarcher, Inc., Los Angeles, 1981.
- SCHUSTER, F.: *Explicación y Predicción*, Clac-so, Biblioteca de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1982.
- VARSAVSKY, O.: *Obras escogidas*, Ed. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1982.
- VON FOERSTER, H.: *Comunicación personal*, Buenos Aires, 1987.
- VON WRIGHT, G.: *Explicación y comprensión*, Alianza Editorial, Madrid, 1979.
- WATZLAWICK, P., WEAKLAND, J., FISH, R.: *Change*, Ed. Norton and Co. Inc., New York, 1974.
- WEEKS, G.: *Paradogical Psychotherapy*, Bru-nner and Mazel, New York, 1982.



ISIS
INSTITUTO SISTEMICO

ASISTENCIA
INVESTIGACION
DOCENCIA

Directora:
M. ESTHER PANIZO
Director asociado:
ENRIQUE ESCOT

ENTRENAMIENTO EN TERAPIAS SISTEMICAS

- CURSOS ANUALES: 1er., 2do. y 3er. Nivel
- TALLERES Y SEMINARIOS:
 - Genograma del Terapeuta.
 - Reencuadre: Teoría y Técnica
 - Utilización de la Teoría de Bateson en la Clínica
- MODULOS:
 - Introducción a la Teoría de I. Prigogine

CORDOBA 2773 1º "D" CAP. FED. TE.: 961-3290

PRIMERA ESCUELA ARGENTINA DE PSICOLOGIA INTEGRACIONAL ESCUELA DE TERAPIA FAMILIAR INTEGRACIONAL

Fundada y dirigida por el Dr. MARCOS BERNSTEIN

SEMINARIOS 1988
"TECNICAS INTEGRADAS EN
TERAPIA FAMILIAR"
A cargo del Dr. Marcos Bernstein
SABADOS: 6 de Agosto, 10 de
Setiembre y 22 de Octubre
Proyección de videos de terapias
familiares realizadas en las asesorías
para la Organización Mundial de la
Salud

CURSOS
TERAPIA FAMILIAR
INTEGRACIONAL
Miércoles de 14 a 15:30 hs.
TERAPIA DE PAREJA
Viernes de 16 a 17:30 hs.
FAMILIA Y DROGADICCION
Jueves de 10 a 11:30 hs.
Duración:
Agosto/Noviembre

NOVIEMBRE: Abierta la Inscripción Cursos 1989
SE ENTREGA CERTIFICADOS DE ASISTENCIA

SECRETARIA E INFORMES: SEDE DE LA ESCUELA
PARAGUAY 1840 2º "A" - CAP. FED. - TE.: 802-5210/803-8719/804-0315
o en LIBRERIA PAIDOS: Las Heras 2741, Loc. 31

terapia familiar

rivista interdisciplinare di ricerca ed intervento relazionale

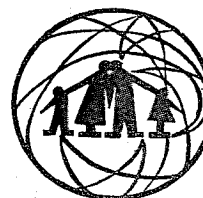
The Journal is published quarterly
(March, July, November) by the Rome
Family Therapy Institute.

Editor in Chief: M. Andolfi

Editorial board: P. Menghi, A. Nicolò, C.
Saccu

Its aim is to promote research and present
studies in the following areas:

- ☐ Theory and practice of family therapy
- ☐ Training in family and marriage therapy
- ☐ The individual, the family, social systems
and their correlates (schools, neighbor-
hoods, social and health services, etc.)
from a systems point of view.



The journal is published in conjunction with:
*Family Process, Journal of Marital and Fa-
mily Therapy, The American Journal of Fa-
mily Therapy.*

The journal, established in 1977, has been
the only Italian publication in the field of fa-
mily psychotherapy. It has always been ac-
tive in the cultural and scientific debate in
this field both in Europe and in America.

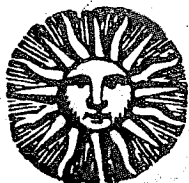
It includes contributions by:

H. Aponte, L. Boscolo, D. Bloch, I. Boszor-
menyi-Nagy, M. Bowen, P. Caillé, G. Cec-
chin, M. Elkaim, J. Framo, J. Haley, K. La
Perrière, S. Minuchin, P. Papp, G. Prata, M.
Selvini Palazzoli, H. Stierlin, C. Sluzki, P.
Watzlawick, C. Whitaker, I. Zwerling.

One year subscription

Europe: u.s. \$ 25
Extra-European countries: u.s. \$ 30

Checks payable to:
I.T.F., s.r.l. - Via Reno, 30 - 00198 Roma



PRACTICUM IN FAMILY THERAPY

With
Maurizio Andolfi

SPRING IN ROME

1988

JUNE 7 - 23

Intensive three-week training program for foreign therapists will be offered for the 8th consecutive year by Maurizio Andolfi, Scientific Director of the Rome Family Therapy Institute and President of the Italian Society for Family Therapy. Maurizio Andolfi will personally conduct the entire Practicum for four days a week. The official language is English (translations will be provided when necessary).

The participants in the courses of past years came from Argentina, Austria, Australia, Brazil, Canada, Chile, Czechoslovakia, Ecuador, Finland, France, Holland, Israel, Japan, Mexico, Norway, Portugal, Spain, Switzerland, South Africa, United States.

The foreign setting, the many countries represented and the variety of cultures, languages and personalities facilitate the utilization of the group potential, deepen a systemic understanding of familial and institutional problems and increase the capacity of using oneself as the major tool in therapy.

Purpose:

to introduce foreign therapists to the model of therapy, supervision and training elaborated in the course of these years by Maurizio Andolfi at the Rome Family Therapy Institute.

Activities:

clinical presentations by each participant, activation of the group through creative exercises, roleplaying and simulations of family therapy. Observation of live family therapies and consultations led by Andolfi.

observation of the supervisory process through live supervision sessions with the advanced students and teachers of the Institute. Discussion on videotapes of family sessions as well as on theoretical issues. Creative and provocative work on professional handicaps.

Eligibility:

a minimum of five years experience in family therapy and clinical practice in the field. Preference will be given to teachers of family therapy.

Fee:

\$ 1500. A non refundable deposit of \$ 200 will be required upon acceptance. The remaining fee \$ 1300 is payable at the beginning of the program.

Application:

send application form with your Curriculum Vitae, a letter of reference and a photo to: Maurizio Andolfi, Via Capodistria 15, Roma. The deadline for application is April 1, 1988. You will be notified of your acceptance within three weeks from the receipt of your application. Priority on the basis of the date of application and professional experience.

Suggested readings:

M. Andolfi, *Family Therapy—An interactional Approach*, Plenum Press, 1979.

M. Andolfi, I. Zwerling (Eds), *Dimensions of family Therapy*, Guilford Press, 1980.

M. Andolfi, C. Angelo, P. Menghi, A.M. Nicolò—Corigliano, *Behind the Family Mask - Therapeutic Change in Rigid Family Systems*, Brunner/Mazel 1983.

Terapia Familiare, Italian Journal of Family Therapy, 1977 - 1987.

Tel. Business

Tel. Home

Degree (s)

Current Position

Date

Signature

I would like to attend:

Practicum, Spring 1988

Practicum, Spring 1989

Revista de libros

Presentamos a los lectores una selección de artículos clínicos correspondientes a los años 1985, 1986 y 1987, publicados en las revistas *Terapia Familiar*, *Sistemas Familiares*, *Terapia Familiare*, *Thérapie Familiale* y *Family Process*.

Estos artículos han sido clasificados por área problemática (anorexia, casos graves, etc.), del ciclo vital (adolescencia, pareja), y técnicas.

Dada la extensión de la selección, algunos artículos han sido comentados y otros no.

ADOLESCENCIA

FRANK, JAN: "Thérapie de L'impossible dans les limites du possible", *Thérapie Familiale*, 1986, Vol. VII, No 1, pág. 61-72.

GUTSTEIN, STEVEN: "Family reconciliation as a Response to Adolescent Crises", *Family Process*, Vol. 26, No 4, 1987, pág. 475-491.

QUIRUR, W., WERFIELD, N., PROTINSKY, H.: "Rites of passage in families with Adolescents", *Family Process*, Vol. 24, No 1, 1985, pág. 101-111.

Tres ejemplos clínicos ilustran la propuesta de los autores sobre los ritos de pasaje y la utilización de prescripciones que

incluyan ritos familiares como medio para producir cambios en la estructura e interacción familiar.

PAREJA

ELKAIM, MONY: "Abordaje sistémico en terapia de pareja", *Sistemas Familiares*, Año 3, No 3, ASIBA, Bs. As., pág. 17-24.

El autor presenta a través de dos ejemplos clínicos, un modelo de trabajo "basado en el doble vínculo recíproco", en el que se destacan: 1) intersección de los mapas de los miembros del sistema, 2) modos de intervención.

FAMILIAS CON NIÑOS

BRIDGMAN, F.: "Le placement familial, système à double parantéité", *Thérapie Familiale*, Vol. VIII, 1987, No 3, pág. 301-313.

FUCKS SCHACHTER, FRANCES: "Sibling Deidentification in the Clinic: Devil vs. Angel", *Family Process*, Vol. 24, No 3, 1985, pág. 415-427.

PITHMAN, FRANK III: "Children of the rich", *Family Process*, Vol. 24, No 4, 1985, pág. 461-462.

WHITE, MICHAEL: "Negative explanation Restraint and Double description: A template for Family Therapy", *Family Process*, Vol. 25, No 2, 1986, pág. 169-184.

Los conceptos de Bateson que dan nombre a este trabajo son analizados y utilizados para construir un mapa que sirva a familia y terapeuta para encontrar

Request for application

Please fill out the form below and send it to:

Maurizio Andolfi
Via Capodistria, 15
00198 Rome - Italy
Phone (06) 863386

Name

Address

City

State

Zip

nuevas soluciones. Muestra también cómo utilizarlo en el tratamiento contextual de los temores infantiles y conductas obsesivo-compulsivas.

ALCOHOLISMO

ROITBLATT S., ARTURO: "La terapia familiar: una aproximación distinta al alcoholismo", *Terapia Familiar*, No 13/14 Buenos Aires, 1985, pág. 163-174.

Luego de una revisión del concepto de alcoholismo, se plantea el de "sistema familiar alcohólico"; analizando el ciclo de la enfermedad y las fases del tratamiento.

ANOREXIA

RAUSCH HERSCOVICI, CECILE: "Anorexia nerviosa: un abordaje integral", *Sistemas Familiares*, Año 3, No 1, ASI-BA, Bs. As., 1987, pág. 35-42.

Luego de describir el cuadro de anorexia nerviosa, sus factores predisponentes, precipitantes y de mantenimiento, la autora muestra el estudio de 25 casos y delinea una línea de tratamiento integral que considera ha sido efectiva.

CASOS GRAVES

BEREZOVSKY, I. y otros: "Juegos saba-tinos", *Sistemas Familiares*, Año 3, No 1, ASI-BA, Bs. As., 1987, pág. 21-27.

En este trabajo, un grupo de terapeutas del CPTB, analiza a través de la metáfora del juego entre dos equipos, las movidas de la familia y las del terapeuta no sólo a fin de prevalecer sino, desde el tera-

peuta, para conseguir los cambios necesarios para la solución de un problema; y lo hacen con ejemplos clínicos de las llamadas "jugadas típicas".

DE BERNART, R.: "Famiglia ed individuo nella psicoterapia delle psicosi", *Terapia Familiare*, No 19, 1985, pág. 31-36.

De Bernart propone una aproximación individual con sentido relacional considerando la familia un sistema osmótico que puede ser analizado en sus relaciones con el mundo externo (sentimientos, emociones, expectativas). El terapeuta se inserta como coartífice de los cambios necesarios para la evolución de la familia.

MAISONDIEU, J.: "Approche familiale de la démence des démences précoces aux démences tardives", *Thérapie Familiale*, 1985, Vol. VI, No 3, pág. 287-294.

PERROTTA, PETER: "Leaving Home: Later stages of treatment", *Family Process*, Vol. 25, No 3, 1986, pág. 461-474.

A partir del modelo de trabajo planteado por Haley como "Leaving Home", el autor examina usando ejemplos clínicos algunas dificultades que aparecen hacia el final del tratamiento, y propone estrategias directas e indirectas para superarlas. Entre las más comunes señala: 1) pérdida de foco e intensidad, 2) dificultad para trabajar los padres en forma cooperativa, y seguir con lo planteado hasta sus últimas consecuencias.

PRATA, GIULIANA: "Trois séances pour déjoner un jeu psychotisant", *Thérapie Familiale*, 1985, Vol. VI, No 3, pág. 305-324.

SCHEINBERG, MARCIA: "The debate: A Strategic Technique", *Family Process*, Vol. 24, No 2, 1985, pág. 259-271.

Este trabajo plantea la importancia de la discusión entre el equipo terapéutico y su utilización como medio para neutralizar a la familia, y promover el cambio: la familia es ubicada en una posición meta desde la que observar la lucha entre los terapeutas para resolver el problema de la familia, el que es "re-presentado" como un problema entre los terapeutas, adquieren así una nueva visión y la posibilidad de otras soluciones a su propio problema.

SELVINI PALAZZOLI, MARA: "Hacia un modelo general de los juegos psicóticos en la familia", *Sistemas Familiares*, Año 3, No 2, ASI-BA, Bs. As., 1987, pág. 71-80.

En este trabajo Selvini P. presenta un modelo de las relaciones familiares y la secuencia de su formación, desarrollo y mantenimiento de las mismas (6 estadios), en familias con miembros diagnosticados psicóticos, junto a los juegos psicóticos de la familia aparece el desarrollo y uso por parte del terapeuta de la "prescripción invariable", táctica considerada clave en el tratamiento de estas familias.

STIERLIN, HELM and others: "Features of Families with Major Affective Disorders", *Family Process*, Vol. 25, No 3, 1986, pág. 325-336.

En este trabajo se muestran las características de un grupo numeroso de familias (22) con un miembro joven diagnosticado como maniaco depresivo: a) familias extremadamente rígidas, b) muy ligadas, c) con una complementariedad parental restrictiva, d) delegación recíproca, e) cons-

trucciones cognitivas compartidas. Estas familias muestran similitudes y diferencias al ser comparadas con familias con miembros esquizofrénicos y/o desórdenes psicosomáticos.

TODD THOMAS, C.: "Prescripciones paradójicas", *Sistemas Familiares*, Año 2, No 2, ASI-BA, Bs. As., 1986, pág. 53-67.

El artículo plantea la utilidad de intervenciones paradójicas en la sesión y la prescripción paradójica intersesión en familias resistentes, a la vez que muestra la eficacia de la acción terapéutica de su "equipo".

WEITZMAN, JACK: "Angaging the severely Dysfunctional Family in Treatment: Basic considerations", *Family Process*, Vol. 24, No 4, 1985, pág. 473-485.

DISCAPACIDAD

BEAVERS, JEANETTE and others: "Coping in Families with a retarded Child", *Family Process*, Vol. 25, No 3, 1986, pág. 365-378.

Este estudio de familias con un hijo retardado está centrado en el método de observación y en los aspectos sistémicos del funcionamiento familiar.

El grado en que la familia está organizada alrededor del hijo discapacitado es una medida de la adaptación familiar: cuánto más se conocen, y responde a las necesidades de los diferentes miembros —el discapacitado y los otros— más capacitada y más efectiva es la familia. Otro aspecto importante es que estas familias se centran más en pequeños logros y en el presente.

POLLNER, M., MC DONALD-WIKLER, L.: "The social construction of unreality: A case Study of a Family Attribution of Competence to a Severely Retarded Child", *Family Process*, Vol. 24 No 2, 1985, pág. 241-254.

Los autores examinan la "construcción de la realidad" hecha por una familia en relación con un miembro joven severamente retardado. Comparan las interacciones en esta familia con la que se da entre adultos y niños en estadio no-verbal y enfatizan las implicancias de esta "folie à famille".

SACRE, M.: "Le jeu des images dans un système familial avec un enfant hand-dicapé", *Thérapie Familiale*, 1987, Vol. VIII, No 2, pág. 185-196.

DIVORCIO

En la revista *Terapia Familiar* No 15, Buenos Aires, 1986, aparece una detallada bibliografía sobre el tema.

DROGADICCION

En una revista *Terapia Familiar* de próxima aparición, se incluirá una reseña bibliográfica sobre el tema.

PSICOSOMATICA

BURRONE, T., CAPELLUTO, DORA: "Terapia familiar y enuresis", *Sistemas Familiares*, Año 3, No 3, ASIBA, Bs. As., pág. 9-16.

El resultado del trabajo con 40 familias con un miembro enurético es plantea-

do abarcando "aspectos individuales", familiares y sociales que mantienen el síntoma. De ahí que el contexto terapéutico optimice la competencia de la familia para activar el crecimiento familiar y favorecer la disolución del síntoma.

DYM, BARRY: "The Cybernetics of Physical Illness", *Family Process*, Vol. 26, No 1, 1987, pág. 35-48.

HODAS GORDON, R., LICHMAN, RONALD: "Trastornos psicosomáticos en los niños: Terapia familiar estructural", *Sistemas Familiares*, Año 1, No 1, ASIBA, Bs. As., 1985, pág. 30-36.

Este artículo muestra la eficacia de las estrategias estructurales en la solución de problemas psicosomáticos en niños utilizadas en tres áreas: 1) la estructura familiar (fortaleza y disfunciones), 2) ecosistema del niño y su familia, 3) ciclo evolutivo familiar.

MASSON, O.: "Thérapie des Syndromes psychosomatiques en Pédiopsychiatrie", *Thérapie Familiale*, 1985, Vol. VI, No 3, 295-303.

WHITE, MICHAEL: "Pseudoencopresis: desde la avalancha hasta la victoria, desde el ciclo vicioso hasta el ciclo virtuoso", *Sistemas Familiares*, Año 2, No 1, ASIBA, Bs. As., 1986, pág. 55-65.

En el marco conceptual de la Segunda Cibernética, se explica el síntoma "encopresis" en un sistema familiar que promueve y mantiene una "avalancha descontrolada de sucesos". El tratamiento pretende alterar y detener una avalancha de manera que la familia triunfe sobre los síntomas.

WIRSCHING, M., STIERLIN, H.: "Psico-

somática II. Consideraciones acerca del tratamiento", *Sistemas Familiares*, Año 3, No 2, ASIBA, Bs. As., 1987, pág. 71-80.

Los autores plantean un enfoque del tratamiento de las familias con miembros psicosomáticos tanto en situaciones de crisis como crónicas enfatizando la importancia del contacto inicial, el contacto del mismo y el uso de técnicas paradójales.

TECNICAS Y ESTRATEGIAS

ANDERSEN, T.: "The Reflecting Team: Dialogue and Meta-dialogue in Clinical Work", *Family Process*, Vol. 26, No 4, 1987, pág. 415-428.

BARRELET, L., MENTHONNEX, A., ARCHINARD, M.: "Traitement de Famille et Travail Institutionnel: au-delà de la transmutation?", *Thérapie Familiale*, 1986, Vol. 7, No 4, pág. 347-361.

DE SHAZER, STEVE and others: "Brief Therapy Focused Solution Development", *Family Process*, Vol. 25, No 2, 1986, pág. 207-222.

Los autores, terapeutas del Brief Family Therapy Center, muestran su concepción y manera de hacer terapia breve: ayudar al paciente o familia a utilizar un "conocimiento" de las soluciones que ellos mismos poseen pero no saben que poseen.

Además plantean una serie de interrogantes: 1) ¿qué correspondencia hay entre la queja y la nueva conducta y marco de la misma que conduce a la solución?, 2) la distribución entre: a) queja concreta y logro concreto y b) queja vaga y logro vago ¿seguirá siendo útil?, 3) ¿qué hace

el terapeuta durante la entrevista?, 4) ¿qué construcción de la terapia breve será más útil que la que preparen?

DUNCAN STANTON, M.: "Una reseña de los abordajes comprensivo-estratégicos a la terapia familiar", *Sistemas Familiares*, Año 2, No 1, ASIBA, Bs. As., 1986, pág. 31-53.

El autor realiza una revisión de la terapia estratégica: 1) figuras prominentes, 2) historia, 3) conceptos básicos: familias sanas y disfuncionales, ciclo vital, jerarquías, tríada, determinación de objetivos, 4) aplicabilidad del tratamiento, 5) estructura del proceso terapéutico, 6) rol del terapeuta, 7) técnicas de tratamiento (paradojas, interpretación positiva). Y para ello parte de un concepto central: el terapeuta es el que inicia el tratamiento e induce a los cambios a través de "un enfoque particular para cada problema".

DUNCAN STANTON, M.: "Una reseña de los abordajes comprensivo-estratégicos a la terapia familiar", *Sistemas Familiares*, Año 2, No 2, ASIBA, Bs. As., 1986, pág. 37-52.

Este artículo es la segunda parte del reseñado antes y analiza las técnicas de tratamiento específicas desarrolladas por Erickson, Haley, MRI, Zuk, el Grupo de Milán, Andolfi, y el mismo Stanton.

DUNCAN STANTON, M.: "Una reseña de los abordajes comprensivo-estratégicos a la terapia familiar", *Sistemas Familiares*, Año 2, No 3, ASIBA, Bs. As., 1986, pág. 49-64.

A partir de una comparación con los enfoques psicodinámicos, Stanton analiza la teoría del cambio y los factores del terapeuta en el enfoque estratégico. Luego analiza algunas investigaciones sobre la

eficacia del tratamiento y la formación de terapeutas para concluir con el lugar que en este momento y en el futuro le cabe a este enfoque innovador y que cuenta con poderosas técnicas de cambio.

ELKAIM, MONY: "From General Laws to Singularities", *Family Process*, Vol. 24, Nº 2, 1985, pág. 151-164.

Basado en los trabajos de Ilia Prigogine sobre sistemas lejos del equilibrio, Mony Elkaim propone el estudio de un nivel "semiótico": el acoplamiento entre las "singularidades" de los miembros del sistema familiar y el terapeuta. A través de un caso clínico, une este nivel de singularidades con las "reglas intrínsecas" del sistema a la vez que abre nuevos cuestionamientos a partir de dichos conceptos.

GRIFFITH, JAMES: "Employing the God Family relationship in Therapy with Religions Families", *Family Process*, Vol. 25, Nº 4, 1986, pág. 609-618.

El terapeuta puede, y es conveniente que lo haga, utilizar la relación de la familia o alguno de sus miembros con Dios en intervenciones terapéuticas, es una forma de rescatar una fuerza vital que actúa en la familia. Hay cuatro ejemplos clínicos.

HABER RUSSELL: "Friends in F.T. Use of a neglected resource", *Family Process*, Vol. 26, Nº 2, 1987, pág. 269-281.

PENN, PEGGY: "Feed-forward: Future questions, Future maps", *Family Process*, Vol. 24, Nº 3, 1985, pág. 299-310.

P. Penn presenta una técnica que ubica a la familia en el futuro, y desde esta

metaperspectiva y en conjunción con connotaciones positivas, facilita el cambio y soluciones a viejos problemas. "Aprender a aprender" es la base de la misma. El ejemplo clínico es claro al respecto.

ROSENHECK, ROBERT, THOMSON, JANE: "Detoxification of Vietnam War Trauma: A combined Family Individual Approach", *Family Process*, Vol. 25, Nº 4, 1986, pág. 559-570.

SELVINI PALAZZOLI, MARA: "El problema del hermano como la persona que deriva", *Terapia Familiar*, Nº 16, Ediciones ACE, Buenos Aires, 1987, pág. 73-100.

En este artículo Selvini Palazzoli da otra vuelta de tuerca sobre el concepto de "juego familiar": lo más complejo (el presente, la persona que consulta, el pedido de ayuda), es lo que explica lo más simple (el pasado), y lo muestra en un caso clínico, poniendo el acento en las estrategias y hacer del terapeuta.

WAYNE JONES, C.: "Strategic interventions within a no-treatment frame", *Family Process*, Vol. 24, Nº 4, 1985, pág. 583-595.

OLGA B. MARTINEZ DE SARGUIZ

LIBRO

HIRSCH, H., ROSARIOS, H.: *Estrategias psicoterapéuticas institucionales: la organización del cambio*. Nadir Editores, Bs. As., 1987.

Se erige como un tríptico cuya primera parte se ocupa de la Organización de la Salud Mental, campo en el cual los autores fueron permanentes protagonistas

—basta recordar la co-dirección del Centro de Salud Mental Nº 1 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La creación del Centro Privado de Psicoterapias constituye la culminación de un proyecto de asistencia psicológica integral en el cual el binomio Hirsch-Rosarios y los profesionales que los acompañan, articulan, cotidianamente, sus ideas sobre psiquiatría comunitaria, docencia e investigación.

En la segunda parte titulada Teoría, se exponen los fundamentos del paradigma sistémico, desarrollando conceptos como la Construcción de Redefiniciones, la Motivación en psicoterapia, la Primera Entrevista como entrevista única y el Uso de Predicciones en Terapia Familiar.

El tríptico se completa con una tercera parte titulada Técnica. En ella se desmenuzan los mecanismos de la terapia sistémica revelando su rigurosidad y su compleja y pragmática sencillez.

En este capítulo se incluyen: una irónica y útil descripción del método más seguro para fracasar en Terapia Breve, y una guía para la elección de modelos terapéuticos. La utilización de técnicas teatra-

les para mejorar la "interpretación" de estos "libretos" terapéuticos cierra esta tercera y última parte.

Si bien este libro es obra de Hugo Hirsch y Hugo Rosarios, se nutre y se enriquece con los invalorable aportes de Celia Elzufán, directora del Centro Privado de Terapias Breves; de Estrella Joselevich, experimentada terapeuta familiar y de un grupo de psicoterapeutas integrantes del afiatado equipo del Centro Privado de Psicoterapias.

El epílogo de la obra se encuentra una interesante síntesis de las principales ideas (y de sus aplicaciones), que constituyen el andamiaje del libro: se trata del paradigma sistémico aplicado a Salud y Enfermedad - Procesos de enfermar y de curar, sistemas asistenciales, integración de las teorías y técnicas de las ciencias sociales y de la psicoterapia en el ámbito de la salud - Organización Asistencia y Terapia. La bibliografía que se menciona al final del epílogo nos permite conocer las fuentes en donde abrevan los autores para construir esta visión macrosistémica.

CLAUDIO DES CHAMPS

Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Carlos E. Sluzki, *Palo Alto, CA*

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, *CHRM., Rochester, N.Y.*, Edgar H. Auerswald, *Maui, Hawaii*, Michael Goldstein, *Los Angeles, Calif.*, Reuben Hill, *Minneapolis, Minn.*, Arthur G. Rosenthal, *Cambridge, Mass.*, Robert Ryder, *Storrs, CT*, Margaret T. Singer, *Berkeley, Calif.*, M. Duncan Stanton, *Philadelphia, Pa.*, Carl Whitaker, *Madison, Wis.*

FAMILY PROCESS, in continuous publication since 1962, is the definitive journal in the field of family psychotherapy. Original articles report on theory and practice of family treatment, research and training. In addition, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to reviews of books and audiovisual materials.

Among the many contributors in recent years have been *James Framo, Mara Selvini-Palazzoli, Paul Dell, Carl Whitaker, Bradford Keeney, Cloe Madanes, and M. Duncan Stanton*.

FAMILY PROCESS

149 East 78th Street
New York, N.Y. 10021

Gentlemen:

DATE _____

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS (U.S. funds drawn on a U.S. bank)

INDIVIDUAL SUBSCRIBERS
(paid by personal check)

INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

☐ \$24.00 per year United States

☐ \$35.00 U.S.

☐ \$27.00 per year Canada &
Latin America

☐ \$38.00 Canada &
Latin America

☐ \$30.00 per year All other countries

☐ \$42.00 All other countries

NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____ STATE/COUNTRY _____ ZIP _____

ALL SUBSCRIPTIONS ARE ENTERED ON A CALENDAR YEAR BASIS

Próximos números

1988

DROGADICCION

Editora invitada:

Lic. María Rosa Glasserman

VIOLENCIA EN FAMILIA

Editora invitada:

Dra. Ana Giller

1989

TERAPIAS BREVES

Editores invitados:

Lic. Hugo Hirsch

Lic. Celia Elzufán

TERAPIAS DE PAREJA

Editor invitado:

Psic. Alberto González

Los autores interesados en algunos de estos temas pueden enviar sus artículos a la Secretaría de la Revista según las "Instrucciones para los autores" que se encuentra en la página siguiente.

PARA PUBLICAR EN ESTA REVISTA
LLAMAR AL TELEFONO: 572-0322
O DIRIGIRSE A JULIAN ALVAREZ 239
CAPITAL FEDERAL.

Instrucciones para los autores

La Revista TERAPIA FAMILIAR publica dos números por año, es multidisciplinaria en el área de la familia con especial énfasis en la salud mental. Tiene como objetivo incrementar el conocimiento profesional de la problemática de la familia para mejorar la calidad de ayuda que la familia requiere.

Los trabajos son seleccionados sobre las bases de objetivos, claridad y contribución al área de la familia.

ARTICULOS

—Los originales, por triplicado, deberán ser enviados al Director de la Revista, Dr. Alfredo Canevaro, Echeverría 1945, PB, 1428 Capital Federal, República Argentina.

—La responsabilidad del contenido de los trabajos es del autor.

—No se paga honorarios por los trabajos aceptados.

—El editor se reserva el derecho de rechazar trabajos, devolverlos al autor para alguna modificación de forma o de someterlos a corrección de estilo.

—Los trabajos deben ser escritos a máquina y a doble espacio. Se debe presentar original y dos copias, también deben incluir un resumen lo más conciso posible, así como su traducción en inglés para su envío a revistas internacionales. Las tablas y gráficos que acompañen el trabajo deben ser claros a fin de permitir la máxima calidad de la reproducción fotomecánica.

—Incluir nombre completo de (los) autor (es), título profesional, dirección e institución a la que pertenece.

—Bibliografía: Las referencias bibliográficas deben ceñirse a las normas internacionales: 1) Ordenadas alfabéticamente y numeradas correlativamente según su orden de aparición. 2) Nombre completo del autor o de todos los autores, en caso de ser varios. 3) Título completo del trabajo citado. 4) Nombre abreviado de la Revista según Index Medicus (si el tema es médico). Número de Volumen o Volúmenes; referencia de primera y última página (en este orden), ciudad, editorial, año de publicación.

Ejemplos:

ASHBY, W.R. Introducción a la Cibernética (1956), Bs. Aires, Ed. Paidós, 1972.

o

RUDRAUF, J., Ensayos sobre la dialéctica de los niveles de comunicación en la intervención terapéutica, TERAPIA FAMILIAR, 1980, Vol. IV, No 7/8, págs. 87-98, Buenos Aires, Argentina.

—Los autores de los trabajos publicados recibirán un ejemplar de la Revista.

—Los artículos deberán ser inéditos en lengua española.

Ficha de suscripción

Nros. 18 y 19

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección

Código Postal Localidad

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Ediciones A.C.E., No a la Orden.

DIRECCION: C.C. Nro. 94 - Sucursal 28 - Buenos Aires - Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION Nros. 18 y 19

ARGENTINA: Solicitar precio por carta o al TE.: 572-0322

EXTERIOR: U\$S 35.--

GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS

SECRETARIA E INFORMES
DE LA REVISTA
TERAPIA FAMILIAR:
Julián Alvarez 239, Capital
C.C. 94, Suc. 28, (1428) Bs. As.,
Argentina.
TE.: 572-0322